

精神疾病中医临床治疗

黄跃东 编著

上海科学技术出版社

精神疾病中医临床治疗

黄跃东 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 常熟市第六印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8.75 字数 201 000

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 7-5323-4812-1/R·1223

定价: 14.60 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,

请向承印厂联系调换

目 录

第一章 精神疾病中医防治体系的形成和发展	1
第一节 精神疾病防治体系的初步形成	1
一、《黄帝内经》奠定了精神疾病防治的理论基础	2
二、《难经》提出以阴阳作为癫狂分类的理论根据	5
三、《伤寒杂病论》为精神医学奠定了临床治疗基础	5
第二节 精神疾病防治体系的不断发展	7
一、晋唐时期的主要成就	7
二、宋元时期的重要贡献	9
三、明清之际的重大进展	10
第三节 精神疾病防治体系的近代进展	12
一、在整理祖国精神病学典籍方面	12
二、在临床研究方面	13
三、现代科技手段和方法在临床科研中的应用	15
第二章 祖国医学有关正常精神活动的认识	16
第一节 阴阳整体说	16
第二节 心主神明论	17
第三节 脏象五志说	18
第四节 脑论	20
第五节 形神学说	21
第六节 七情学说	22
第三章 中医精神疾病的病因病理特点	25
第一节 精神疾病的病因特点	25
一、七情致病的特点	25

二、六淫的致病特点	27
三、其他因素	28
第二节 精神疾病的病理特点	29
一、阴阳失调与精神疾病的关系	30
二、脏腑功能失调与精神疾病的关系	30
三、经络失调与精神疾病的关系	32
四、气血功能失调与精神疾病的关系	32
五、痰、火与精神疾病的关系	35
第四章 中医精神疾病常用治疗法则	37
第一节 活血化瘀法	37
第二节 理气解郁法	39
第三节 清热泻火法	40
第四节 涤痰开窍法	43
第五节 养血安神法	45
第六节 温阳振奋法	47
第五章 常见精神疾病中医临床治疗	49
第一节 精神分裂症	49
第二节 情感性精神障碍	66
第三节 神经症	83
一、神经衰弱	83
二、癔症	96
三、焦虑性神经症	105
四、强迫性神经症	113
第四节 癫痫性精神障碍	120
第五节 老年痴呆症	130
第六节 颅脑外伤所致的精神障碍	141
第七节 儿童多动症	150
第八节 更年期精神病	162

第九节 睡眠障碍	170
一、失眠症	171
二、嗜睡症	181
第十节 气功偏差所致精神障碍	187
第六章 精神科急症的中医处理	197
第一节 精神科急症处理的一般原则	197
第二节 精神科急症处理	198
一、兴奋状态的急症处理	198
二、神郁状态的急症处理	200
三、意识模糊状态的急症处理	202
四、癫痫持续状态的急症处理	204
五、精神药物急性中毒的处理	205
第七章 祖国医学的心理疗法	209
一、疏泄开导法	209
二、反相调治法	214
三、气功“参禅”疗法	220
四、修身养性法	222
[附篇一] 文献选议	228
[附篇二] 中西医结合精神疾病辨证分型诊断标准	253
[附篇三] 精神疾病常用方剂选	258

人们对精神疾病的认识由单纯的实践经验逐步上升到了理论的高度,并又以此来指导临床实践。

一、《黄帝内经》奠定了精神疾病防治的理论基础

《内经》为我国现存最早的医学著作,约成书于战国前后。该书对精神疾病进行了系统的论述,对“癫狂”、“狂症”、“癲痢”、“躁”、“癲疾”等病的病名确定和临床发病机制与特征进行了较系统的论述,并专集为“癫狂篇”,这是论述精神疾病最早的专门篇章,初步奠定了中医防治精神疾病的理论基础。

1. “心神”论

《内经》把人的精神活动归之于“心神”的功能。所谓“心藏神”,“心者,君主之官,神明出焉”。“心神”不仅主持人的精神活动,而且统管人的五脏六腑,故“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也”。《灵枢·本神篇》指出:“生之来谓之精,两精相搏谓之神”。“人始生,先成精,精成而后脑髓生”,“神者,水谷之精气也”。这充分说明了“神”是在物质基础上表现的功能活动。这种活动,将随生命的终止而消失。如《灵枢·天年篇》曰:“人生十岁,五脏始定,血气已通,……百岁,五脏皆虚,神气皆去,形骸独居而绝矣。”的神形终结论,为祖国医学对精神活动的认识,已达到了相当的认识水平。

“神”的活动,在《内经》中是以“五神”和“五志”来表现的,而“五神”和“五志”分属于“五脏”,由心来统领。《素问·宣明五气篇》论曰:“五脏所藏,心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏志”。所谓神、魂、魄、意、志统称为五神,是人的精神活动的各种不同的内在表现。《素问·阴阳应象大论》曰:“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐”,即是五志。并且认为:肝在志为怒,心在志为喜,脾在志为思,肺在志为忧,肾在志为恐。后世在“五志”的基础上发展成为喜、怒、悲、思、忧、恐、惊七情学说。

2. “情志”说

在情志医学方面,《内经》强调“恬淡虚无”、“精神内守”、“形与神俱”(《素问·上古天真论》)的防治思想,对情志失常的病理、病症等方面的叙述尤为详尽。如“怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下……惊则气乱……思则气结”(《素问·举痛论》)。对各种情志产生不同的病症,则有“心怵惕思虑”则“破腠脱肉,毛悴色夭”;“脾愁忧而不解”则“四肢不举,毛悴色夭”;“肝悲哀动中”,则“人阴缩而挛筋,两胁不举……”;“肺喜乐无极”则“皮革焦,毛悴色夭”;“肾盛怒不止”则“喜忘其前言,腰脊不可以俯仰屈伸”(《灵枢·本神篇》)。在护理方面强调医者要关心体贴患者,做好思想疏导工作,纠正其心理偏衡状况,指出“人之情,莫不恶死而乐生,告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦,虽有无道之人,恶有不听者乎”(《灵枢·师传》),阐述了语言开导,精神安慰,是诊治、护理情志病症时所不可忽视的一个重要方面,为中医心理学奠定了基础。

3. 癫狂

《内经》对癫狂症的成因、病理、症状及治疗等问题,作了较系统的论述,并出现了讨论癫狂的专篇——《灵枢·癫狂篇》。该篇着重阐述狂症,认为引起狂症的原因是“邪”,如《素问·宣明五气论》曰“邪入于阳则狂”;并提出“火邪”是主要的发病原因,“诸躁狂越皆属于火”(《素问·至真要大论》)。同时认为狂症的发病机制是阴阳不平衡,如《素问·生气通天论》曰“阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂”。《内经》对躁狂状态做了生动细致的描述,并提出了要经络取穴针刺的方法。《灵枢·癫狂篇》曰“狂始生,先自悲也,喜忘,苦怒、善恐者,得之忧饥,治之取手太阴、阳明,血变而止,及取足太阴、阳明。”“狂

始发，少卧，不饥，自高贤也，自辩智也，自尊贵也，善骂詈，日夜不休，治之取手阳明、太阳、太阴、舌下、少阴。视之盛者，皆取之，不盛，释之也”。“狂，目妄见、耳妄闻、善呼者，少气之所生也。治之取手太阳、太阴、阳明、足太阴、头、两颞”，“狂而新发，未应如此者，先取曲泉左右动脉及盛者见血，有顷已；不已，以法取之，灸骨骶二十壮。”《素问·病能论》还提出了“夺其食”“服以生铁落为饮”的治疗方法。

4. 癲疾

《内经》对癲疾的论述，主要是指癲痫，古代医书中，癲与颠通用，癲疾是头部的病。《素问》提出癲疾可由先天因素产生，也可由阴阳失调所致，并认识到癲痫可以自行停止发作，有的病例最初发病稀少，如果不予治疗可逐渐严重起来。如《素问·奇病论》曰：“人生而有病癲疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癲疾也。”这里的“癲疾”即是后世所说的“痫症”。又如《素问·大奇论篇》云：“心脉满大，病癲筋挛，肝脉小急，病癲筋挛”，这是对痫证临床表现的初步描述。

5. 其他

《素问·厥论篇》曰：“阳明之厥，则癲疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言”，所谓阳明之厥，就是外感发热的意思，高热所引起的神志谵妄、幻觉丰富和精神运动性兴奋状态，与现代感染中毒性精神障碍极为相似。《灵枢·经脉篇》曾生动描述“洒洒振寒，善呻，数欠，颜黑，病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处”的一组症状，近似现代精神病学中的迫害妄想与幻觉症状。

此外，《灵枢》首次出现了“奔豚”一词（《灵枢·邪气脏腑

病形篇》)对精神因素引起突然失音的发病机制进行了讨论,提出了针刺天突穴可以促使发音恢复正常,并对登高而发眩晕,以及善忘、善饥、不得卧、多卧、卒然多卧、少瞑等症状的病因病机分别作了解释,认为与阴阳失调有关。

《内经》所提出的上述见解,是对中医精神疾病的初步的概括,为后世精神医学的发展奠定了基础。

二、《难经》提出以阴阳作为癫狂分类的理论根据

《难经》是我国古代著名经典医学著作之一。它在《内经》的基础上进一步发展,《难经·第二十难》中指出:“重阳者狂,重阴者癫”,首先提出以阴阳作为癫狂分类的理论根据,这一认识直到现在仍为许多医家所采用。同时该书还对癫、狂以及发热谵妄加以鉴别。《难经·五十九难》曰:“狂癫之病,何以别之?然狂之始发,少卧而不饥,自高贤也,自辩智也,自倨贵也,妄笑好歌乐,妄行不休是也。癫病始发,意不乐,僵卧直视,其脉三部阴阳俱盛是也”,“病若谵言妄语,身当有热,脉当洪大”(《难经·十七难》)。这些以临床表现作为区分三种病证的依据,在如今仍然有其指导意义。

三、《伤寒杂病论》为精神医学奠定了临床治疗基础

《伤寒杂病论》是汉代名医张仲景所著,它对癫、狂、痫的叙述并没有超过《内经》的范围,但该书集两汉以前医学之大成,对临床医学的方剂学有了进一步发展,同样对精神医学的临床治疗产生了一定影响。张氏对急性热病或传染病所引起的精神障碍做了很细致的观察,提出“谵妄”、“伤寒发狂”、“热入血室”、“郑声”、“狂语”、“妄见”等病名。如《伤寒论·第145条》曰:“妇人伤寒,发热,经水适来,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状者,此为热入血室。”记述了发热谵语,不仅伴有恐怖性幻觉,且具有昼轻夜重的特点。《伤寒杂病论》还对这类精神障碍

提出了方药和针刺等治疗方法,丰富了精神医学的内容。如:

“太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。……宜桃核承气汤。”

“伤寒八九日,下之,胸满烦惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之”。

“伤寒脉浮,医者以火迫劫之,亡阳,必惊狂,卧起不安者,桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之”。

“太阳病六七日,表证仍在,脉微而沉,反不结胸,其人发狂,以热在下焦,少腹当硬满,小便自利者,下血乃愈,所以然者,以太阳随经,瘀热在里故也,抵当汤主之。”

“伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕……小柴胡汤主之。”

张氏在《金匱要略》中对多种精神疾病的临床治疗也做了详细的描述:“奔豚病,从少腹起上冲咽喉,发作欲死,复还止,皆从惊恐得之。”并根据不同病因提出奔豚汤、茯苓桂枝甘草大枣汤和桂枝加桂汤。

《金匱要略》还首先提出脏躁症,“妇人脏躁,悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主之。”“妇人咽中如炙脔,半夏厚朴主之”。这些症状的描述很象,现代的癔症、梅核气等。

“百合病者,百脉一宗,悉致其病也,意欲食复不能食,常默然,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美时,或有不闻食臭时,如寒无寒,如热无热,口苦小便赤,诸药不能治,得药则剧吐利,如有神灵者……”其原因或为热病前后,或因忧思过多,根据不同病因采用百合汤加减治疗,这些症状的描述与现代神经症极为相似。

《金匱要略》还记述了产后感染伴发精神障碍的治疗方法。“产后七八日,无太阳证,少腹坚痛,此恶露不尽,不大便,

烦躁发热，切脉微实，再倍发热，日晡时烦躁者，不食，食则谵语，至夜即愈，宜大承气汤主之”。

由于战国、秦汉这一历史时期，《内经》从理论上对精神疾病作出了重要贡献；《伤寒杂病论》在《内经》的基本理论基础上与临床实践有机地结合起来，为一部分精神疾病提出了临床治疗方法，对精神疾病的防治进行了初步的概括，因此可以认为，这一历史时期是精神疾病中医防治体系的初步形成阶段。

第二节 精神疾病防治体系的不断发展

秦汉之后，随着人们对精神疾病的认识不断深化，精神疾病和临床经验的逐步积累，从而使得精神疾病中医防治体系得到进一步发展。

一、晋唐时期的主要成就

晋唐时期的主要贡献在于当时医家对精神疾病病因病机及临床分类学的进一步认识和诊断，治疗方法的创新。

在病因病机学方面，巢元方的《诸病源候论》曰“心气虚，则风邪乘虚伤其经，入舍于心，故为风惊邪也，其状乍惊乍喜，恍惚失常是也”，提出心气虚，风邪所伤而致精神异常。同时认为“狂病者，由风邪入并于阳所为也，风邪入血，使人阴阳二气，虚实不调，若一实一虚，则令血气相并，气并于阳则为狂发，或欲走，或自高贤称圣是也。”强调了阴阳平衡失调是导致精神异常的病理机制。孙思邈在《千金方》中进一步提出“风入阳经则狂，入阴经则癫”强调“风邪”对狂症和癫症的致病作用。

在临床分类学方面：王叔和提出“大入癫，小人痫也”（《脉经》卷二）。将癫痫按年龄划分为癫和痫两类。孙思邈归纳王

睡两昼夜，醒后恢复常态。这是一个用药物进行睡眠疗法最早的记载，反映古代医家已经有了较高的治疗水平。

这一时期的精神病学继承了秦汉医学的基本理论，病因学强调“风邪”的致病作用，精神疾病症状学更为细致。疾病分类学更进一步完善。治疗方面，大量使用针灸和药物，对后世精神疾病学的发展产生一定影响。

二、宋元时期的重要贡献

宋元时期各家医学学说纷纷崛起，学术争鸣空前活跃，使得人们对精神医学的认识又有了新的突破，提供了许多新的见解。

“火热过亢论”：河间刘完素发挥《内经》“诸躁狂越皆属于火”的理论，力倡火热说，认为癫狂是由于火热过亢而致。他说：“心火旺，则肾水衰，乃失志而狂越。”又说“多喜为癫，多怒为狂，然喜为心志，故心热甚则多喜而为癫，怒为肝志，火实制金不能平木，故肝实则多怒而为狂，况五志所发，皆为热”（《河间六书》）。至于惊、惑、悲、笑等病症，他都认为与心火有关，主张治疗以降心火益肾水的寒凉药为主。

“痰迷心窍说”：张从正首倡“痰迷心窍”之说，认为精神疾病主要是由于痰迷心窍所致。他在《儒门事亲》一书中指出“肝屡谋，胆屡不决，屈无所伸，怒无所泄，心血日涸，脾液不行，痰迷心窍则成心风。”他擅长汗、下、吐三法治病，主张用吐下法猛攻顽痰。张氏的“痰迷心窍”说对后世影响极大，至今乃是精神疾病的主要理论之一。

朱丹溪进一步发展了张从正的“痰迷心窍”说，认为癫狂二症“大率多因痰结于心胸间，治当镇心神，开痰结”，又云“癫者神不守舍，狂言如有所见，终年不愈，心经有损，是为真病。如心经蓄热，当清心除热；如痰迷心窍，当下痰宁志。若癫哭呻

吟，为邪所凭，非狂也……”，提出了“镇心神，开痰结，下痰宁志”的治疗原则。

以情胜情的“活套”法：朱丹溪在《内经》五志七情学说的基础上，明确提出了以情胜情的“活套”疗法，他认为“五志之火，因七情而起，郁而成痰，故为癫癇狂妄之证，宜以人事制之，非药不能疗也，须诊察其中以平之”。朱氏在“活套”疗法医案中描述的非常生动、真实，比较完整地发挥了中医关于精神病的心理治疗方法。

三、明清之际的重大进展

明清时期，中医学对精神疾病无论辨证论治、病因病理，还是防治方法，都又有了进一步发展，其中突出地体现在以下几位杰出医家的学术观点。

虞搏对癫狂二症辨证论治有其独到的见解，他在《医学正传》中指出：“大抵狂为痰火实盛，癲为心血不足，多为求望高远者有之。癲病独主乎痰，因火动之所作也。治法，癲宜乎吐。狂宜乎下，癲则宜乎安神养血，兼降痰火。虽然，此三证者，若神脱而目瞪如愚痴者……吾未如之何也已矣。”他反对《难经》以阴阳辨癫狂之说，提出应从虚实辨证，并明确指出疾病如发展到精神衰退，出现类似愚痴时，预后甚差，这是从临床角度对精神疾病做出的实事求是的预后判断。

王肯堂所著的《证治准绳》一书中，对我国明代以前中医各科作了一次系统的总结，且列出神志门，形成了比较完整的精神病学专章，将精神病分为癫狂癲、烦躁、惊悸恐三大类。在癫、狂、癲下，又将癫、狂、癲三者明确区分，指出“素问止言癲而不及癲，灵枢乃有癲癎、癲厥之名，诸书有言癲狂者，有言癲癎者，有言风癎者，有言惊癎者，有分癲癎为二门者，迄无定论，究其独言癲者，祖素问也，言癲癎，言癲狂者，祖灵枢也。要

之癲癩狂，大相迥庭，非名殊而实一之谓也。”改变了以往对癲癩这个概念长期混淆不清的状况。在烦躁项下列有烦躁、谵妄、循衣摸床、喜笑不休、怒、善太息、悲诸类。在惊悸恐下列有惊、悸(怔忡)恐、健忘诸类。其中还对癩病与中风、中寒、中暑和痉病的鉴别作了描述，著述分类明确，论证精辟，简洁扼要，为后世医家论证癲、狂、癩者所师崇，实为当时精神病学的一大进步。

明代张介宾在《景岳全书》中对“痴呆”的病因症状、治疗及预后均有独到的见解，他说：“痴呆症，凡平素无痰而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑惑，或以惊恐而渐至痴呆，言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证则千奇万怪，无所不至。……此证有可愈者，有不可愈者。”这种对精神病痴呆症状的详细描述，颇似十九世纪德国精神病学家克雷不林(Kraepelin)所描述的“早发性痴呆”，但在时间上却早了二百多年。

清代陈士铎所著的《石室秘录》将精神病分为癲症、狂症和呆病三类，其中对呆病论述甚详，“呆病如痴而默默不言，如乱而悠悠如失也，意欲癲而不能，心欲狂而不敢，有时睡数日不醒，有时坐数日不眠，有时将己身衣服密密缝完，有时将他人物件深深藏掩，与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉，与之食则厌薄而不吞，不与食则吞炭而若快。”形象生动，与现代的精神分裂症表现极为相似。他还将癲病分有花癲之证，曰“如人病花癲，妇人忽然癲癩，见男子抱住不放，此乃思慕男子不可得，忽然得病，如暴风疾雨，罔识羞耻，见男子，则为情人也。”描述青春型精神病性欲亢进的精神症状。该书尚有许多生动的病案记载，在治疗上除以方药治疗外，还强调药物治疗与精神治疗相结合的方针，内容相当丰富，实为一部精神病论述的重要著作。

我国精神病学简介”(中华神经精神科杂志,1955,1(1):14)和“我国古代的精神病学”(同上 1955,1(3):167);湖南罗忠悃整理的“中医书籍对癫痫的认识”(同上 1957,3(2):93)等,对以后学习与整理中医精神病学的典籍皆有一些帮助。近年来中医古籍出版社出版的《癫狂痫》,上海科学技术出版社出版的《失眠嗜卧专辑》以及陈元德编著的《中医精神病学集成》等专辑,在一定程度上对祖国精神病学的典籍进行较全面的整理。

二、在临床研究方面

60年代有不少地区、单位以中药、针灸为治疗精神病的主要方法,应用的人数以万计,象这样广泛、长期地进行临床试验工作,其规模之大是空前的,尽管多数以可重复性低、疗效不确切而不能持续下去,但也为今后临床研究提供许多有益的经验与教训。

在辨证论治方面,有些学者对一些历史影响较大的理论、学派进行了一些以现代科学为基础,按现代科研方法设计的临床研究及实验室研究,并据以开展了“痰火”说与“瘀血”说之争,有效地促进了中医精神科基础理论的发展。70年代上海精神卫生中心,周康主任等首先对“痰迷心窍说”提出了质疑,其发表的“痰迷心窍论在精神科所引起的影响及其实用价值”在全国产生了很大的反响,引起了别开生面的学术争鸣,对中医精神科的发展产生了较大的影响。他力倡“瘀血”说,自拟“达营片”(三棱、莪术、大黄、赤芍)治疗周期性精神病、精神分裂症,取得较好的临床疗效。此后东北地区吴彩玉等,江西杨春霖、谢勇、汪斌等先后设计应用活血化瘀中药与西医抗精神病药对照研究,均可看出中西医结合治疗之优越性,即小剂量西药合并活血化瘀中药治疗组,疗效与大、中剂量西药组相

成立,通过学术交流与组织协作研究推动了精神科领域中西医结合研究的发展,先后制订了常见精神疾病的中西医结合辨证分型标准,包括精神分裂症、躁郁症及神经症;同时全国各地重点开展了上述常见疾病之中西医结合治疗的研究,取得可喜的科研成果。

总之,建国四十多年来,中医精神科领域得到了空前的发展,特别是开展精神疾病“瘀血”学说的基础理论和临床治疗研究,取得了可喜的成就,为今后中医精神科的发展提供了有益的探索途径。

三、现代科技手段和方法在临床科研中的应用

运用现代科技成就挖掘和整理祖国医学遗产,是中西医结合的重要途径之一,也是临床和科研等必不可少的工具。

在实验室检查方面,目前在精神科的常用的检测手段,如微循环观察、血液流变学、血液动力学、血液凝固机制等检查方法,提示精神病的发病,与其血液成分及理化特性的改变有密切关系,这为活血化瘀法治疗精神疾病提供了佐证。

在药物研究方面,中国中医研究院西苑医院翁维良等对34种传统活血化瘀药,在血液流变学作用方面的比较研究,进一步探索了活血化瘀的作用内涵。广州军区吴焕等对活血化瘀药的化学成分进行了研究,在一定程度上阐明了药物的作用机制。

血瘀证与活血化瘀研究,是我国中医、中西医结合研究中成果显著,疗效好,发展迅速的领域之一,对现代医学的基础与临床研究产生了广泛影响。目前来看,活血化瘀法在精神科的研究较其他治疗法则深入,但还有待进一步深入提高,应在目前研究成果的基础上,选择疗效高、结论可靠、具有代表性的病种,进一步深化机制的研究,以期取得突破性进展。

第二章 祖国医学有关正常精神活动的认识

祖国医学整体地看待人的精神活动,在长期的医疗实践中,历代医家们不断地进行探索,从理论上可概括为阴阳整体说、心主神明论、脏象五志论、脑论以及形神学说、七情学说等,这些理论不仅是贯穿于对精神医学体系整个发展过程,而且贯穿于病因、病机、诊断、治疗、预防保健等各个环节,形成独特的精神医学理论体系,这些理论至今仍有效地指导着中医临床实践。

第一节 阴阳整体说

祖国医学把人体看作是阴阳对立统一的整体,认为阴阳的对立统一是人体保持躯体与精神健康的根本。《素问·宝命全形论》说:“人生有形,不离阴阳。”人的精神充沛,心理活动正常是机体阴阳协调的综合体现。所以《素问·生气通天论》说:“阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。”阴阳的偏差,可产生不同样的情绪变化。如《灵枢·行针》有“重阳之人,其神易动,其气易往也”。“重阳之人,焄焄高高,言语善疾,举足善离。心肺之脏气有余,阳气滑盛而扬,故神动而气先行。”提出了阳气偏盛的人,具反应敏感、情感丰富、讲话很快、性格活跃、乐观等外向性格表现。而阴阳严重失调还可以产生各种精神疾病,如《素问·生气通天论》有“阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。”《难经》中称:“重阳则狂,重阴则癲。”均阐述阴阳的

行,尤其是需要血液提供充分的养料,故《素问·八正神明论》说:“血气者,人之神,不可不谨养。”若人之血气充盛,血脉调和而通利,则表现为精神充沛,神志清晰,感觉灵敏,活动自如。正如《灵枢·平人绝谷》说:“血脉和利,精神乃居。”因此,无论何种原因引起的血虚、血热、血瘀或血液运行失常都可能出现精神衰退、健忘、失眠、多梦、烦躁,甚则精神恍惚、惊悸不安、癫狂以及谵妄、昏迷等神志失常的临床表现。正如《景岳全书·血证》论所称血“灌溉一身,无所不及,故凡为七窍之灵,为四肢之用,为筋骨之和柔,为肌肉之丰盛,以至滋脏腑,安神魂,润颜色,充营卫,津液得以通行,二阴得以调畅,凡形质所在,无非血之用也,是以人有此形,惟赖此血,故血衰则形萎,血败则形坏”。其中“七窍之灵”、“安神魂”均阐述了血与精神活动的密切关系。

第三节 脏象五志说

《素问·阴阳应象大论》曰:“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐”,“肝在志为怒,心在志为喜,脾在志为思,肺在志为忧,肾在志为恐”。《内经》把五脏与人的情志活动(谓之五志)联系起来,认为人有五志分属五脏,五志五脏之间存在着五行制胜的规律。如“怒伤肝,悲胜怒”,“喜伤心,恐胜喜”,“思伤脾,怒胜思”,“忧伤肺,喜胜忧”,“恐伤肾,思胜恐”(《素问·阴阳应象大论》)。在临床上就可以利用这种相互的关系,采用以情治情的方法,去调节因某种情志刺激而引起的疾病,以消除情志障碍,纠正不良心理状态。以情胜情疗法的具体运用如下:

1. 悲胜怒

怒是一种勃发粗犷的情志,易导致人体气机逆乱。肝主疏

泄，性喜条达，肝疏泄条达与否对人的精神活动影响很大。郁怒不解则容易引起脏腑气机紊乱，出现胁痛、口苦、头痛、烦躁、焦虑、紧张不安等症，甚则横走脾土而见腹胀、纳呆、呕逆等症。悲为肺所主，肺主宣发肃降，肺气以清下肃降为顺。在五行上肺金克肝木，“忧则气消”（《素问·阴阳应象大论》），故悲伤的情感可制怒，治疗时多采用“怆恻苦楚之言感之”（《儒门事亲》），唤起患者的悲伤情感，以治疗郁怒的情志症。

2. 恐胜喜

喜归心属火，喜本为乐事，但凡物太过，其气偏激皆为患。喜太过则气缓，心气耗散则“神惮散而不藏”（《灵枢·本神》），故见健忘、失眠、多笑、喜笑不休。恐属肾主水，在五行上肾水克心火，在病理上，“恐则气下”（《素问·举痛论》），故“恐可以治喜，以迫惧死亡之言怖之”（《儒门事亲》），临床上可运用惊惧怕之类的刺激去治疗某些强迫症和忧郁症。这种做法与现代的行为疗法有相似之处。

3. 喜胜忧

忧归肺属金，肺主气而忌愤郁。《内经》曰：“忧愁者，气闭塞而不行”，气闭不畅则加重了忧郁的情绪，故常见忧闷不舒、无故担忧愁郁、胸膈满闷等症。喜属心主火，在五行上心火克肺金，“喜则气和志达，营卫通利，故气缓也。”（《素问·举痛论》）。《吴医汇讲》曰：“凡人有所忧愁，每多胸膈不舒，适逢欢快之事，即可情怀开旷，此尤情性之常，宁独火可胜金而已哉。”用娱乐、欢喜的方法去唤起病人精神上的喜悦、欢快，来治疗忧郁、悲伤的病人。这就是现代所谓的娱乐疗法。

4. 怒胜思

思归脾属土，思之过甚，可以使人的行为和活动调节发生障碍，使气不行而结滞，即所谓“思则气结”（《素问·举痛

论》),常见有精神不振,倦怠乏力,纳少便溏等症。怒属肝之木,在五行上肝木克脾土,在病理上“怒则气上”(《素问·举痛论》)。临床上可采用激怒或活跃病人的情绪,以治疗因忧思气结所致的情志障碍的疾病。

5. 思胜恐

恐归肾属水,恐是感到自己或亲近者的安全、利益受到威胁而产生的一种畏惧心理。恐常与惊同时产生,临床上常表现坐卧不安,如人将捕之状或惧怕某种事物者。思属脾主土,在五行上脾土克肾水。在病理上“思则气结”(《素问·举痛论》),临床上常以“以虑彼志此之言夺之”(《儒门事亲》)。思可以促使病人进入反省的境地,去领悟事物真实状况,摆脱精神枷锁,从而获得精神上的轻松、愉快,其病自可渐愈。这种用心思考揣摩,令病人反省自责,以解除恐惧心理的疗法与现代森田疗法相似。

第四节 脑 论

中医对脑的论述早已有之,《素问·脉要精微论》曰“头者精明之府”,“脑为髓之海,其输上在于其盖,下在风府”(《灵枢·海论》),“诸髓者皆属于脑”(《素问·五藏生成篇》)。明清时代,关于脑主神明的认识有所发展,李时珍独倡“脑为元神之府”,开辟了“脑主神”学说之先河。金正希曰:“人之记性皆在脑中”。清代医家王清任根据自己对人体解剖的观察和认识,明确地提出了“灵机记性,不在心在脑”的见解。同时进一步阐明“两耳通于脑,所听之声归于脑,……两目系如线长于脑,所见之物归于脑,……鼻通于脑,……所闻香臭归于脑”(《医林改错》),详细描述了人在清醒状态下以视、听、嗅等感官接受客观条件刺激反映于脑,并产生相应感觉和运动,尤其

维活动,也称“神志”、“神明”。如《素问·灵兰秘典论》所说的:“心者,君主之官,神明出焉”,及曰“积神于心,以知往今”(《灵枢·五色》)等。③指自然界物质运动变化的功能表现及其内在规律,如《素问·天元纪大论》说:“故物生谓之化,物极谓之变,阴阳不测谓之神,神用无方谓之圣”。荀况也指出:“万物各得其积以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神”(《荀子·天论》)。

形与神的关系,是物质与精神的关系,形体是本,神是形体生命活动的表现,有形体才有生命,有生命才产生精神活动。气血是神的物质基础,所谓“血气者,人之神,不可不谨养”(《素问·八正神明论》),而气血的生成又有赖于脏腑的功能活动。如“五味入口,藏于肠胃,味有所藏,以养五气,气和而生,津液相成,神乃自生”(《素问·六节藏象论》),都说明“神”不能离开形而单独存在。但是,人体脏腑组织的功能活动以及气血的运行又受“神”的主宰和影响,故《类经·摄生类》说“虽神由精气而生,然所以统驭精气而为运用之主者,则又在吾心之神。”形神统一是生命存在的主要保证。

形神统一观是精神疾病诊断治疗的重要理论根据之一,也是养生防病,调摄精神的方法之一。如《素问·上古天真论》说:“活淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”及“外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自得为功,形体不敝,精神不散,亦可百岁。”

第六节 七情学说

人的情志活动与内脏生理活动存在着密切的关系,人的精神情志活动,是整个机体功能活动的组成部分,在全身气血正常运行,脏腑功能正常的情况下,人才能进行正常的精神情

志活动,故《素问·阴阳应象大论》说:“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐。”

七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊是机体对客观事物的刺激在精神情志方面的反应,通常情况下,是人体生理活动的一部分,并不足以导致疾病。然而,如果由于长期的精神刺激或突然的剧烈的精神创伤,就会引起精神异常,甚至影响脏腑功能失调而产生各种疾病。反之,脏腑的生理活动的异常,则又可引起有关情志的异常。

1. 喜

喜为心志,喜乐是心情愉快的表现,有益于身心。故《素问·举痛论》说:“喜则气和志达,营卫通利。”但喜乐过度又可致心神受伤。《灵枢·本神》说“喜乐者,神惮散而不藏”。从心主神志的生理功能、活动状态来说,其太过与不及均能引起情志的变化。如《素问·调经论》说:“神有余则笑不休,神不足则悲”。《灵枢·本神》又说:“心气虚则悲,实则笑不休。”又说“肺喜乐无极则伤魄,魄伤乃狂”。《灵枢·癫狂篇》更明确指出:“狂者多食,善见鬼神,善笑而不发于外者,得之有所大喜。”说明喜乐过度,可引起精神失常。

2. 怒

怒为肝志,怒对人体生理活动来说属于不良刺激,他可使人体气血上逆,阳气升泄,肝火上走而情绪激动,甚则狂躁不安。如《素问·调经论》说“血有余则怒”,“气血上逆,令人善怒”(《素问·四时刺逆从论》),怒对人体颇伤,如“大怒则形气绝而血菀于上,使人薄厥”,均说明过度愤怒可产生精神异常、厥证、中风等。

3. 忧

忧为肺志,忧愁与悲伤均是受到不良刺激的情绪反应,他

主要影响肺气,悲又与心有关。《杂病源流犀烛》说:“忧者,肺与脾病也,肺居华盖之顶,下通心肝之气,心有所愁苦而不乐,则上薄乎肺而成忧,故忧为肺病”。又说“悲者,心肝两虚病也”,临床表现均以抑郁悲伤之征象。

4. 思

思为脾志,是人的精神意识思维相对集中于某一事物的表现。《素问·阴阳应象大论》说:“思伤脾”,思发于脾而成于心,思虑过度,可伤及心脾,临床上常见心悸怔忡、健忘、失眠、食少倦怠、少言恶动、面色萎黄等心脾两虚之证。

5. 恐

恐为肾志,是人们对事物惧怕的一种精神状态,恐与惊相似,但惊为不自知,事出突然而受惊,恐为自知又称胆怯,惊恐对人体生理活动产生不良刺激而引起疾病。《证治准绳·杂病》说“脏腑恐有四,一曰肾,二曰肝胆,三曰胃,四曰心”,说明恐还与心肝胆胃有关。恐与气血的关系较密切,《素问·刺逆从论》曰:“血气内却,令人善恐”,说明气血不足,容易造成惊恐症。

总之,七情与脏腑气血的关系密切,在生理上,情志变化以脏腑精气作为物质基础,是人体对外界客观事物的刺激所作的反应。不良的情绪刺激可影响脏腑、气血的正常生理活动,脏腑、气血等生理活动异常,也可引起有关的情志变化。七情学说已成为中医精神医学理论体系的重要组成部分。

第三章 中医精神疾病的病因病理特点

第一节 精神疾病的病因特点

祖国医学中,有关精神疾病病因学的内容是非常丰富的,但归纳起来,不外分为内因、外因、不内外因。内因指七情最为重要。外因指六淫。不内外因指饮食不节,劳逸所伤等。这些致病因素对精神疾病产生重要的影响。

一、七情致病的特点

七情致病特点概括起来主要有三个方面:一是直接伤及脏腑;二是主要影响气机;三是情志波动,常导致病情加剧和恶化。

1. 直接伤及脏腑

《灵枢·百病始生》说:“喜怒不节则伤脏,脏伤则病起于阴也。”同时认为不同的情志太过与相应脏腑的病变有关,如《素问·阴阳应象大论》中载有“怒伤肝”、“喜伤心”、“思伤脾”、“忧伤肺”、“恐伤肾”之说。《三因极一病证方论·五劳论治》说:“五劳者,皆用意施为,过伤五脏,使五神(即神、魂、魄、意、志)不宁而为病,故曰五劳,以其尽力谋虑则肝劳,曲运神机则心劳,意外致思则脾劳,预事而忧则肺劳,矜持志节则肾劳。”所以说情志伤,直接作用于内脏,并且还指出了不同的情志刺激,所伤的脏腑以及所表现的精神症状也有所不同。

必须指出,虽然情志损伤对脏腑有一定的选择性,但不能机械。因为人是一个有机的整体,情志活动又复杂多变,而总

统于心,故《灵枢·口问》说:“心者,五脏六腑之大主也,……故悲哀愁忧则心动,心动则五脏六腑皆摇。”指出了各种情志刺激都与心脏有关,心神受损,可涉及其他脏腑。

关于情志所伤与临床证候的关系,历代医学家各有见解,如明代戴思恭在《证治要诀》中说:“癫狂由七情所郁,遂生痰涎,迷塞心窍,不省人事,目瞪不瞬,妄言叫骂,甚至逾墙上屋,裸体打人。”《灵枢·癫狂》说:“狂者多食,善见鬼神,善笑而不发于外者,得之有所大喜。”“狂言、惊、善笑、好歌乐、妄行不休者,得之大恐。”张介宾在《景岳全书》论及痴呆与情志所伤的关系时写道:“凡平素无痰而或以郁结,或以不遂,或以思虑,或以疑惑,或以惊恐而渐致痴呆。”清代沈金鳌的《杂病源流犀烛》中也说:“或由于有所大恐大喜,大忧大惊,以至失神之为患也。”由此可见,古代医学家对精神因素的致病作用是相当重视的。

2. 影响气机

《素问·举痛论》说:“怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,……惊则气乱,……思则气结”。《三因极一病证方论·七气叙论》说:“喜伤心,其气散;思伤肝,其气出;忧伤肺,其气聚;思伤脾,其气结;悲伤心胞,其气急;恐伤肾,其气怯;惊伤胆,其气乱。虽七诊自殊,无喻于气。”说明情志变化可直接影响气机的功能紊乱进一步影响脏腑的功能。

3. 情志异常波动,可使精神症状加重,或迅速恶化

根据临床观察,在许多精神疾病的过程中,若患者有较剧烈的情绪波动,往往使病情加重,或急剧恶化,如精神疾病在病情稳定期间,常因突然重大的思想刺激而造成精神疾病的复发,或急剧恶化。

总之,七情内伤是中医精神医学病因学的重要内容。七情

致病,主要是使人体脏腑的气机紊乱,气血阴阳失调而致病;脏腑的功能失调,气血失常,又容易出现异常的情志变化。掌握七情致病的原理,对于精神疾病的防治有积极意义。近代学者在研究整理有关内容时认为,情志与内脏的联系,并非不同性质的精神刺激直接作用于某脏的结果,而是通过“心神”的调节使五脏分别产生的不同变化。情志变动对脏腑气血的影响,除取决于精神刺激因子的质和量外,更主要取决于“心神”状态。当“心神”健全,意志坚强时,机体虽受到一定质和量的精神刺激,但因能很好的调节,故不会发生强烈的情绪波动,即或一时波动,但能很快平复,也不致造成气血逆乱,脏腑功能失调。

七情虽属“神志”的活动,但在病理情况下,又是损伤“神志”的最直接因素,强调精神因素在发病中的重要作用,是中医发病学的一个特点,被当前新兴的“医学心理学”“心身医学”等学者所重视。经现代科学研究已证实,人体的各种内脏器官和内分泌腺体,都是直接受包括下丘脑在内的边缘系统和自主神经中枢所支配的,而这个中枢与控制情绪活动的中枢又是紧密联系的,于是在人的不同情绪活动状态下,就表现出各式各样的生理反应,当过度的情志变化一旦超过“心神”所能调节的限度,便变原有的生理状态而发病。七情致病初期,多为精神活动或脏腑气血失调,但由于“形神合一”之理,故病久必然影响及“形”,造成器质方面的损害,因此七情致病范围相当广泛,不仅有精神性、功能性疾病,也有很多器质性疾病。

二、六淫的致病特点

中医六淫指的是风、寒、暑、湿、燥、火之六类外界自然因素,认为六者的侵袭可以产生许多疾病,也可以产生精神病。

妇人在月经期或产后感染可发生精神失常。如《金匱要略》有“妇人伤寒、发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼者，此为热入血室”，及“产后七八日……恶露不尽……日哺时烦躁”等论述。《医学入门》中更明确指出“妇人月水崩漏过多，血气迷心，或产后恶露上冲而言语错乱，神志不守。”提出月经期精神障碍及产后精神病的特殊病理变化。

胎病：在《素问·奇病论》中载有：“人生而有癲疾者，……病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癲疾也。”后世医家对提出小儿五迟，解颅皆可由“胎弱”、“先天禀赋不足”所致，说明古代医家已认识到某些精神疾病与先天因素有关。

食物中毒：误食腐败变质食物，或误食有毒食物，可引起精神异常。《山海经》载有：“观水多鰮鱼，其味酸，食之已狂”。《肘后方》说：“食莨菪令人发狂”等均描述了误食有毒食物，可发生食物中毒，引起精神异常的症状。

此外尚有一部分精神障碍，是由于药石乱投，误治引起的精神失常，如《伤寒论》就有“伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂”。

总之，引起精神异常的原因很多，有些是直接的，有的是间接的，了解致病因素，对精神疾病的诊断与治疗有着十分重要的意义。

第二节 精神疾病的病理特点

精神疾病的发生发展，有着一系列的生理病理变化，祖国医学是以整体观点，运用阴阳五行、脏腑经络为纲，结合气血痰火等病理变化加以阐述的，这是辨证论治的基础，具有重要的临床意义。

一、阴阳失调与精神疾病的关系

祖国医学认为,机体的一切组织结构及其功能活动,均可分属于阴和阳两类不同性质的属性,机体各种组织结构之间,各种功能活动之间,组织结构和功能活动之间的平衡协调关系,处于“阴平阳秘”的平衡协调状态,这种平衡协调状态由于某些因素的作用而遭到破坏,就导致了阴阳失调。

人是阴阳对立的统一体,阴阳两者属性不同,功能也各异。《素问·生气通天论》说:“阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也,阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。”所以必须保持阴阳平衡,才能使精神活动保持正常。即所谓“阴平阳秘,精神乃治”(《素问·生气通天论》)。外感六淫,或七情内伤以及其他原因导致阴阳失调,就可能引起精神疾病,如《素问·宣明五气篇》说“邪入于阳则狂”。《类证活人书》说:“伤寒病,若阳气独盛,阴气暴绝,必发躁,狂走,妄言,而赤。”《素问玄机原病式》有“伤寒发狂奔走,骂詈不避亲疏,此阳有余,阴不足”。这些论述均是指外邪导致阴阳失调而出现的精神异常的症状。七情内伤所致的阴阳失调而产生的精神障碍,更为多见,如《素问·阴阳应象大论》中所说的“暴怒伤阴,暴喜伤阳”等等。

阳主动,阴主静,阴阳偏胜与偏衰,所表现的精神症状有所不同。如《内经》有“阳主动,阴主静”。《难经》有“重阳者狂,重阴者癫”。《脉经》有“阴附阳则狂,阳附阴则癫”。《丹溪心法》概括为:“癫属阴,狂属阳”,把精神疾病概括为阴性症状和阳性症状两大类。

阴阳失调与精神症状的发生有着密切的关系,阴阳胜衰的临床辨证,具体体现在脏腑、经络及气血痰火等病理变化。

二、脏腑功能失调与精神疾病的关系

脏腑功能失调与精神疾病有着十分密切的关系。《灵枢·

本神》说：“心怵惕思虑则伤神，伤神则恐惧自失，……脾愁忧而不解则伤意，意伤则惋乱，……肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，……肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，……肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言。”说明七情内伤，使心肝脾肺肾五脏受损，皆可导致精神失常。

1. 心系病变

心为五脏六腑之主宰，主神明，为七情活动的中枢，故心的病变产生的精神症状最多。临床常见有心气虚、心阳虚之心悸惊恐，精神衰退；心血虚、心阴虚之癫证；心血瘀阻，心神失宁之癫狂症。以及痰迷心窍、痰火扰心之癫、狂、痫症等。

2. 肝系病变

肝主谋虑，与胆互为表里，而胆主决断，司勇怯，所以肝脏的病变，可以产生一系列情感思维的改变。肝又主筋，抽搐痉挛等症多与肝有关，临床常见有肝气虚之恐惧症；肝阴虚之焦虑症；肝火旺之躁狂症；肝风动之癫痫症；肝气结之忧郁症等。

3. 脾系病变

脾主运化，为后天之本，脾伤则运化失司，容易转精化痰，痰浊内扰，可产生种种精神症状。脾与胃互为表里，所以有“脾胃为生痰之源”的论点。脾系病变与精神疾病的关系，临床常见有痰迷心窍之癫狂症，阳明火热之躁狂症，心脾两虚之惊恐，阴癫证，以及脾肾阳虚之精神衰退等。

4. 肺系病变

肺主气，朝百脉，与心共同调节百脉之气血，肺在志为忧，所以悲忧易伤于肺，临床上多见情志方面的变化。

5. 肾系病变

肾为先天之本，藏精而主骨生髓，脊髓上通于脑，脑为髓汇聚而成，而脑主精神活动，记忆和意识思维，肾精不足，髓海

虚空则多见头晕健忘，痴呆，愚智，以及精神衰退等症。

三、经络失调与精神疾病的关系

经络学说也是中医的基础理论的重要组成部分，与阴阳脏腑学说互相紧密联系，经络是沟通表里上下，联络脏腑和通行气血的独特系统。经络失调可产生多种精神异常的病变，如《素问·厥论篇》有“阳明之厥，则癫疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言”。《伤寒论·蓄血证》有“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂”以及温病学派认为神昏、谵语、言语错乱为邪入心包所致等，这些均说明脏腑经络受损，均可出现精神障碍。

十二经脉与督冲二脉病变时，所产生的精神症状，在历代医书中多有阐述，如《丹溪心法·十二经见证》中就有“足阳明胃经见证，恶人与火，闻木声则惊。狂，上登而歌，弃衣而走……善伸数欠。癫疾，湿淫心欲动，则闭户独处，惊。”“足少阳胆经见证，……善太息。”“手阳明大肠经见证，……耳聋焔焔焔焔，耳鸣嘈嘈。”“足太阴脾经见证，……怠惰嗜卧，抢心……烦闷……善噫，形醉……”。“足少阴肾经见证……嗜卧，坐而不起……善思，善恐……”。“足厥阴肝经见证，头痛，脱色善洁，耳无所闻……遗溺，淋洩……眩暈……善恐，胸中喘，骂詈。”“手少阴心经见证，……浸淫善笑，善恐，善意，……眩仆……悲。”“手厥阴别脉经见证，笑不休……”。以及王叔和《脉经》中所说：“冲督之脉者，十二经之道路也，冲督用事，则十二经不复朝于寸口，其人皆若恍惚狂痴”。这些论述为后世医学家运用针灸治疗精神疾病提供了重要的理论依据。

四、气血功能失调与精神疾病的关系

气属于阳，血属于阴。《难经·二十二难》说：“气主煦之，血主濡之。”《张氏医通》说：“盖气与血，两相维附，气不得血则

散而无统,血不得气,则凝而不流”。这说明了气与血之间,存在着相互依存,相互为用,互为阴阳,共同组成一个对立的统一体。气为生命活动的动力,血为生命活动的基础。不论何种原因,一旦造成气血失调,阴阳失去平衡,各种疾病即随之而生。

气与七情内伤的关系密切。《素问·举痛论》说:“百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,热则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结。”并认为“惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱矣。”阐述了七情内伤可直接影响气机功能。《儒门事亲》进一步描述了因七情内伤所致气机功能紊乱而产生各种精神症状,如“怒气所致,为煎厥,为薄厥,为阳厥”;“喜气所致为笑不休……甚则为狂”;“悲气所致为阴缩……为目昏,为少气不足以息”;“恐气所致……为阴痿,为惧而脱颐”;“惊气所致……为痴癎,为不省人,为僵卧”;“劳气所致为咽噎病,……为瞑视,为耳闭”;“思气所致,为不眠,为嗜卧,为昏瞢”;“热气所致……目不明,耳鸣或聋、躁扰狂越,骂詈惊骇,禁慄如丧神守”。临床上气机功能紊乱所造成的精神疾病多见于癫症、忧郁症、神经症、癎癎、痴呆以及情志方面的疾病等。

血是机体精神活动的主要物质基础,《素问·八正神明论》说:“血气者,人之神,不可不谨养”,若人之血气充盛,血脉调和而通利,则表现为精神充沛,神志清晰,感觉灵敏,活动自如。所以《灵枢·平人绝谷》说:“血脉和利,精神乃居”。血的功能紊乱,可直接产生精神障碍,如《素问·调经论》中就有“血有余则怒,不足则恐”和“血并于阴,气并于阳,故为惊狂”的论点。虞搏进一步提出“癫为心血不足”(《医学正传》)。李梴在《医家人门》中谈到“妇人月水崩漏过多,血气迷心或产后

恶露上冲，而语言错乱，神志不守者，此血虚神耗也。”阐述产后精神病是由于“血虚神耗”所致。

气与血关系十分密切，两者常同时为病，如张仲景在《金匱要略》中所论述“邪哭使魂魄不安者，血气少也，血气少者，属于心，心气虚者，其人则畏，合目欲眠，梦远行而精神离散，魂魄妄行”。巢元方《诸病源候论》说：“风癫者，由血气虚，邪入于阴经故也，人有气血少，则心虚而精神离散，魂魄妄行，因为风邪所伤，故邪入于阴，则为癫疾。”均阐述了气血功能紊乱，是产生精神疾病的重要因素之一。

瘀血与精神疾病的关系，最早见于汉代张仲景的《伤寒论》。如“妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状，此为热入血室，小柴胡汤主之”。又如“太阳病……如狂，血证谛也”等论述，对“蓄血症”及“热结膀胱”等症，提出用桃仁承气汤、抵挡汤等活血破瘀的治法。朱丹溪治一切杂病，俱于气、血、痰、郁四条求之，对癫狂也不例外。《医学入门》有“血迷心包”、“败血冲心”之论点，主张用泽兰汤并失笑散，或逍遥散加远志、桃仁、红花、苏木以调气破瘀。至明清有所发展，王清任明确提出气血凝滞说：“癫狂一症，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同作梦一样”，治用癫狂梦醒汤破气活血。近十几年来，随着祖国医学的不断发展，运用现代医学、现代科学方法研究中医精神疾病，不断取得突破与成果，特别是瘀血学说在精神疾病的运用与研究，取得令人接奋的成就，越来越显示其重要作用，不少单位及专家以活血化瘀治疗精神分裂症和其他精神病，取得较好的疗效。特别是近年来在中西医结合方面研究了活血化瘀理论与临床实践，运用现代科学技术方法分析了活血化瘀类中药的性能与成分，进一步提高“瘀血学说”的研究深度。随着血瘀证的不断研究深入，经较长期的临

床观察发现,活血化瘀在精神病治疗领域中可从各个不同侧面发挥其功用与所长,其临床之实用价值,又远远超出痰、火理论,同时也初步探索到一定的适用规律,有较广阔的研究前景。

五、痰、火与精神疾病的关系

痰火是中医病因病理学的主要内容,是脏腑病理变化的产物,同精神疾病的发生与发展有着十分密切的关系。

痰迷心窍的理论在中医精神医学理论中占有重要地位,早在《内经》中就有“下其痰”而治狂症的论述。明确把痰作为癫狂的病理机制,则起自金元时期的张从正与朱丹溪,张从正所著《儒门事亲》中有“肝屡谋,胆屡不决,屈无所伸,怒无所泄,心血日涸,脾液不行,痰迷心窍则成风”的论述。《丹溪心法》有“癫属阴,狂属阳,癫多喜而狂多怒,……大率多因痰结于心胸之间”。至此痰迷心窍说作为癫狂的重要病理学说的形成对后世产生了巨大的影响。以后明清医家如戴思恭、虞搏、徐春甫、张景岳、陈士铎等也都相继发扬了痰迷心窍学说,在临床辨证与治疗上都有了新的发展,目前这一学说仍然在精神疾病的临床辨证论治中占有重要的地位。

“火”为六淫之一,关于火与精神疾病的关系,早在《内经》中即有“诸躁狂越,皆属于火”(《素问·至真要大论》)等论述,强调了“火”能致狂的重要作用。历代医学家,在此基础上又有所发展,如明代李梴在《医学入门》中论及癫狂时指出“狂者凶狂也,轻则自高自是,好歌好舞,甚则弃衣而走,逾垣上屋,又甚则披头大叫,不避水火,且好杀人,此心火独盛,阳气有余,神不守舍,痰火壅盛使然”。又说“癫则异常也,平日能言,癫则沉默,平日不言,癫则呻吟,甚则僵仆直视,心常不乐,此阴虚血少,心火不宁”。由此可见,癫狂的发生不仅与“火”作用于

“心”有关,而且在临床上,尚有虚实的区别。

实火多因外感诸邪火化而致,来势较猛,变化迅速,常可见高热、狂躁、神昏谵语,便结尿黄,舌质红,苔黄燥,脉洪大数实。虚火多因内伤引起,如脏腑功能失调,气血阴阳偏衰,起病多缓慢,病程迁延。脏腑火症,与精神疾病有关的常见有心火炽盛、肝胆火盛的实火证及肾阴虚、心肾不交及肝肾阴虚等虚火证。

“痰”与“火”往往互为作用,在精神疾病的发生发展上经常起着重要的病理作用。如明代虞搏在《医学正传》中说:“大抵狂为痰火实盛,癫为心血不足,……狂宜乎下,癫则宜乎安神养血,兼除痰火”。说明不论癫症或是狂症,在临床辨证上应重视痰火密切的关系。

第四章 中医精神疾病常用治疗法则

第一节 活血化瘀法

“瘀血”与精神病的关系由来已久,早在《内经》就已提出“血”与“神”的关系,认为“神为血气之性”(《灵枢·小针解》),“血有余则怒,不足则恐”(《素问·调经论》)等论述。汉代张仲景提出“热入血室”、“蓄血症”、“热结膀胱”等证,并创桃核承气汤、抵挡汤等活血破瘀的治法;李梴提出“血迷心包”、“败血上冲”等精神病病理机制,提出用泽兰汤并失笑散,或逍遥散加远志、桃仁、红花、苏木以调气破瘀;还提出男子挟瘀血者用“陶氏当归活血汤”;对妇女产后精神病用开迷散、夺命散、调经散等活血化瘀方剂。至清代王清任,更明确地提出了气血凝滞的学说,认为“癫狂一症,乃气血凝滞,脑气与脏腑气不接,如同作梦一样”。从气血立论,治用癫狂梦醒汤调气破血。

祖国医学对于气血与精神失常的关系虽然有所认识,但不象痰迷学说那样受到重视,近40年来随着对“瘀血学说”的不断深入研究,普遍认为其适用范围及疗效,超过了痰火等理论,已越来越引起医学界的广泛重视。

一、常用方剂

1. 癫狂梦醒汤(《医林改错》)

桃仁、柴胡、香附、青皮、陈皮、半夏、木通、大腹皮、赤芍、桑白皮、苏子、甘草。

2. 血府逐瘀汤(《医林改错》)

头痛等。临床表现以情绪不稳、行为紊乱、兴奋躁动、妄想幻觉为突出症状者，如同时有病情反复发作、症状表现基本一致、唇舌出现青黑紫红瘀点或瘀斑、脉涩等瘀血征象，更为用本法的指征。

四、临床研究

根据有关报道，活血化瘀疗法对精神分裂症的妄想型、青春型疗效较好，而对单纯型、慢性型疗效欠佳，对躁狂症、反应性精神病、癔病精神发作、产后精神病、颅脑外伤所致精神障碍、周期性精神病有一定疗效。上海周康氏报道对周期性精神病，疗效优于西医治疗，一般认为本法对于情绪不稳、行为紊乱、兴奋躁动、妄想、幻觉疗效较好。

第二节 理气解郁法

气机郁滞与精神疾病的关系十分密切，《素问·举痛论》有“百病生于气”之说，《难经·八难》指出：“气者，人之根本也”，气贵流通，无病可生，一有郁滞，则变生诸症，气郁最常见为肝气郁结，可产生许多精神病证，如癫狂症、忧郁症、神经症以及情志病变等。根据《素问·至真要大论》“逸者行之，结者散之，高者抑之”以及沈金鳌之“气升则降，气逆则调”等治则，采用理气解郁法以舒畅气机，调整脏腑功能，达到调治精神之目的。

一、常用方剂

1. 逍遥散(《局方》)

柴胡、白术、当归、茯苓、甘草、煨姜、薄荷。

2. 四逆散(《伤寒论》)

柴胡、芍药、枳实、甘草。

3. 越鞠丸(《丹溪心法》)

香附、苍术、川芎、神曲、炒栀子。

4. 柴胡疏肝散(《景岳全书》)

柴胡、枳壳、陈皮、川芎、赤芍、香附、炙甘草。

5. 半夏厚朴汤(《金匱要略》)

半夏、厚朴、茯苓、苏叶、生姜。

6. 散花丹(《辨证奇闻》)

柴胡、陈皮、当归、栀子、白芍、生地、熟地、玄参、天花粉、茯神。

二、常用药物

精神科理气解郁常用药物有：柴胡、枳壳、香附、青皮、郁金、佛手、旋复花、绿萼梅、薄荷、苏叶、乌药、金铃子、延胡索等。

三、适应范围

临床主要用于各类精神疾病表现以精神运动性抑郁为主。证见精神抑郁、情绪不宁、少言呆滞、或时静时烦，躁扰不安，胸胁满闷，善喜太息，舌淡脉弦。

本法用药多属芳香、辛燥之品，易耗气伤阴，故在方药配伍上常加白芍、当归、麦冬、瓜蒌等养阴润燥之品。

四、临床研究

本法多用于治疗以精神运动性抑郁为主要症状的各种精神疾病，据有关报道，本法对精神分裂症之紧张状态、躁郁症之抑郁状态、神经性忧郁以及情志疾病有肝郁气滞见证者均有较好疗效。

第三节 清热泻火法

《内经》有“诸躁狂越，皆属于火”认为癫狂乃由于火热甚所致，并提出以“生铁落饮”治疗狂病之“热盛”、“阳盛”，后世

根据这一病因病机,制定出许多清热泻火的方剂。临床上主要有寒凉泻火法和清热养阴法两种方法。对兴奋躁动、狂乱不安、行为冲动等有明显阳明火盛的狂症病人,采用寒凉泻火法;而对于久热伤阴,“阳盛阴虚则水弱火强”(《格致余论》)的病人,应在清热泻火的同时给予大剂量的养阴药物,以达壮水熄火之目的。

一、寒凉泻火法

1. 常用方剂

(1) 龙胆泻肝汤(《兰室秘藏》):黄芩、柴胡、龙胆草、当归、车前子、焦山栀、泽泻、木通、生地、甘草。

(2) 泻肝汤(《三因极一病证方论》):前胡、柴胡、秦皮、细辛、栀子仁、黄芩、升麻、蕤仁、决明子。

(3) 当归龙荟丸(《宣明论方》):当归、龙胆草、栀子、黄芩、黄连、黄柏、大黄、青黛、芦荟、木香、麝香。

(4) 泻心汤(《证治准绳》):大黄、黄芩、黄连。

(5) 抽薪饮(《景岳全书》):黄芩、石斛、木通、炒栀子、黄柏、枳壳、泽泻、甘草。

(6) 防风通圣散(《宣明论方》):防风、川芎、当归、芍药、大黄、芒硝、麻黄、薄荷、石膏、桔梗、黄芩、白术、山栀子、荆芥、连翘、滑石、炙甘草、生姜。

(7) 大承气汤(《伤寒论》):大黄、厚朴、枳实、芒硝。

2. 常用药物

精神科寒凉泻火常用药物有:龙胆草、黄芩、黄连、黄柏、栀子仁、大黄、石膏、柴胡、木通、泽泻等。

3. 适应范围

临床主要用于各类精神病表现以精神运动性兴奋为主,特别是有脉弦数、苔黄、口干唇燥、面红目赤、尿黄便结、形盛

体实等实热证者,更为适宜。

本法用药多苦寒,久服则影响食欲,损伤脾胃,故当中病则止,而改用健脾调胃安神之剂,以减轻副作用,巩固疗效,常用药物如白术、百合、菖蒲、陈皮、太子参、远志、茯苓、柏子仁等。

4. 临床研究

本法多用于治疗以精神运动性兴奋为主要症状的各种精神病,即中医之“阳狂”、“狂症”,且伴有脉弦数、苔黄、尿黄少、大便干结、口干唇燥、形盛体实等阳亢火热之象,据报道本法对躁狂症、精神分裂症阳性症状、心因性反应症兴奋型、及部分感染中毒性精神障碍的某一阶段而出现上述征象者,应用此法有效。

二、清热养阴法

对子兴奋躁动时间较久,或服用大剂量抗精神病药而致津液亏损,阴虚火旺之表现者,在用清热药的同时,加用大剂量养阴药物,取养阴清热之法,亦可取得一定疗效。

1. 常用方剂

(1) 加减玉女煎(《温病条辨》):石膏、知母、玄参、生地、麦冬。

(2) 清营汤(《温病条辨》):犀角、生地、玄参、竹叶、麦冬、丹参、黄连、金银花、连翘。

(3) 二阴煎(《古今图书集成》):生地、麦冬、酸枣仁、白茯苓、玄参、木通、黄连、甘草、灯心草。

(4) 芩连清心丸(《杂病源流犀烛》):黄芩、黄连、天花粉、茯神、麦冬、丹参、牛黄、菖蒲、远志。

(5) 大补阴丸(《丹溪心法》):黄柏、知母、熟地黄、龟板。

(6) 知柏地黄丸(《医宗金鉴》):知母、黄柏、熟地黄、山萸

肉、干山药、泽泻、牡丹皮、白茯苓。

2. 常用药物

精神科常用清热滋阴降火的药物有：知母、生地、玄参、天冬、麦冬、沙参、黄柏、熟地、龟板等。

3. 适用范围

本法主要适用于更年期精神病、老年性精神病、精神分裂症、精神运动性兴奋日久、感染中毒性精神病的后期、某些神经官能症、癔症等，由于火邪伤及营分、心肾阴亏、阴虚火旺、见咽干口燥、尿赤便干、舌红苔少、脉细数等阴亏阳亢之症状者。

4. 临床研究

有报道本法对精神症状表现为焦虑、紧张、恐惧、忧郁或有幻听、猜疑，伴有五心烦热、口干盗汗、失眠、耳鸣、舌质红绛无苔、脉细数者常可获效，特别对于服用大剂量抗精神病药物后出现的锥体外系反应同时伴有阴虚火旺见症者，可起到减轻西药毒副作用。阴虚内热型多见于更年期精神病和精神分裂症妄想型和青春型。

第四节 涤痰开窍法

有关痰与癫狂的关系，早在《内经》就有治疗狂症宜“下其痰”的记载。自张子和、朱丹溪创痰迷心窍之学说后，后世医家更多以痰立论，形成对癫狂病因、病机论治之传统看法，至今仍为中医治疗精神病的主要学派之一。这一法则可分为两大类：一类以“涌吐顽痰”为主，用峻药猛攻以求迅速控制病情，代表方有三圣散、瓜蒂散、控涎丹、将军汤等；另一类以“清下痰火”为主，用大量较缓和的祛痰药物以消化体内的痰浊，如温胆汤、宁志化痰汤等。因这类治疗方法作用较缓和，不会产

生严重吐泻，故临床上运用较多。

一、化痰开窍法

这类方剂以大量化痰药物为主，加安神开窍之药组成。

1. 常用方剂

(1) 温胆汤(《千金方》):橘红、半夏、白茯苓、枳实、炙甘草、竹茹。

(2) 宁志化痰汤(《古今医鉴》):胆星、制半夏、陈皮、茯苓、天麻、人参、黄连、酸枣仁、石菖蒲、生姜。

(3) 神志丸(《增补内经拾遗方论》):茯神、远志、羌活、天南星、辰砂、益智仁、白附子、雄黄、枯矾。

(4) 白金丸(《医学纲目》):郁金、明矾。

(5) 六安煎(《景岳全书》):陈皮、半夏、茯苓、甘草、杏仁、白芥子、生姜。

(6) 解郁化痰汤(《经验方》):橘红、半夏、柴胡、郁金、香附、远志、菖蒲、瓜蒂、胆星、竹茹、丹参、琥珀。

(7) 涤痰开窍汤(《经验方》):胆南星、青皮、陈皮、竹沥、半夏、广木香、煅礞石、天竺黄、石菖蒲、生大黄、郁金。

2. 常用药物

精神科常用化痰开窍药物有:胆南星、浙贝母、瓜蒌、郁金、半夏、竹茹、陈皮、青皮、石菖蒲、白芥子、天竺黄等。

3. 适应范围

主要适用于精神分裂症，中医辨证为肝郁痰结者疗效较好。对一氧化碳中毒所致精神障碍疗效较佳。临床上对见有神志迷茫、行为紊乱、兴奋躁动不安、舌苔厚腻、脉带滑数等中医所称之痰浊弥漫之象的临床症状，有改善作用。

4. 临床研究

国内用此法治疗各种类型精神病的报道颇多，差异很大，

有的认为完全无效,有的认为疗效甚好。天津精神病院用解郁温胆汤治疗精神分裂症妄想型,其中以迫害妄想效果较好。北京安定医院经验也如此。上海精神病院用涤痰开窍法治疗一氧化碳中毒性精神障碍有效,但运用本法治疗几十例精神分裂症疗效不佳,认为对精神分裂症作用不大。

二、攻逐顽痰法

这类方剂由峻猛之剂组成,用药后产生严重的上吐或下泻,以达到逐荡顽痰的目的。有时因吐泻过度可产生脱水、电解质紊乱、虚脱等并发症,这类方剂现已为多数人所淘汰。

1. 常用方剂

瓜蒂散、龙虎丸、逐痰将军丸、甘遂散等皆为峻猛之剂。

2. 常用药物

瓜蒂、巴豆、砒霜、大黄、甘遂等。

3. 临床研究

这类疗法,文献报道疗效差异很大,一般用于治疗狂症,多数狂症病人经大泻大吐之后体力衰疲,可得暂时之安静,但一旦进食体力恢复后,躁动如故。治疗期间须严密观察病人,防止脱水、酸中毒、虚脱等严重并发症,应慎之使用。

第五节 养血安神法

祖国医学医书记载,治疗癫狂用补法颇多,特别是癫症,主张用安神定志、补虚养血、调中扶正、补益心脾……等法者,更为普遍。虞搏《医学正传》有“癫为心血不足”之说,李挺在谈到产后精神失常时也说:“此血虚神耗也”,都着重提出了因血虚而致精神失常,可用补法治之。

一、常用方剂

1. 加味归脾汤(《医学心悟》)

人参、茯苓、白术、甘草、当归、黄芪、枣仁、远志、木香、辰砂、琥珀末。

2. 七福饮(《景岳全书》)

人参、熟地、当归、杏仁、炒白术、炙甘草、远志。

3. 大补元煎(《景岳全书》)

人参、山茱萸、炒山药、杜仲、当归、枸杞、熟地、炙甘草。

4. 养心汤(《证治准绳》)

黄芪、茯苓、茯神、当归、川芎、炙甘草、半夏曲、柏子仁、酸枣仁、远志、五味子、人参、肉桂。

5. 定志小丸(《千金方》)

菖蒲、远志、茯苓、人参。

6. 养血安神汤(《经验方》)

当归、川芎、白芍、生地、酸枣仁、柏子仁、茯神、白术、黄连、甘草。

二、常用药物

精神科养血安神常用药有：当归、川芎、熟地、白芍、人参、黄芪、茯神、柏子仁、酸枣仁、山茱萸等。

三、适应范围

主要用于精神分裂症妄想型、青春型，以妄想幻觉、情绪不稳、行为紊乱为主要症状者，以及精神病的恢复期，证见病人气血不足、精神萎靡、失志不守、怔忡健忘、舌淡无华、脉虚细无力等气血两虚的病人，用之得当常可收效。

四、临床研究

近报道可用于神经症、老年性精神病、产后精神病及感染中毒等伴发的精神障碍见气血两虚的病人，疗效较佳，但这类方剂对于消除精神分裂症的基本症状无大帮助。

第六节 温阳振奋法

在祖国医学的记载中,较少以温热药治疗癫狂症,张景岳认为治癫狂痴呆有:“若无火邪,不得妄用凉药,……且复有阴盛阳衰,乃气血暴脱,而绝无痰火气逆等症,则凡四君、四物、八珍、十全大补等或干姜桂附之类皆所必用。”《石室秘录》有遂呆仙丹治呆病,痰势最盛,呆气最深者,而用附子等。近代对本法有较大发展,上海等采用大剂量壮阳振奋药物治疗情绪淡漠、呆滞退缩、孤独等阴性症状为主的精神分裂症,取得一定临床效果。

一、常用方剂

1. 温阳兴奋汤(《上海经验方》)

党参、熟地、淫羊藿、肉苁蓉、龟板、附片、黄芪、炙甘草、肉桂、干姜。

2. 地黄饮子(《医学六书》)

干地黄、巴戟、山茱萸、石斛、肉苁蓉、附子、五味子、肉桂、白茯苓、麦门冬、菖蒲、远志。

3. 洗心汤(《辨证录》)

人参、甘草、半夏、陈皮、菖蒲、附子、茯神、枣仁、神曲。

4. 归神汤(《辨证奇闻》)

人参、白术、巴戟天、茯神、紫河车、半夏、陈皮、白芥子、甘草、柏子仁、丹砂、菖蒲、麦冬。

5. 遂呆仙丹(《石室秘录》)

人参、白芥子、兔丝子、白术、茯神、半夏、附子、白薇、丹砂。

6. 温阳振奋汤(《经验方》)

附子、巴戟、肉桂、细辛、三棱、桃仁、甘草。

(4) 病程 3 个月以上。

2. 鉴别诊断

(1) 躁郁症：急性发病并表现为兴奋话多的精神分裂症青春型应与躁狂症鉴别，前者多为不协调性言语运动性兴奋，后者为协调性精神运动性兴奋。精神分裂症的紧张木僵应与抑郁性木僵鉴别，前者接触困难、表情呆板、情感淡漠，后者是严重抑郁之情感活动。

(2) 神经症：早期精神分裂症也有类似神经症症状，表现头痛、头昏、失眠、记忆减退、注意力不集中、工作能力下降等，但早期精神分裂症没有内省力、求医不迫切，多数拒绝就医，若出现思维怪异，言行荒谬等不可理解的症状时，神经症可排除。

(3) 反应性精神病：在强烈的精神创伤下发病，病人病情围绕起病的精神刺激、情感反应鲜明；精神因素消除，症状也相应减轻，预后良好。精神分裂症也可以在精神因素作用下发病，但症状内容与精神因素常没有必然联系，病程长、预后差，常反复发作。

(4) 症状性精神病：因感染、中毒、躯体疾患等引起精神障碍，也可以出现类似精神分裂症症状，幻觉、妄想明显，使诊断困难，但症状性精神病，有意识障碍和丰富鲜明的错觉，可以查到阳性病史、体征和化验等资料，鉴别诊断并不困难。

【临床治疗】

1. 辨证要点

(1) 精神分裂症症状表现多端，病情变化复杂，而且病人往往言不达意，答非所问，有些病人掩饰自己的内心体验，给临床辨证带来困难。为此首先要辨清属阳性病证或阴性病证；临床上将表现为兴奋躁动、幻听妄想、行为特异、思维障碍等

症状归属阳性病证；将情感平淡、反应迟钝、意志缺乏、思维贫乏等表现者归属阴性病证。尽管精神分裂症临床表现错综复杂，但抓住阳性病证与阴性病证两个重点，有利于临床辨证治疗。

(2) 精神分裂症的维持治疗以及对西药常见副作用的治疗是中医发挥较好作用的阶段，为此在精神分裂症病人急性症状得以控制后，在使用适量西药之同时，运用中西医结合的方法，充分发挥中医之所长，互相取长补短，用中医辨证论治调整机体并对抗西药副作用以提高与巩固治疗效果，从而减少西药维持量及毒副作用，降低复发率有着十分重要的临床意义。

2. 辨证论治

(1) 急性发作状态的临床治疗

① 阳性病证

主证：兴奋躁动、幻觉妄想、思维紊乱、行为怪异、形盛体实、面红目赤、大便干燥、舌红苔黄、脉弦或弦数有力。

辨证分析：素体阳盛、五志过极、重阳则狂、狂则六神无主、心神不宁故见兴奋躁动、幻觉妄想、思维紊乱、行为怪异等阳性症状；面红目赤、大便干燥、舌红苔黄、脉弦，均为阳气内盛之象。

治法：泻火、涤痰、活血祛瘀、重镇安神。

常用方剂：龙胆泻肝汤、涤痰汤、癫狂梦醒汤、生铁落饮。

方药分析：阳性癫狂，以痰火上扰，瘀血阻滞，心神被扰为常见之病机。龙胆泻肝汤为泻肝胆实火之主方，适用于肝胆实热，火热过甚以精神运动性兴奋为主要症状的精神分裂症。涤痰汤功善涤痰开窍，主要用于精神分裂症伴有舌苔白腻或黄腻，脉滑弦等有痰迷心窍、浊气蒙心者。癫狂梦醒汤以活血

自语、哭笑无常、善喜叹息、胸胁胀满、不思饮食、舌苔腻、脉弦滑。

辨证分析：思虑太过、所求不得、肝气被郁、脾失健运而生痰浊、气郁痰结、阻蔽神明故见表情淡漠、精神抑郁、多疑多虑、语无伦次、哭笑无常等种种精神异常的证候。肝气怫郁、肝经不畅故见善喜叹息、胸胁胀满；痰浊中阻、脾气不运故不思饮食。舌苔腻、脉弦滑均为痰气郁结之象。

治法：理气解郁、化痰开窍。

方药：顺气导痰汤合控涎丹加减。

陈皮 10g,半夏 10g,制胆星 10g,茯苓 15g,
香附 10g,菖蒲 15g,木香 7g。

控涎丹(甘遂、大戟、白芥子)2~3丸(吞)

水煎两次兑匀,分两次温服,送服控涎丹。

方药分析：顺气导痰汤降气化痰、解郁开窍,方中半夏、陈皮、胆星、茯苓利气化痰；香附、木香、菖蒲解郁开窍、宽中降气；合控涎丹攻逐痰涎,以除胸膈之痰浊,则肝气可行,痰浊得清故精神症状得以缓解。

加减：若胸膈膈闷,口多痰涎,脉象滑大有力,形体壮实者,可用三圣散,以瓜蒂、藜芦、防风取吐、劫夺痰涎,惟药性峻峻,自当慎用。若神思迷惘,表情呆钝,言语错乱,目睛不瞬,舌苔白腻为痰迷心窍,治宜豁痰宣窍,理气散结,可先予苏合香丸芳香开窍,继用四七汤加陈胆星、郁金、菖蒲、远志等,以化痰行气。若不寐易惊,躁烦不安,舌红苔黄,脉滑数为气郁化热,痰热交蒸,上扰心神,治宜清热化痰,可用温胆汤加黄连合白金丸,伴神昏志乱者,可用至宝丹以清心开窍。

② 痰火上扰证

主证：性情急躁、毁物伤人、口出秽语、两目怒视、面红目

淡、脉细无力均为心脾两虚、气血俱衰之象。

治法：健脾养心、益气安神。

方药：归脾汤。

炙黄芪 30g, 党参 12g, 当归 12g, 白术 12g,
茯神 30g, 龙眼肉 30g, 酸枣仁 30g, 木香 10g,
远志 6g, 炙甘草 6g, 大枣 6 枚, 生姜 6g。

水煎服两次兑匀, 分早晚两次温服, 每日一剂。

方药分析：方中人参、黄芪甘温益气、大补脾气；白术苦温，健脾燥湿；茯神健脾安神；炙甘草甘温，调中益气健脾；龙眼肉甘温，益心脾、补血以安神、益智宁心；当归伍黄芪益气生血；木香辛温，行气散滞，以解滞气而理气醒脾；远志安神益智而解郁；枣仁宁心安神；姜枣和胃健脾，调和营卫以资生化。诸药合用，即能健脾益气，又能补血养心，而心神自安。

加减：若神思恍惚，善悲欲哭，惊恐不安，心神不宁，可用养心汤以健脾益气，养心安神。若神思迷乱，痴呆不语，年迈体弱，或经久不愈者，治宜温肾健脾，可用济生肾气丸加仙灵脾、菖蒲、郁金等。

④ 阴虚火旺证

主证：狂病日久其势渐激，且有疲惫之象，多言善惊、情绪焦虑、紧张时烦、形疲面红、五心烦热、口干不欲饮、舌质红、少苔或无苔、脉细数。

辨证分析：狂久不已、耗气伤阴、气不足则狂热渐激、精神疲惫；阴不足则不能制心火，虚火上扰、心神失养故见多言善惊、情绪焦虑、紧张时烦等症状。形疲面红、五心烦热、口干不欲饮、舌质红、少苔、脉细数皆为阴虚火旺之象。

治法：滋阴降火、安神定志。

方药：二阴煎。

生地 30g, 麦冬 12g, 玄参 12g, 茯苓 12g,
酸枣仁 20g, 黄连 10g, 木通 8g, 竹叶 12g,
灯心 3g, 甘草 3g。

水煎服两次兑匀, 分两次温服, 每日一剂。

方药分析: 方中生地、麦冬滋肾阴降心火为主药, 玄参滋阴, 黄连清心火, 酸枣仁滋阴养心安神, 共为辅药。茯苓淡渗, 木通清利, 竹叶清心, 使心经邪热从小便而去; 灯心入心, 甘草调药和中, 是为佐使。合而用之, 则心经热邪得去、肾阴得补、心肾相交、水火既济, 诸症自除。

加减: 若大便干燥者加火麻仁、郁李仁、桃仁以润肠通便。若口干纳呆, 不思饮食宜加焦三仙以消食导滞。若精神不振, 懒散少动宜加太子参、炙黄芪、升麻以益气提神。

⑤ 气滞血瘀证

主证: 情绪不稳、时躁时静、自语神呆、猜疑妄想、幻听幻觉、面色晦滞、头痛如刺、舌暗红有斑点或瘀斑, 或舌下脉络瘀阻、脉弦涩。

辨证分析: 癲病日久, 缠绵不已、气滞血瘀、瘀血内阻、心神失宁故见情绪不稳、时躁时静、猜疑妄想、幻听幻觉等症; 面色晦滞、头痛如刺、舌暗红、有瘀斑、脉弦涩均有瘀血内阻之象。

治法: 理气解郁、活血化瘀。

方药: 血府逐瘀汤。

桃仁 12g, 红花 10g, 当归 10g, 生地 10g,
川芎 6g, 赤芍 6g, 桔梗 5g, 川牛膝 10g, 柴胡 3g,
枳壳 6g, 甘草 3g。

水煎两次兑匀, 分两次早晚温服。

方药分析: 方中以当归、桃仁、红花活血祛瘀为主药, 川

芎、赤芍助主药以活血祛瘀为辅药；生地配当归养血活血，使瘀祛而阴血不伤，川牛膝祛瘀而通血脉；柴胡、桔梗、枳壳疏肝、理气、宽胸以解除气滞之苦，气行则血行，共为佐使药。诸药配合活血祛瘀、气行血行则诸症自愈。

癫狂日久，病情反复发作，常伴有气滞血瘀之象，故在临床辨证中适当运用活血化瘀之品常可获显著疗效。

加减：若兼见口苦咽干，小便短赤、内有蕴热者宜加木通、黄芩以清热泻火。若兴奋不安，躁动不宁宜加丹皮、生地以清血中伏火。若夜眠不安，郁闷不舒者宜加合欢皮、夜交藤、忘忧草以解郁安神。若少语少动，面色无华，倦怠疲困者宜加黄芪、当归以益气补血。

3. 经验方药

(1) 静安胶囊(制剂)本方由银杏叶、桃叶、三棱、赤芍、大黄、冰片、地龙干等药物组成，经水煎、浓缩、提炼、干燥成粉末状，装于胶囊，每粒胶囊 1.5g，每次服 5 粒，每日 3 次，3 个月为一疗程，具有活血化瘀、安神通窍之功效，临床上主要用于阳性症状伴有瘀血之精神分裂症患者以及本病后期维持巩固治疗。

(2) 振奋口服液(制剂)：附片、巴戟、肉桂、细辛、三棱、桃叶、甘草等药物组成，经煎煮浓缩成溶液剂，每次 30～50ml，每日 3 次。本方具有振奋气阳、活血化瘀、提升精神患者的生活品质之功效。适用于阴性症状明显以及慢性衰退型精神患者。

(3) 清开灵注射液治疗组：清开灵注射液 60～80ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中，静脉滴注每日一次，15 日为一疗程，适用于兴奋躁动、思维紊乱、幻觉妄想、行为怪异等阳性症状明显、急性或亚急性发作的精神病患者。

(4) 蝮蛇抗栓酶治疗组：蝮蛇抗栓酶 1u 加入 5% 葡萄糖液 250ml 中，静脉滴注，每日一次，每逢周日休息，24 次（4 周）为一疗程。适用于情感淡漠、思维贫乏、意志缺乏、注意力不集中等阴性症状明显、慢性或迁延性发作的精神病人。注意事项：使用蝮蛇抗栓酶前应做皮试，阴性者方可使用，使用过程中应每周查一次血常规及出凝血时间，有条件可用血液流变仪进行检测，有出血倾向的禁止使用。

(5) 参附注射液治疗组：参附注射液 10~20ml 加入 10% 葡萄糖液 250ml 中，静脉滴注，每日一次，周日休息，24 次为一疗程。适用于阴性症状明显，慢性退缩的精神病患者。

4. 常见抗精神分裂症药物副作用的中医治疗

临床资料表明，长期服抗精神分裂症药物的患者，其椎体外系副作用发生率可达 38.9%，震颤麻痹综合征可达 14%，其他如静坐不能、心肌损害、便秘、失眠、流涎以及迟发性运动障碍、恶性综合征等。在临床极为多见，此种症状之产生，绝大多数与精神药物之用量较大有关，由于药物的毒副作用，使病人对服用西药产生恐惧心理，而自动减轻药量或停药，直接影响了疗效的巩固，而导致病情复发。为此在精神分裂症患者急性症状已得到控制，合作情况良好的住院后期或出院后，在使用适量西药之同时，再运用中西医结合方法，充分发挥中医之所长，互相取长补短，用中药调整机体，并对抗西药副作用，以提高与巩固治疗效果，从而减少西药维持量及毒副作用，直至降低复发率，有着重要的临床意义。

(1) 椎外系副作用：表现为齿轮样肌张力增高、碎步、动作缓慢、面具脸、震颤等类帕金森病，或见扭转性痉挛、角弓反张、斜颈及下颌假脱臼等急性肌张力障碍，或表现为焦虑、坐立不安、来回踱步、不能停坐等，治疗方用白芍 30g、赤芍 30g、

僵蚕 15g、酒大黄 15g、葛根 30g、甘草 10g，水煎服，每日一剂，或按比例制成浓缩液，30 天为一疗程。

(2) 药源性恶性综合征：多见于高效价抗精神分裂症药物大剂量治疗时，或骤然减停药物时，表现为紧张性木僵、高热(可达 $41\sim 42^{\circ}\text{C}$)、意识障碍以及大汗淋漓、口涎、心律加速、呼吸血压不稳等自主神经系统症状。临床处理：

意识障碍：牛黄醒脑静 20ml 加入 10%葡萄糖液 500 毫升中，静脉滴注，每天 1~2 次。

高热不退：清开灵注射液 80ml 加入 5%葡萄糖液 500ml 中，静脉滴注，每日一次。

自主神经系统功能紊乱等症状者：生脉注射液 20~30ml，或参附注射液 20ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中，静脉滴注。

(3) 粒细胞减少和粒细胞缺乏：白细胞总数低于 $4\times 10^6/\text{L}$ 为白细胞减少，白细胞总数低于 $2\times 10^6/\text{L}$ 、中性粒细胞低于 $1\times 10^6/\text{L}$ 为粒细胞缺乏。常用升白汤：炙黄芪 60g、当归 15g、黄精 30g、升麻 10g、大枣 15g，水煎服，每日一剂，或按比例制成浓缩液。

(4) 迟发性运动障碍：是指在长期应用抗精神分裂症药物的情况下发生的一种锥体外系的症状，临床表现为不自主的、有节律的刻板式运动，紧张时加重，睡眠时消失，口—舌—颊三联征，肌张力降低，全身躯干肌肉不协调等，应缓慢减药或停药，停用抗胆碱能药物，同时使用蝮蛇抗栓酶 1u，加入生理盐水 500ml 中静脉滴注，每日一次，30 次为一疗程，可重复 3~4 疗程，每次疗程结束后休息一周。或静脉滴注一疗程后，改用蝮蛇抗栓酶 0.5u，加入生理盐水 5ml 中稀释，深部肌肉注射，每日一次，30 次为一疗程，如此交替用药，治疗前、中、

后进行血液学检查,如出凝血时间、血小板、凝血酶原时间、纤维蛋白原等,出血患者禁止使用。

【其他疗法】

1. 针灸治疗

(1) 体针疗法:取穴以任督二脉,心及心包经为主,心主血脉,其配穴总以清心醒脑,活血安神为原则,其手法多采用3个或5个医师同时进针的方法。对阳证型多用泻法,大幅度捻法,进行强刺激;对阴证型可用平补平泻的手法。

阳证型主方:

中脘、神门、三阴交。

心俞、肝俞、脾俞、丰隆。

两组可以交替使用。

阴证型主方:

人中、少商、隐白、大陵、丰隆。

风府、大椎、身柱。

鸠尾、上脘、中脘、丰隆。

人中、风府、劳宫、大陵。

每次取穴一组,四组穴位可以轮换使用。阳性症状明显,可独取两侧环跳穴,用四寸粗针,行强刺激,可起安神作用。

(2) 电针:在常用治疗精神疾病的穴位上,通以适当的脉冲电流,往往会提高疗效,尤其对控制兴奋,稳定情绪及消除幻觉等有效,对焦虑状态及改善睡眠也有效果。北医三院精神科曾用电风岩及电百印治疗精神分裂症。

① 电风岩治疗:风岩穴在耳垂下缘与哑门穴联线上,位于内九分之五与外九分之四分交界处。治疗时取双侧风岩穴,配双侧合谷穴。风岩穴用二寸半针(26~28号)向对侧眼球方向刺入一寸半至二寸(向上向内方向,刺入至针尖抵颅骨为

止);合谷穴用一寸针,一般深度即可。

治疗方法:用 G6805 型电麻仪,每一个插头的两条导线分别连在同侧风岩穴与合谷穴。电量 1.0~2.0 刻度,穴位局部可见抖动,头部轻微摇动。病人无严重不适为限,电流频率以每分钟 60~80 次闪光为宜,通电时间开始为 15min,后可增至 1h,每日治疗一次,12 次为一疗程,疗程之间休息 3~5 日。

② 电百印治疗:即在百会和印堂同时通电,简称“电百印”。据初步观察对精神分裂症的兴奋状态,幻觉妄想及焦虑忧郁状态等有一定疗效。

治疗方法:百会穴沿头皮下向前方进针一寸许,印堂穴沿头皮下向上方进针一寸许。治疗机用 G6805 型电麻仪,电量为 1.0~2.0 刻度,电压一般为 5~6V,电流强度一般是 3~4mA,频率为每分钟 180 次闪光(开至 5 刻度)治疗时缓慢增加电量。当患者自觉穴位局部有麻胀舒适感为限,一般局部可见轻微肌肉抽动,每日治疗一次,30 次为一疗程。

(3) 耳针治疗:选穴与治疗方法:穴位取耳部神门、心、幻听(耳孔后缘中点)、脑干、额、顶等。每次进针一侧穴位,双侧轮替,留针 2~3h,每日针刺一次,每周进行 6 次,12 次为一疗程。疗程之间休息 5~7 日,操作时要特别注意严密消毒,以防感染引起耳软骨炎。据报道对幻觉特别是幻听疗效较好。

(4) 激光治疗

① 氦氖激光穴位照射:应用广泛,凡是针灸适应证,几乎都可以以相同穴位进行照射。一般应用最大功率 30mV,常用治疗:幻听、失眠、妄想、情感淡漠。取穴:哑门、大椎、听宫、听会、耳门、神庭、太阳。每次取 1~2 穴位,每次照射 10min,

30次为一疗程。在治疗过程中未发现副作用,但国内外均报道激光对眼睛有影响,故操作时需戴防护镜。

② 激光血管内照射:采用 DX-280-IB 氦氖激光多功能治疗仪,经静脉留置针穿刺,将激光针导入上肢肘正中静脉或贵要静脉内照射,激光波长 632.8nm,末端输出功率 1.2~2.0mV。每次照射时间:下腕静脉内 45min,外周静脉内 60min,每日或隔日照射 1 次,6~8 次为 1 疗程。据报道激光血管内照射疗法,对于精神分裂症偏执型有一定治疗效果,尤其是在消除幻觉症状,比普通抗精神病药物速度快,对慢性精神分裂症可以改善部分精神症状。

本疗法操作简便,无副作用,安全可靠,易被患者接受,值得推广。

2. 单方验方

(1) 黑水牛角,锉为粗粉,捣碎,过 7 号筛,加入适量白砂糖备用,开始服 2~3g/次,每日 3 次,胃肠适应后,每日可增加 5~10g,10 日左右,应加量至每日 60g,这样疗效较可靠,30 日为一疗程,治疗 3 个月,对思维感知分析结合能力的疗效较满意,对精神运动性兴奋也有一定抑制作用。

(2) 丹参 60g、夜交藤 20g、灵芝 10g、大枣 10g,制成浓煎剂 100ml,分 3 次口服,适用精神分裂症缓解期伴失眠、疲乏、紧张焦虑等症。

(3) 酒大黄 30~60g、活地龙 50~70 条、韭菜汁 100ml,加水适量,先将地龙洗后切断,于瓦罐中文火熬 1~2h,取汁约 350ml,冲入大黄中浸 2h,其后煎片刻去渣,待放温后兑入韭菜汁中,分 2~3 次服,每日 1 剂。本方具有清心泻火、平肝止痉、涤痰开窍之功,适用于实热痰火、上扰心窍之精神分裂症。

【预防与护理】

由于本证为素体阴阳偏颇,或气血禀赋不足,加之七情过极的影响所致,故平素慎起居,调饮食,补其不足,伐其有余,令气血冲和,阴阳平衡则不易发病。同时应避免七情过极,在药物治疗的同时,还应积极进行心理治疗。在护理方面,首先应正确对待患者,要关心、爱护患者。急性期主要是作好患者的安全护理。近年来精神科临床医护工作者观察到精神分裂症患者的自杀或伤人最难预防,因此,无论对住院患者或门诊患者均应提高预防患者自杀与伤人的警惕性。据有关资料统计,50%的精神分裂症患者有自杀企图,10%自杀身亡,值得注意的是当患者恢复自知力后,自杀的可能性更大。慢性期主要是作好患者的心理护理工作及家庭康复护理工作。

【现代研究】

周康(1988):用活血化瘀中药莪术、赤芍、大黄,按照10:3:3的比例加工提炼成达营片(每片相当于生药8g),口服每次6~8片,每日3次,30日为一疗程。治疗精神分裂症血瘀证患者,发现该药对“兴奋躁动,阳狂有余”的精神症状有较好疗效。

黄跃东(1996):采用大剂量清开灵治疗精神分裂症,随机抽样分组,清开灵组30例,对照组25例。治疗方法:常规使用小剂量抗精神病药物同量折合氯丙嗪效价 $\leq 400\text{mg}$ 。清开灵组采用清开灵注射液80ml稀释于10%葡萄糖液500ml中,静脉滴注,每日一次,4周为一疗程。对照组:每日输入10%葡萄糖液500ml。结果表明:①清开灵组对精神分裂症的临床症状的改善程度明显优于对照组,BPRS因子分析在治疗4周即明显下降($P < 0.05$),面对照组在治疗4周后仅运动过多一项有明显下降外,其他各因子无明显改善。②清开

灵对精神分裂症的阳性症状显效率 $> 80\%$, 而阴性症状疗效明显降低 ($P < 0.05$)。③经血液流变学检测, 清开灵有改变血粘度和红细胞变形的作用, 具有活血化瘀的功效。

李禄斌(1990): 自拟精复康 1 号治疗精神分裂症, 用生石膏 180g、柴胡 25g、生大黄(后下) 50g、栀子 15g、生铁落 60g、夜交藤 60g、青皮 25g、芒硝(冲服) 40g、青礞石 50g, 水煎服, 日 1 剂, 每剂加水连煎 3 次, 将 3 次煎液混和, 分 3 次服完。热盛者加黄连 10g、败酱草 30g; 痰湿者去芒硝、栀子, 加天竺黄 10g、石菖蒲 6g、法半夏 15g。临床观察 50 例, 近期疗效: 显效 45 例, 占 90%; 好转 4 例, 占 8%; 无效 1 例, 占 2%; 总有效率 98%。远期疗效: 连续随访 5 年, 复发者共 14 例, 复发率为 28.6%。

张良栋等(1994): 对 57 例精神分裂症按中西医结合学会精神疾病专业委员会修订的精神分裂症中西结合辨证分型标准加以分型, 其中痰火内扰型 11 例, 痰湿内阻型 15 例, 阴虚火旺型 16 例, 阳虚亏损型 13 例, 并作临床实验室检查的对照研究。结果显示: 病人组血浆 β -内啡肽含量低于正常人, 神经降压素含量高于正常人, 在血浆 β -内啡肽含量变化中, 痰火内扰型和阴虚火旺型高于痰湿内阻型和阳虚亏损型, 认为 β -EP 或 D_1 -8 均广泛分布于边缘系统、下丘脑、海马和杏仁核, 与人的情感、思维、记忆和意识活动有关, 它们的失调可能导致精神异常, 值得进一步研究。

张继志等(1993): 对 66 例精神分裂症患者进行了临床与实验室的观察, 从精神症状、中医四诊和血液流变学等方面初步提出了精神分裂症血瘀症的临床与实验室指征, 以活血化瘀的血府逐瘀汤为主(柴胡 15g、红花 10g、赤芍 30g、川芎 15g、丹参 30g、降香 15g)的中西医结合治疗能使精神症状缓

望和自伤自杀,给社会和家庭造成较大的危害,为此越来越引起医学界的广泛重视。

本病病因未明,近年来在遗传研究方面取得可喜进展,国内资料表明,本病患者有精神病家族史者可高达 30%~41.8%,较精神分裂症高。国外调查资料,本病患者的一级亲属中患同病概率:同胞为 12.3%、父母为 7.4%、子女为 9.4%,比一般人群高 30 倍左右,血缘关系越近,发病概率越高,证明本病有明显的遗传倾向。

祖国医学对躁狂症早有认识,历代医籍中均有不少精辟的论述,但都散见于内科杂病诸门内,并多将癫、狂、痫三者混淆并述,缺乏系统的临床分类,与其他主要临床各科相比显得较为薄弱。躁郁症分散见于狂症、烦躁、郁症、失志等范畴。《黄帝内经》设“癫狂篇”对本病作专题讨论,如《灵枢·癫狂篇》就十分生动地描述了“狂始生,先自悲也,喜忘苦怒,善恐者,得之忧饥……;狂始发,少卧不饥,自高贤也,自辨智也,自尊贵也,善骂詈,日夜不休”这一躁狂抑郁发作的临床特征。

本症多因大惊大恐、七情过激、五志化火、火盛痰壅、气血逆乱、扰乱神明。或图谋不遂,忧思郁结、屈抑无所伸、急怒无所泄、气郁血滞、蒙蔽心神所致。临诊时应根据疾病是处在兴奋状态,还是抑郁状态,进行辨证论治。

【临床表现】

1. 躁狂状态

躁狂状态的临床表现可概括为情感高涨、思维奔逸和活动增多三方面,起病可急可缓,以急性起病较多。

(1) 情感高涨:患者表现愉快、乐观、持久的喜悦,自我感觉极为良好,患者沉醉在喜乐和情趣之中,生动而高涨的情感与患者的内心体验相一致。故具有感染性,常博得周围人的

共鸣,这是躁狂症的一个具有特征性的症状。有的患者情绪不稳,易激惹可因细故而暴跳如雷,怒不可遏,甚至伤人,毁物,但往往较快转怒为喜,若无其事,悠然自得。

(2) 思维奔逸:患者思维联想明显加速,内容丰富多变,表现为口若悬河、滔滔不绝、常旁征博引、高谈阔论,别人无插话余地,有时患者自觉脑子特别灵活,写信、作文往往下笔千言,一挥而就,但内涵浮浅。有时患者往往过多评价自己,表现高傲自大、自命不凡、盛气凌人,严重时可达夸大妄想程度。

(3) 活动增多:患者整日忙碌不停,多管闲事,不知疲劳,但往往做事有头无尾,缺乏成效,对睡眠的要求很少,但精力异常充沛;患者食欲亢进,性欲增强,挥金如土,喜欢近异性,如打架、恋色情,失去正常的社会控制能力。重度的躁狂兴奋,患者的活动增多可达到狂暴程度。

2. 抑郁状态

本症主要特点是情绪低落、思维缓慢以及活动减少、迟缓三个方面,起病大多缓慢,起病前可有失眠、乏力、食欲不振、工作能力下降、经期紊乱和各种内感性不适。由精神因素或躯体因素诱发起病者,发病可较急。

(1) 情绪低落:以情绪低落,抑郁悲观最为突出。患者终日忧心忡忡,唉声叹气,兴趣索然,即使听到愉快的消息,亦不能减轻患者的抑郁、悲伤情绪,对工作、学习、家庭、生活丧失信心。常有自责自罪观念,对微不足道的小事加以夸大,罗列种种罪名,严重时出现消极观念,自杀企图。抑郁情绪常在早上加重,下午或晚间减轻。

(2) 思维缓慢:患者自觉脑子迟钝,思路闭塞,缺少主动言语,回答问题反应迟慢,低声细语,内容简短,或仅轻启嘴唇而不发声。如写信、作文半天也写不出什么内容。

临床相虽有兴奋躁动,但情感不是轻松、愉快,而是喜怒无常,行为也多具冲动性。临床上确有一些躁抑症患者具有与心境不协调的精神病性特征,但历时短暂。

② 中毒性精神病:某些药物如皮质激素,异烟肼、阿的平等中毒可引起躁狂状态,根据用药史、用药时间、剂量与发病关系、停药或减药后渐趋好转可资鉴别,中毒性精神病往往伴有不同程度的意识障碍。

③ 脑器质性精神病:如麻痹性痴呆、老年性精神病可出现躁狂状态,但往往有智能障碍,情感并非高涨,而是以欣快为主。详细的病史、躯体和神经系统检查有助鉴别。

④ 躯体疾病所致的精神障碍:甲状腺功能亢进可出现轻躁狂状态,但情感并非真正高涨,而以焦虑,情绪不稳为主,伴有原发躯体病症状和体征。

(2) 抑郁症的鉴别诊断

① 抑郁性神经症或心境恶劣障碍:是以持久(至少2年)的轻度至中度抑郁为特征的神经症。病人兴趣减退,但未丧失;对前途悲观失望,但不绝望;自我评价下降,但愿接受鼓励和赞扬;自觉病情严重,但又主动求医。常伴有显著焦虑,躯体不适或疼痛和睡眠障碍,症状波动性大,生活能力不受严重影响,病前往往有明显心理社会应激因素和素质因素。

② 心因性(反应性)抑郁症:鉴别要点为起病和精神症状与心理社会因素密切相关。临床症状充分反映心因内容,情绪波动性大,易受外界环境影响,失眠多为入睡困难,情绪反应多为怨天尤人。

③ 精神分裂症:精神分裂症可伴有抑郁症状,但其情感反应以对周围淡漠为主,缺乏抑郁内心体验,妄想内容也比较荒谬。

④ 癫痫性病理心境恶劣：心境恶劣的起始、终止均较急剧，持续时间一般也较短，缺乏典型的情感低落和运动性抑郁症状，而以紧张恐惧为主。

【临床治疗】

1. 辨证要点

(1) 躁狂状态应辨明虚实：躁狂急性发作，兴奋冲动、躁扰不宁、情绪高涨、舌红苔黄腻脉弦滑数有力，病机以邪气盛，阳气实，痰、火二邪内扰，神明失控为主。此时治疗重点在化痰泻火。若狂久不已，或反复发作，则其势渐敛、邪热伤阴、阴伤及血，或气机失调、气郁日久、气病及血、瘀血留滞，而见情绪焦躁、辗转不安、行为怪异、多言不眠、形瘦面赤、舌红或暗紫、脉弦细数，或弦涩等气滞血瘀、阻滞脑窍之症。临床上不应因表现为兴奋躁动，而皆以实证论治，要参照病程之长短、体质之强弱、病程之变化、舌脉之虚实，进行辨证论治。躁狂状态的瘀血型多发于疾病的后期，或反复发作的病人，应详于审察。

(2) 抑郁状态要辨明病因病机与脏腑的关系：郁症的主要病机为肝失疏泄、脾失健运、心失所养，虽然肝、脾、心三个脏腑皆有相关，但各有所侧重。肝气郁结多与气、血、火相关，而食、湿、痰主要关系于脾，心则多表现为虚证，如心神失养、心血不足、心阴亏虚等，也有一些属于正虚邪实，虚实夹杂的证候。郁症初病在气，久病及血，故气滞血瘀的证候在临床上十分多见，抑郁症日久不愈，往往损及脾、肾，造成阳气不振、精神衰退的证候。

2. 辨证论治

(1) 躁狂状态

① 肝郁血热证

主证：情绪高涨、急躁易怒、思维奔逸、好管闲事、两胁胀

痛、失眠多梦、口苦口干、舌绛少苔、脉弦数。

辨证分析：素体阳盛、性情急躁，又因悲愤恼怒、肝气郁滞、阳气暴张、血热内扰、神明失控，故见情绪高涨、急躁易怒、思维奔逸、好管闲事等精神运动性兴奋症状；肝经郁滞、气郁不宣，故见两胁胀痛；血热内扰、心神不安故失眠多梦；口苦口干、舌绛少苔、脉弦数均为肝郁血热之象。

治法：疏肝泻热、解郁安神。

方药：柴胡清肝饮。

柴胡 10g，栀子 10g，丹皮 15g，青皮 5g，

苏梗 10g，白芍 10g，钩藤 15g(后入)。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：方中柴胡疏肝解郁；栀子苦寒清三焦之热；丹皮凉血清血中伏火，共为主药。青皮、苏梗理气和中；白芍养阴柔肝、缓肝之急；钩藤入肝经、平肝安神。诸药合用，具有清肝泻火、解郁安神之功。

加减：形体壮实、躁扰不宁、脉弦劲有力者宜加生铁落、礞石、磁石以重镇安神、抑制狂越之势；若口苦口干、心烦不宁、大便秘结、性欲亢进，乃心火亢盛之象，宜加黄连、黄芩、大黄、莲子芯直折亢盛之心火。

② 肝郁痰火证

主证：性情急躁、行为冲动、口若悬河、胡言乱语、两胁胀痛、失眠多梦、眩晕头痛、口吐黄痰、舌红苔黄腻、脉弦滑数。

辨证分析：平日痰火素盛、性情急躁、阳气偏亢，又因情志不遂、肝气郁滞、阳气暴涨、鼓动痰火二邪内扰神明，故见行为冲动、胡言乱语、口若悬河等精神失控之症状；肝经郁滞、痰火上扰清窍故见两胁胀痛、失眠多梦、眩晕头痛；口吐黄痰、舌红苔黄腻、脉弦数滑均为痰火内蕴、肝气郁滞之征。

治法：疏肝解郁、化痰泻火。

方药：清气化痰汤合滚痰丸。

陈皮 10g,杏仁 10g,枳实 10g,黄芩 15g,
瓜蒌 15g,茯苓 15g,胆南星 15g,制半夏 12g,
滚痰丸 9g。

水煎两次兑匀,分两次送滚痰丸 9 克,早晚温服。

方药分析：方中胆南星清热化痰为主药,辅以黄芩、瓜蒌清热化痰,以助胆南星之力;陈皮、枳实疏肝解郁、理气化痰,共为辅药。脾为生痰之源,肺为贮痰之器,故以茯苓健脾渗湿;杏仁润肠止咳;半夏燥湿化痰为佐使药;因精神失控、痰火内盛,故加滚痰丸,以增加降火逐痰之力。

加减：若行为冲动,狂越莫能自制,宜加生铁落、磁石、代赭石以重镇安神;如大便秘结、小便黄赤,加大黄、芒硝以通腑泻热;如头晕头痛加菊花、钩藤、白蒺藜以平肝止痉。

③ 气滞血瘀证

主证：情绪不稳、病情反复、时而冲动奔走、时而呆若木鸡、口出狂言、喜怒无常、胸部满闷、头痛如刺、目赤而巩膜脉络怒张、舌质暗紫或有瘀斑、舌下静脉郁血、脉弦涩。

辨证分析：狂症日久、反复无常、气滞血瘀,“气血凝滞脑气,与脏腑气不接,如同作梦一样”故见情绪不稳,时而冲动狂越,时而呆若木鸡、口出狂言、喜怒无常等症。瘀血阻滞、清阳不展、脉络不通故见胸部苦满、头如刺;目赤、巩膜脉络怒张、舌质暗紫或有瘀斑、舌下静脉郁血、脉弦涩均为瘀血内阻之象。

治法：活血化瘀、理气解郁。

方药：癫狂梦醒汤。

桃仁 24g,柴胡 10g,赤芍 20g,木通 10g,
大腹皮 10g,陈皮 10g,桑白皮 10g,香附 6g,

阴以清虚火、养心而安心神之功，宜于久狂阴伤、虚火内扰之证。

加减：若心悸不宁，多言善惊，焦虑不安者宜加千金定志丸，以安神定志。若心烦胸闷，时躁时郁，善喜叹息者宜加柴胡、杭白芍、旋复花以疏肝解郁。若心烦不寐，多恐善惊，日久不已宜加丹参、琥珀以活血安神。

（2）抑郁状态

① 肝气郁结证

主证：情绪低落、多愁善虑、悲观失望、活动减少、反应迟钝、胁胀作痛、腹胀纳少、便溏不爽、舌淡脉弦缓。

辨证分析：肝主疏泄、性喜条达、肝气怫郁、气结不展、疏泄失常故见情绪低落、多愁善虑、悲观失望、反应迟钝等症。肝气郁滞、经脉气机不畅故见胁胀作痛、肝气横逆，乘脾犯胃则见腹胀食少、便溏不爽；舌淡脉弦缓为肝胃不和之象。

治法：疏肝解郁、理气畅中。

方药：柴胡疏肝汤。

柴胡 10g，香附 10g，枳壳 10g，陈皮 7g，

川芎 5g，芍药 10g，炙甘草 6g。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：本方由四逆散加川芎、香附、陈皮而成，方中柴胡、香附、枳壳、陈皮疏肝解郁、理气畅中；川芎、芍药、甘草活血定痛、柔肝缓急。

加减：若气郁较甚，可加郁金、青皮以助解郁之功；五郁为病，先起于肝气郁结，在服汤药的同时，可常服越鞠丸，以行气解郁。若悲观欲绝、神识混朦宜配合苏合香丸温通开窍、化浊醒脑。

② 肝血瘀滞证

主证：情绪抑郁、有自杀观念或行为、心情烦躁、思维联想缓慢、运动迟缓、面色晦暗、两胁作痛、妇女闭经、舌质紫暗瘀点、脉弦涩。

辨证分析：谋虑不遂、忧思气结、气郁日久、血行不畅，而致气滞血瘀。肝气郁结、瘀血阻滞、疏泄失司、精神不振故见情绪抑郁、有自杀观念或行为、心情烦躁、思维联想缓慢、运动迟缓等症；面色晦暗、两胁作痛、妇女闭经、舌质紫暗瘀点、脉弦涩皆为气滞血瘀之征象。

治法：活血化瘀、理气解郁。

方药：血府逐瘀汤。

桃仁 12g,红花 10g,当归 10g,生地 10g,
川芎 6g,赤芍 6g,桔梗 5g,川牛膝 10g,柴胡 3g,
枳壳 6g,甘草 3g。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：本方以桃仁、四物汤合四逆散加桔梗、川牛膝组成，方中以当归、桃仁、红花活血祛瘀为主药；川芎、赤芍助主药以活血祛瘀为辅药；生地配当归养血活血，使瘀祛而阴血不伤；川牛膝祛瘀面通血脉；柴胡、桔梗、枳壳疏肝理气宽胸以解除气滞之苦，气行则血行；甘草调和诸药为使。诸药配合，血活气行则诸证自愈。

加减：若气郁重，有自杀行为，加桃花、郁金、石菖蒲以逐瘀开窍醒脑；瘀血甚，加降香、炮山甲、苏木。

③ 心脾两虚证

主证：情绪抑郁、兴趣缺乏、自罪自责、活动减少、多思多虑、心虚胆怯、失眠健忘、疲乏困倦、面色无华、食少便溏、舌质淡、苔白、脉细弱。

辨证分析：劳心思虑、久则损伤心脾、脾虚则运化失常、

气血生化不足、心失所养、心神无主则见情绪抑郁、兴趣缺乏、自罪自责、多思多虑、心虚胆怯等证；脾失健运、气血不充故见疲乏困倦、面色无华、食少便溏等证，舌质淡苔白、脉细弱均为气血不足之象。

治法：健脾养心、益气补血。

方药：归脾汤。

党参 15g，炙黄芪 15g，当归 5g，炒白术 10g，
茯苓 10g，炙甘草 6g，龙眼肉 15g，炒枣仁 15g，
远志 10g，木香 5g，生姜 6g，大枣 3 枚。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：方中人参、黄芪甘温益气，大补脾气；白术苦温、健脾燥湿；茯苓淡渗健脾；炙甘草甘温，调中益气健脾，脾胃得养，生化旺盛，心血充足，其神自安；龙眼肉甘温益心脾、补气血以安神、益智宁心；当归伍黄芪，益气生血；木香辛温、行气散滞以解滞气而理气醒脾；远志安神益智而解郁；枣仁宁心安神；姜枣、炙甘草和胃健脾、调和营卫以资生化、气旺血自生、心血充而心神自安。

加减：抑郁甚、夜寐不佳可加郁金、枳壳、合欢花以开郁安神。若食少懒言宜加砂仁、陈皮以理气消食。

④ 脾肾阳虚证

主证：精神萎靡、情绪低沉、嗜卧少动、意志消沉、悲观厌世、性欲减退、男子阳痿遗精、女子带下清稀、面色㿔白、四肢不温、舌质胖淡、或有齿痕、苔白、脉沉细。

辨证分析：久郁不解、损及脾肾、脾肾两虚、阳气不振，故见精神萎靡、情绪低沉、嗜卧少动、意志消沉、悲观厌世、性欲减退等一派精神衰退之症状。面色㿔白、四肢不温、舌质胖淡、苔白脉沉细为脾肾阳虚之象。

治法：健脾益气、温补肾阳。

方药：温阳兴奋汤。

党参 15g,熟地 15g,淫羊藿 5g,肉苁蓉 15g,
龟板 15g,附片 10g,黄芪 10g,炙甘草 10g,
肉桂 6g,干姜 6g。

水煎两次兑匀,分两次早晚温服。

方药分析：方中党参、黄芪、炙甘草健脾益气,以资生化之源;淫羊藿、肉苁蓉补肾壮阳;龟板、熟地滋肾填精、阴中求阳;附子、干姜、肉桂温阳兴奋、振奋阳气。诸药合用,共有健脾益气、振奋阳气之效。

加减：若精神不振,嗜卧少动,气短懒言,纳少便溏者宜加炒白术、升麻、陈皮、炒麦芽以健脾益气。若抑郁不乐,意志消沉者宜加柴胡、远志、郁金、枳壳以疏肝解郁。若思维缓慢,行为迟缓,小便余沥不尽者宜加菟丝子、益智仁、乌药、石菖蒲以补肾开窍。

3. 经验方药

(1) 镇狂汤(经验方)：黄连 10g、黄芩 15g、酒大黄 30g、礞石 30g(先煎)、生铁落 30g(先煎)、龙骨 30g(先煎)、磁石 30g(先煎)、牡蛎 30g(先煎)、神曲 10g、菖蒲 6g,水煎两次兑匀,分两次服。该方具有化痰泻火、重镇安神之功效,主要用于躁狂症急性发作状态,体形壮实者。

(2) 忘忧汤(制剂)：生地 30g、忘忧草 30g、当归 10g、红花 10g、赤芍 10g、合欢皮 30g、郁金 30g,水煎兑匀,分两次温服,或煎成浓缩液,每次 30~50ml,每日 3 次。该方具有活血解郁、健脑安神之功效,主要用于气滞血瘀所致之抑郁症。

(3) 清开灵冲击疗法：清开灵注射液 80~120ml,分两批加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日一次,15~20 日

为一疗程。该法清开灵用量一定要大,才能取效,但应注意观察,个别患者会出现皮疹应马上减量,或停止使用,该法主要用于急性躁狂状态。

(4) 蝮蛇抗栓酶治疗法:具体方法详见精神分裂症篇,该法可用于快速循环型(即躁狂忧郁反复交替发作)的情感性精神障碍。

(5) 刺五加注射液治疗法:刺五加注射液 40~60ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日一次,周日休息,24 次为一疗程,适用于体质虚弱、气血不足之抑郁症。

【其他疗法】

1. 针灸治疗

(1) 躁狂状态:一般采用强刺激手法,或在进针后以两支针为一对电极,通以适量的脉冲电。头部穴取:百会、人中、太阳、听宫、翳风等;四肢穴取:间使、内关、神门、合谷、劳宫、足三里、三阴交、太冲、照海等。急性期每日 2~3 次,一个月为一疗程。躁狂发作时,可独取两侧环跳穴,用四寸粗针,行强刺激,可起安神定志作用。

(2) 抑郁状态:近年来不少报道采用智能电针(CCEA)治疗情感之抑郁状态,取得满意的效果。治疗方法:CCEA 治疗仪选择四组不同刺激频数,时间(分 10、10、10、15min)共 45min,以正弦波为调制波,其频率(Hz)分别为 12、10、8、6,基波 1 频率为 250Hz,基波 2 频率为 750Hz,一般强度在 2~9V 范围之内。治疗穴位选择两组:一组为印堂、百会;另一组为神庭、哑门。穴位针刺深度均 5 分。两组穴位隔日交替一次,CCEA 治疗每日一次,每次 45min,8 周一疗程。

(3) 电针休克疗法:适用于内源性抑郁症(重精神病性抑郁症)或其他抑郁症出现自杀观念和行為明显者,是严重抑

具有活血化瘀、化痰安神之功效。适用于抑郁症兼有痰火或瘀血症,对严重抑郁有自杀倾向有一定疗效。

【预防与护理】

情感性精神病是一组反复发作性疾病,一般认为急性情感障碍的预后较好,但并非间歇期症状全部消失,一部分患者仍处于慢性、轻型精神病状态,社会活动能力未能恢复到病前水平。其预后与年龄、家族史、长期人格适应不良、躯体疾病、缺乏社会支持、治疗不充分等因素有关。为此应充分调动患者的积极性,树立战胜疾病,适应社会的信心与勇气,指导其生活、工作和服药,不宜过早停药。情感性精神障碍的发病与情感因素有一定的关系,中医认为因七情过度所伤,因此在疾病的缓解期要充分做好心理治疗,帮助患者摆脱心理压力。

此外,抑郁症自杀行为危险性最大,消极患者无故突然变得心情开朗,病情突然恢复“正常”,必须想到有伪装的可能性,应提高警惕,小心看护。

【现代研究】

罗和春等(1992):电针治疗抑郁症,共完成 241 例抑郁症的临床疗效观察 570 例实验研究,其中电针组 133 例,全愈显著好转率 75.2%。阿米替林药物对照组 108 例,全愈显著好转率为 76.7%,经统计学处理两组无显著性差异,治疗后两组患者 Hanilton 抑郁量表均分皆显著下降。因子分析表明,电针治疗躯体化焦虑综合征、认知障碍综合征比阿米替林疗效更好,对内源性抑郁症两组疗效相当,而反应性抑郁电针组疗效比阿米替林组更好。另外,阿米替林组的副作用明显高于、重于电针组。生化药理研究发现接受电针治疗的患者,中枢神经介质 NE 代谢研究中,电针对治疗前血中 NE 偏低尿中 MHPG 偏低,治疗后两者上升趋势明显的患者疗效较好,

电生理脑电图研究也提示两组患者治疗前后有不同之改变。

张再康(1994):采用过梁针刺经外奇穴为主治疗躁狂抑郁症。分三种类型治疗。躁狂症:主穴为天灵、腋灵、屈阳委、中平、平顶、阴委、四连、灵宝。配穴为涌泉、人中。手法均取刺激泻法。4日1次,同时配合方药荡痰汤(生赭石 60g,大黄 30g,朴硝 18g,清半夏、郁金各 9g,大便未畅利者调服甘遂末 6g)。抑郁症:针刺主穴平顶用过梁针。配穴为合谷透劳宫、太阳、三阴交、攒竹透鱼腰、百会。手法均取平补平泻。4日1次,同时配合方药甘麦大枣汤加味(淮小麦、夜交藤各 30g,大枣 5枚,炙甘草、陈南星、郁金、丹参、菖蒲各 9g,远志 6g,生铁落 60g,萱草 12g)。半癫半狂双相型:躁狂与抑郁交替不规则发作。针刺穴位及手法,施以躁狂症或抑郁症的针刺法及取穴法,方选癫狂梦醒汤。共治疗躁郁症 12 例,除 1 例复发后再治无效外,其余少有复发,即使复发,用本法仍有效。

包培蓉(1994):以柴胡加龙牡汤化裁:柴胡 24g、黄芩 9g、半夏 12g、党参 15g、大枣 6 枚、茯苓 30g、桂枝 6g、生龙牡各 30g、铅丹 4.5g、大黄 6~15g、生铁落 30~60g,伴有不寐加朱砂 1.5g(冲)、琥珀 3g(冲);烦闷者加菖蒲 15g、郁金 15g;痰热者加胆星 9g、天竺黄 3~9g(研冲)、礞石 15g;痰阻胸膈者亦可配合瓜蒂散或明矾催吐以求速效。共治疗狂症 21 例,结果,治愈 16 例,好转 4 例,无效 1 例,总治愈率 76%,有效率 95.9%。

参 考 文 献

1. 罗和春等. 回顾 10 年来电针治疗抑郁症的研究. 北京医科大学精神卫生研究所中西医结合研究室资料汇编, 1992
2. 张再康. 过梁针刺经外奇穴为主治疗躁狂抑郁症. 浙江中医杂

志,1994,29(2):78~79

3. 包培蓉. 柴胡加龙骨牡蛎汤化裁治疗狂症 21 例. 山东中医杂志, 1994,13(1):15~16

第三节 神经症

神经症又称神经官能症,是一组精神障碍,除癔症外,没有精神病性症状,主要表现为烦恼、紧张、焦虑、恐怖、强迫症状,疑病症状,心情抑郁,或分离症状,转换症状等。除癔病表现为短暂的发作外,病程大多是持续迁延的,病前多有一定的素质和人格基础,起病常以心理社会因素有关,其症状以无可证实的器质性病变作为基础。

神经症是各类精神疾病中的常见病,全国 12 个地区精神疾病流行病学调查资料显示,在 15~59 岁人口中,神经症患病率为 22.21%(1982 年);北京市 1991 年精神障碍流行病学调查结果,神经症在 15~59 岁人口中患病率为 33.81%;1984 年四川省某县医院调查,神经症占内外科门诊患者的 9.5%;1986 年上海与广州市心理咨询门诊中,神经症分别占 58.6%和 57.2%。

目前国内将神经症分为:神经衰弱、癔症、恐怖性神经症、焦虑性神经症、抑郁性神经症、疑病性神经症以及其他神经症等 8 种类型。在祖国医学中多数属于情志疾病范畴。

一、神经衰弱

神经衰弱是在工作、学习、生活等长期过度紧张,长期情绪紧张,思想矛盾,精神压力等因素作用下,导致的一种神经症性障碍,主要临床相是与精神易兴奋相联系的精神易疲劳,心情紧张,烦恼和容易激惹等情绪症状,以及肌肉紧张性疼痛和睡眠障碍等生理功能紊乱症状。症状不是继发于躯体疾病

或脑的疾病,也不是其他任何一种精神障碍临床症状的一部分。

一般发病年龄以 16~40 岁的青壮年最多,且以脑力劳动者占大多数,男女两性无显著差异。

中医对本病的记载散见于“失眠”、“健忘”、“惊悸”、“头痛”、“虚损”等病证中,认为七情所伤、劳逸失度、房室不节、病后失养等因素都可导致脏腑阴阳、气血功能失调,心神不宁而发病,其中以心、肝、脾、肾四脏受累最为显著,临床上多表现为虚证或虚中夹实证。

【临床表现】

1. 衰弱症状

脑力活动容易疲劳,患者感到精力不足,脑子迟钝,相应表现为注意力不能集中或不能持久,为此导致记忆力差,思考困难,工作效率显著减退,做事丢三拉四。此外,肢体无力,困乏思睡,即使充分休息也不足恢复其疲劳感。

2. 情绪症状

主要表现为容易烦恼,心情紧张而不能松弛,烦恼的内容往往涉及现实生活中的各种矛盾。感到困难重重,难以解决,另一方面由于自制力减弱,而容易激惹、烦躁易怒,但事后又感到后悔。病人容易伤感、落泪、情感脆弱,部分病人出于对疾病症状的担心而产生焦虑及抑郁情绪。

3. 兴奋症状

患者精神容易兴奋,表现在用脑力工作或看电视等活动时,出现不由自主地回忆和联想增多,控制不住,这种现象在入睡前尤为明显,致使患者深感苦恼。此外,兴奋症状还表现为病人对于声光敏感,怕声、怕光有时对细微的躯体不适也特别敏感,如感到心悸,胸前区不适等。

4. 肌肉紧张性疼痛

常由情绪紧张引起,如紧张性头痛最为常见,患者感到头部沉重感,头部紧压感,头胀或颈项僵硬,有的病人诉述腰酸背痛或四肢肌肉酸痛。

5. 睡眠障碍

最常见为入睡困难。病人辗转难眠,为此心情烦躁更难入睡;即使睡着但多梦、易惊醒;或感到睡眠很浅,似乎整夜未睡,以致醒后不觉解乏;有的病人表现睡眠节律紊乱,晚上睡不着,白天思睡、困倦,但上床后仍兴奋睡不着;有的病人则缺乏真实的睡眠感,虽然酣然入睡,鼾声大作,但醒后都坚决否认已经睡着,因此为睡眠担心、苦恼。

6. 其他心理生理障碍

较常见如头昏眼花、耳鸣、心悸、气短、胸闷、腹胀、消化不良、尿频、多汗、阳痿、早泄、遗精、月经紊乱等。多属于自主神经功能障碍所引起的症状,患者经常为这些症状产生疑病观念,担心自己所患疾病复杂,对治愈失去信心。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 发病前具有用脑长期过度紧张的因素。

(2) 临床症状在衰弱症状、情绪症状、兴奋症状、肌肉紧张性疼痛、睡眠障碍这五项中至少具有三项。

(3) 严重程度:疾病症状妨碍病人的工作、学习、生活或社交活动;或者无法摆脱精神痛苦;或者病人主动要求治疗。在这三条中至少具备一条。

(4) 持续病程至少三个月。

(5) 必须排除器质性精神障碍。

2. 鉴别诊断

(1) 神经衰弱综合征：各种脑器质性疾病，如脑动脉硬化、颅内肿瘤、颅内感染、颅脑外伤后、各种急慢性工业中毒；各种慢性躯体疾病，如肺结核、溃疡病、慢性肝炎、副鼻窦炎、屈光不正、甲状腺及肾上腺疾病、高血压等，均可有类似神经衰弱的症状表现。应该根据这些疾病的不同病因、常见症状、病程特点、阳性体征及辅助检查所见加以鉴别。

(2) 某些重性精神病：精神分裂症和抑郁症等重性精神病的早期、病程中和缓解期，均可出现类似神经衰弱的症状。但这类患者往往不能主动关心自己的健康，不积极求治，缺乏自知力，并有相应的精神病性症状存在及各自精神病的特点。

(3) 其他类型的神经症：神经衰弱症状也常见于焦虑症、抑郁症性神经症、躯体化障碍、疑病症等神经症，如果患者有这类疾病的典型症状，则不再诊断神经衰弱，而诊断为各种相应的神经症。

【临床治疗】

1. 辨证要点

(1) 对神经衰弱的辨证要领是，首先要抓住主症，结合兼症，审证求因，其次要分清虚实。虚证多属阴血不足，贵在心、肝、脾、肾。实证多因气郁日久、肝郁化火，或气病及血、瘀血留滞、夹痰夹火、内扰心神，以致疾病缠绵不已。其治法以补虚泻实、调和气血、调整阴阳、安神镇静为原则。虚者补其不足，宜益气养血、滋补肝肾；实者宜泻其有余、活血化瘀、清火化痰、消导和中；虚实夹杂者，应攻补兼顾为治。

(2) 由于神经衰弱病程较长，病情反复，多因七情所伤，气血运行失调，脏腑功能紊乱，久病及血，往往存在不同程度的瘀血症状，因此在调理脏腑功能的同时应注意适当的活血化瘀，特别对一些较顽固，运用其他常规治疗无效的病人，采

(2) 心虚神怯证

主证：心悸心慌、胆怯易惊、多疑善恐、坐卧不安、失眠多梦、神疲健忘、舌质淡、脉弱。

辨证分析：平素心气亏虚、神气怯弱、突受精神刺激、心气浮躁、心神失养，故见心惊心慌、胆怯易惊、多疑善恐、坐卧不安、失眠多梦、神疲健忘等症状，舌质淡、脉弱均为气虚不足之象。

治法：益气镇惊、安神定志。

方药：安神定志丸。

人参 10g，茯苓 10g，茯神 10g，远志 10g，

石菖蒲 15g，龙齿 21g。

水煎两次兑匀，分两次中午、晚上温服。

方药分析：方中人参益气安神；茯苓、茯神、远志安神宁志；石菖蒲、龙齿镇惊开窍宁神。药味虽少，用药精良，用于治疗神经衰弱、心虚神怯之证，确有疗效。

加减法：若见惊惕不安、心悸较甚，加生龙牡、朱砂以重镇安神；夜寐不安、失眠较重加酸枣仁、夜交藤以安神；若舌质暗、脉涩，有心血瘀阻之象宜加丹参、郁金活血通脉。

(3) 阴虚火旺证

主证：心烦不寐、焦虑紧张、口燥咽干、头晕头痛、健忘耳鸣、腰酸梦遗、五心烦热、舌红少津、脉细数。

辨证分析：思虑过度、耗伤阴液，或气郁日久而化火，灼伤阴精，阴液亏虚、虚火亢旺、上扰心神，故见心烦不寐、焦虑紧张；阴精亏耗、髓海空虚、精神失养，故见头晕头痛、健忘耳鸣；阴精不足则髓海不足、精气不固，故见腰酸梦遗；阴亏于下，虚火上炎，则见五心烦热、口燥咽干；舌红少津、脉细数均为阴虚火旺之象。

治法：滋阴降火、清心安神。

方药：黄连阿胶合六味地黄丸。

黄连 3g, 黄芩 6g, 芍药 12g, 阿胶 9g(烔化),
鸡子黄 1 枚(冲服), 六味地黄丸 15g(送服)。
水煎两次兑匀, 再浓缩于晚上入睡前温服。

方药分析：六味地黄丸滋阴补肾, 合黄连、黄芩直折心火; 芍药、阿胶、鸡子黄滋阴养血, 两方合用共奏滋阴降火之效。

加减法：若心烦心悸较甚、男子梦遗失精, 可加肉桂引火归元; 与黄连共用交通心肾, 使肾水上济于心, 心火下交于肾, 心肾相交则心神可安。

(4) 心脾两虚证

主证：心悸难眠、多梦易醒、头晕健忘、面色萎黄、食少神疲、腹胀便溏、舌淡脉弱。

辨证分析：思虑过度、劳伤心脾, 或久病失血、年高体衰而致心脾两虚、气虚血少。脾主思而统血, 心藏神而主血, 脾虚则气衰血少、心失所养, 故见心悸失眠、多梦易醒、头晕健忘、面色萎黄、食少神疲、腹胀便溏、舌淡脉弱等症。

治法：补益心脾、养心安神。

方药：归脾汤。

白术 9g, 茯苓 10g, 黄芪 12g, 龙眼肉 10g,
酸枣仁 10g, 人参 12g, 木香 5g, 炙甘草 5g,
当归 10g, 远志 10g, 生姜 6g, 大枣 3 枚。
水煎两次兑匀, 分两次温取。

方药分析：本方益气补血, 健脾以资化源、养血以益心神, 适用于思虑过度, 或久病气血虚衰之神经衰弱, 亦可用于外伤或产后出血过多, 气血两亏之不寐。方用人参、黄芪为主,

补气健脾；辅以当归、龙眼肉养血和营，合主药以益气养血；用白术、木香以健脾理气使补而不滞；茯神、远志、枣仁以养心安神，共为佐药，使以甘草、生姜、大枣和胃健脾，以资生化，则气旺而血充实。各药合用能补益心脾，气旺血生，则失眠、惊悸、健忘诸病自愈。

加减法：失眠较重者，加五味子、柏子仁、合欢花、夜交藤，助养心安神；若惊悸不安、胆怯多梦、易于惊醒，或遇事善惊、焦虑恐惧者，加珍珠母、牡蛎、丹参、琥珀以镇静活血安神；如脘闷纳呆、舌苔腻，加半夏、陈皮、茯苓、厚朴以健脾理气化痰；如血虚较甚，加熟地、白芍、阿胶以补血养心。

（5）气滞血瘀证

主证：顽固性失眠、而定性头痛、持续性健忘、反复波动性情绪、眼眶暗黑、舌紫或有斑点、脉弦涩。

辨证分析：《伤寒论》曰：“其人喜忘者，必有蓄血也”；清代名医王清任认为“瞀闷”、“急躁”、“夜不安”、“不眠”诸症，都有瘀血。盖人之气血，贵乎中和，七情内伤、久病不愈，均可引起气血不和、气滞血瘀，而出现严重的失眠、头痛、健忘、烦躁不安等症状，凡长期失眠，用常法治疗无效，又见头部刺痛、眼眶暗黑、舌质暗红、脉弦涩者，均可从瘀论治。

治法：活血祛瘀、养血安神。

方药：血府逐瘀汤。

桃仁 12g，红花 9g，当归 9g，生地黄 9g，
川芎 5g，赤芍 6g，牛膝 9g，桔梗 5g，柴胡 3g，
枳壳 6g，甘草 3g。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：血府逐瘀汤方出自清代名医王清任《医林改错》，为治疗“胸中血府血瘀之药方”临床应用甚广。王清任指

出“夜寐难睡，用安神养血药治，不效者，此方若神”。血府逐瘀汤旨在祛胸膈之瘀血，使气达血畅，心脉舒通，神得血养，而心神自安之目的。方中桃仁、红花、川芎、赤芍活血祛瘀；配当归、生地活血养血；柴胡、枳壳疏肝理气，气行则血行；牛膝破瘀通经引瘀血下行；桔梗入肺经载药上行；甘草调合诸药。本方不仅行血分瘀滞，又能解气分之郁结，活血而不耗血，祛瘀又能生新，合而用之使瘀去气行，气血通和，心神自安，则诸症可愈。

加减法：若证见烦急易怒、情绪不稳、焦虑不安为主兼见头痛脑胀、心中烦乱、不能入睡、目赤口苦、大便燥结、舌暗红、苔黄者，多系情志不遂、暴怒伤肝、气郁化火、瘀血阻滞所致，宜兼疏肝泻热，加龙胆草、黄芩、栀子。若胸闷胁胀，善叹息者，加香附、郁金、佛手干以加强疏肝开郁之力。若证见抑郁寡欢、不思饮食、情绪消沉、闷闷不乐，加忘忧草、合欢皮，或送服丹栀逍遥丸。

3. 经验方药

(1) 活血安神合剂(经验方)：丹参、徐长卿、延胡索、苦参根各等量，水煎成浓缩液后(相当于每10ml含生药15g)，分装于瓶中，密封防腐，每次服30~50ml，每日3次，晚上加倍。该方具有活血安神之功效，适用于较严重的神经衰弱症，对顽固性失眠、头痛，有明显的瘀血症者，疗效显著。

(2) 健脑忘忧汤(见抑郁症)：该方主要用于健忘失眠、情绪抑郁等症状较明显，且伴有气阴两虚症状的神经衰弱症。

(3) 复方丹参注射液治疗组：复方丹参注射液10~20ml加入5%葡萄糖液500ml中，静脉滴注，每日一次，周日休息，15日为一疗程。治疗神经衰弱126例，总有效率为85.3%，其中符合瘀血症诊断者54例，有效率达92.4%，其他各型有效

率均在 70% 以上,说明复方丹参注射液在神经衰弱的临床应用上有广泛性。

复方丹参注射液(含丹参、降香等)广泛用于心血管疾病,该药经药理实验证明,具有扩张冠状动脉,降低血液粘度,加快红细胞的流速,改善外周循环,达到活血化瘀,通脉养心的功能。有报道丹参对中枢神经系统有抑制作用,复方丹参注射液能使兔大脑皮层自发电活动减少,重复刺激引起的后发放的阈值提高,感觉刺激的诱发电位增大,丹参在与氯丙嗪和眠尔通合并应用时,使其作用增强,丹参的抗惊厥作用不明显,但对抗苯丙胺精神运动性兴奋作用都较显著,有试验在清醒的犬侧脑室内注入微量丹参素,产生脑电波慢波和犬的镇静作用,说明丹参素为丹参引起中枢镇静的一有效成分。

(4) 刺五加注射液治疗组:刺五加注射液 20~40ml,加入 10% 葡萄糖液 250ml 中,静脉滴注,每日一次,20 日为一疗程。笔者运用刺五加注射液治疗 30 例神经衰弱,经 1~2 个疗程治疗均达到全愈,认为刺五加对改善脑循环血流量,调整神经系统有很好的作用。

(5) 生脉注射液治疗组:生脉注射液 20~40ml,加入 10% 葡萄糖液或 0.9% 葡萄糖盐水 200~250ml 中,静脉滴入,每日一次,10~15 日为一疗程。本组适用于阴虚症状较明显的神经衰弱,疗效显著。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

- (1) 针刺内关、合谷、三阴交、通里。
- (2) 针刺列缺、心俞、神门、中脘、足三里、灸少海。
- (3) 针刺合谷、内关、曲池、足三里,三阴交。
- (4) 手厥阴心包经、手少阴心经、足太阳膀胱穴为主。

疗程。

【预防与护理】

神经衰弱是一类以精神容易兴奋和脑力容易疲乏,常有情绪烦恼和心理生理症状的神经症性障碍,被看作可由素质、躯体、心理、社会和环境等诸多因素引起的一种整体性疾病。多数患者起病缓慢,症状呈波动性,常随情绪、睡眠和休息情况而变化,如果能及时去除病因,适当休息并给予及时治疗,症状常可显著减轻。神经衰弱的预后一般较好,可以彻底治愈。神经衰弱与精神分裂症是两种完全不同的疾病,其病因、发病机理、临床表现和转归完全不同,这就需要医护人员向患者及家属作耐心细致的思想工作,鼓励患者树立起战胜疾病的信心。国内的经验提示采取心理治疗、药物治疗、物理治疗和体育锻炼等综合措施,常可获得较好的疗效。

【现代研究】

李增兰(1990):介绍用辨证论治五法治疗神经衰弱。

①化湿祛痰醒脾:适用于痰浊上泛、清阳不升,治当燥湿祛痰、醒脾止眩。常用半夏、白术、天麻、钩藤、陈皮、茯苓、泽泻。若痰郁化火加滑石、黄连、龙胆草;气虚者加黄芪、党参;呕吐频繁者加代赭石;胸闷不适加藿香、寇仁。

②补益心脾安神:适用心脾两虚、气血不足、脑失所养者,治以补益心脾,养血安神。常用党参、白术、茯苓、当归、酸枣仁、龙眼肉、茯神、远志、广木香、炙甘草等。若失眠甚者加柏子仁、夜交藤;心悸加五味子;易惊加生龙骨、牡蛎、珍珠母。

③疏肝理气解郁:适用于情志不舒,远志、五味子、茯神、柴胡、当归、杭芍、白术、薄荷、夜交藤、莲子心等。

④补肾固精止遗:适用于阳萎遗精,治当补肾固精止遗。常用熟地、山药、山萸肉、金樱子、芡实、沙苑、蒺藜、五味子、生龙骨、生牡蛎。若偏阴虚加生地、麦冬;偏阳虚者加

锁阳、巴戟天、菟丝子、补骨脂。⑤益气安神、镇静定志：适用于突受惊恐、心胆气虚。证属心胆气虚，治当益气安神、镇静定志。常用党参、茯苓、白术、远志、生龙齿、酸枣仁、知母、川芎、甘草。若血虚加当归、丹参；自汗盗汗加五味子、生牡蛎；身热口干加杭芍、生地、麦冬等。

龙功宏(1994)：介绍分三型辨证治疗神经衰弱症 107 例。病程一年以内者 82 例，一年以上者 25 例。心脾亏损型：方用归脾养心汤加减(党参 30g、茯神 20g、远志 10g、黄芪 20g、白术 10g、龙眼肉 15g、酸枣仁 10g、淮山药 20g、甘草 6g、夜交藤 15g)。阴虚火旺型：方用知柏地黄汤加减(生地 20g、山萸肉 20g、泽泻 15g、茯苓 22g、知母 15g、黄柏 8g、淮山药 15g、丹皮 10g、麦冬 12g、远志 6g、酸枣仁 10g、参须 10g)。脾胃不和型：方用温胆汤加减(法半夏 10g、陈皮 6g、茯苓 12g、竹茹 5g、枳壳 10g、川朴 10g、酸枣仁 10g、太子参 10g)。随证加减。治疗结果，107 例中，临床治愈 82 例，有效 17 例，无效 8 例，总有效率 92.52%。

黄禾生(1995)：介绍用体针和耳针相结合治疗重症神经衰弱 32 例。耳针取穴：神门、心、肝、肾、枕。每日针一耳，双耳交替治疗。体针取穴：神门、内关、三阴交、太冲。针感以酸麻胀为度，避免强刺激，每日针刺一次。每种针法同时留针 30min，每 10 次为一疗程。治疗结果，32 例患者中，显效 12 例(占 37.5%)，有效 17 例(占 53.1%)，无效 3 例(占 9.4%)，总有效率为 90.6%。

参 考 文 献

1. 李增兰. 神经衰弱辨证论治五法. 山西中医, 1990, 6(5): 20~21
2. 龙功宏. 辨证分型治疗神经衰弱 107 例. 湖南中医杂志, 1994, 10

2h 即可自行缓解。

2. 运动障碍

表现痉挛发作,伴四肢乱舞、闭眼、睑缘颤动、呼之不应或故作怪声,无大小便失禁。肢体瘫痪,可单瘫、偏瘫或截瘫,呈弛缓性,但腱反射存在或增强,无病理反应。

3. 感觉障碍

表现感觉减退或消失,但感觉障碍与神经解剖分布的部位不相符,呈手套式、靴子式或散式间断分布,这些对鉴别诊断有意义。

4. 自主神经功能紊乱

表现神经性呕吐、呃逆、腹痛、头痛、假孕等。

【诊断和鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 起病大多急骤,有明显的精神因素及其所引起的强烈情感体验,或因暗示与自我暗示而发病。

(2) 临床症状具有发作性、戏剧性、高度暗示性及丰富的情感色彩,精神症状内容与诱因之间存在可理解的联系,各种检查未能发现与症状相应的器质性病变,其体征不符合解剖生理规律。

(3) 病前常具有癔症性人格特点和(或)既往有相类似的癔症发作史,症状具有暗示性。

2. 鉴别诊断

(1) 癫痫大发作:癫痫意识障碍和运动性发作都与癔病发作类似,但癫痫发作时不是意识范围缩小,而是意识完全丧失,过后不能回忆,伴有大小便失禁,脑电图改变,可与癔病区别。

(2) 散发性脑炎:意识模糊和类似癔症样发作常为本病

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：方中柴胡、枳壳、香附、陈皮疏肝解郁、理气畅中；川芎、白芍、甘草活血通络、柔肝缓急。诸药合用，共奏疏肝理气之功。

加減：肝郁甚者，可在此方基础上酌情选加旋复花、郁金、青皮、佛手干、绿萼梅等，以助疏肝解郁之功。嗳气频作、胸脘不舒者，可加旋复花、代赭石、陈皮、半夏以平肝和胃降逆。兼有食滞腹胀者可加神曲、麦芽、山楂、鸡内金消食化滞。若肝郁日久、气郁化火兼见性情急躁易怒、口干口苦、舌红苔黄者宜加丹皮、栀子、黄连以凉肝泻火，或改用丹枝逍遥汤。

（2）气郁痰阻证

主证：精神抑郁、闷闷不乐、呆坐懒语，或突然失语，或突然昏倒、肢冷强直，气逆则发，气缓则止，或喉际似有物梗，痰多胸闷，舌淡苔白或腻，脉弦滑。

辨证分析：七情内伤、肝气怫郁、气滞湿阻、聚湿生痰、痰气内阻故见精神抑郁、闷闷不乐、呆坐懒语。痰气内阻甚至蒙闭神明，故或见突然失语，或突然昏倒，肢冷强直，气逆则发，气缓则止。痰气上逆胸膈故见喉际似有物梗。痰多胸闷、苔白或腻，脉弦滑皆为肝郁挟痰之象。

治法：疏肝理气，化痰解郁。

方药：半夏厚朴汤。

半夏 10g，茯苓 12g，紫苏 9g，厚朴 6g，生姜 9g。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方中用半夏辛温化痰开结，和胃降逆；厚朴辛苦温，“苦能下气泄实满，湿能益气散湿满”，两药相配，厚朴行气以助半夏之化痰，半夏降逆，可助厚朴之行气。配生姜辛以散结，苦以降逆，下气散满，解郁宽中；紫苏入肺，质轻辛温，芳

香疏散，又助半夏降逆和中。本方辛、苦、温并用，辛散气滞，宣通郁结，苦能燥湿降逆，温能通气滞、温化痰饮。诸药合用，辛以散结，苦以降逆，辛开苦降，化痰降逆，则痰气郁结之证，自可解除。

加减：气郁为主可酌加柴胡、香附、佛手干、枳壳以增强理气开郁；痰郁甚者可加海蛤壳、紫菀、贝母、陈皮、瓜蒌以加强化痰行气之效。

（3）气滞血瘀证

主证：情绪不稳、精神忧郁、悲伤啼哭、神情呆滞、胸胁满闷、目眶暗黑、头痛失眠、多梦易惊，甚则肢体废用、夜寐神游、舌质暗紫，或有瘀斑，脉弦涩。

辨证分析：瘵症的成因，总不离乎七情所伤，气血郁滞。《七松岩集》曰：“若人情志抑郁，怀抱不舒，意兴不畅，则生机退绝，而精神气血亦无不受伤矣，盖久郁不解，必伤营血，气血瘀滞，脏腑失润，心失血养，心神不宁故发瘵证。”

治法：活血化瘀，养血润脏。

方药：桃仁四物汤加味。

桃仁 10g，红花 10g，当归 10g，赤芍 30g，

川芎 10g，生地 12g，柴胡 10g，香附 12g，

龙骨 30g，炙甘草 6g，琥珀 6g（研末冲）。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：桃仁四物汤既有雄厚的补血之功，又有强大的活血之力，为治疗血虚血瘀之专方。配柴胡、香附疏肝理气、解郁行气，使血得气而行、气得血而畅、脏腑得气血而濡润，郁滞之气得以疏解；加入龙骨、琥珀、炙甘草宁心定志，柔和血脉以使气机条达、血脉充盈、瘀血化、脉络通、五脏润、心神定。诸药配用，相得益彰。

加减：若胸闷急躁，口苦苔黄宜加黄连、栀子以清热除烦；若胸痞叹息者加佛手、郁金，以理气解郁；心悸失眠者加茯神、炒枣仁以宁心安神。

（4）心神失养证

主证：心神不宁、精神恍惚、悲伤欲哭、志意不定、数欠伸、心烦不得卧、心悸、坐卧不安、舌淡苔薄白、脉细弱。

辨证分析：七情失调、忧思烦恼，或精神过度紧张，使肝气郁结、心气耗伤；营血不足，而致心神失养，故见心神不宁、精神恍惚、悲伤欲哭、志意不定、数欠伸、心烦不得卧、坐卧不安等症。心悸、舌淡苔薄白、脉细弱为心血不足之象。

治法：甘润缓急，养心安神。

方药：甘麦大枣汤加味。

甘草 10g，淮小麦 30g，大枣 15 枚，柏子仁 10g，
炒枣仁 15g，茯神 10g，龙齿 30g，牡蛎 30g。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：甘麦大枣汤具有养心安神、甘润缓急之效。《金匱要略》用本方治疗脏躁症，深合“肝苦急，急食甘以缓之”之意，佐以大枣甘平质润，补中益气、并润脏躁。加柏子仁、炒枣仁、茯神可加强养心安神之功。龙齿、牡蛎镇静安神。诸药合用，共奏养心安神之功效。

加减：若面色少华、神疲倦怠、心悸不寐宜加当归、白芍、黄芪等补气养血；若心气不足、心神不安、精神恍惚、坐卧不宁者可送服人参琥珀丸，以养血养心、安神定志。若心气不足、忧郁伤神、心血暗耗而见神志不宁、心悸失眠者，宜送服安神定志丸。

（5）心脾两虚证

主证：心悸胆怯、多思善疑、失眠健忘、夜寐不安、多梦易

(2) 生脉注射液 20ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日 1 次,15 日为一疗程。适用于心脾两虚兼有阴虚证见之癔症。

(3) 菖蒲郁金注射液 2ml 肌注,或每次 10~20ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日一次,10~15 日为一疗程。该方具有清热化浊、芳香开窍之功效。用于癔症急性发作而精神障碍明显者。

【其他疗法】

1. 针刺治疗

(1) 针刺取穴:人中、合谷、内关、太冲、百会、上脘、中脘、气海、印堂、风府、大椎、十宣、神门、三阴交、期门、大陵、地仓、颊车、下关、肩髃、曲池、环跳、风市、阳陵泉、天枢、足三里。

(2) 配方原则

情感暴发:人中配合谷(双),内关(双),配三阴交(双)。

意识障碍:合谷(双)配太冲(双),神门(双)配上脘、三阴交(双)。

运动障碍:上肢瘫痪,肩髃(双),配曲池(双)、合谷(双);下肢瘫痪,环跳(双),配风市(双)、阳陵泉(双)。

自主神经功能紊乱:天枢(双),配气海、足三里(双);神门(双)配三阴交(双)。

(3) 手法:均以捻转泻针,留针 15min。

2. 单方验方

(1) 茯神 120g、香附子 500g,为末炼蜜为丸,如弹子大,每日清晨服 1 丸。适用于肝气郁滞之癔症。

(2) 忘忧草 30g、郁金 15g、炙甘草 5g,水煎服,每日一剂。适用于七情内伤、痰气郁结之癔症。

(3) 百合 30g、知母 6g,水煎每晚临睡前服。主治百合病,

子。配合暗示疗法,取得较好的疗效。

符俊(1994):介绍用破瘀醒神法治疗癔症性昏厥 38 例。水蛭 6~20g、菖蒲 6~20g、大黄 6~20g、郁金 10~20g、丹参 15g、茯苓 15g、白芍 10g、远志 10g、甘草 6g。初发体健者加细辛 6g、枳实 10~15g,并加大水蛭,大黄的剂量;体弱者去大黄,加龙骨、牡蛎各 15g,太子参 30g;牙关紧闭、呼吸气粗、四肢颤抖者加钩藤、石决明各 20g,沉香 6g。治疗结果:全愈 28 例(占 73.6%),好转 8 例(占 21%),无效 2 例(占 5.4%),总有效率为 94.6%。最少服药 3 剂,最多服药 60 剂,平均服药 25 剂,多数服药 10~20 剂。

参 考 文 献

1. 夏俊杰. 辨证治疗癔病 33 例. 陕西中医, 1989, (5): 199~200
2. 王忠民. 柴胡桂枝汤加味治疗癔病性瘫痪. 黑龙江中医药, 1989, (2): 18~19
3. 符俊. 破瘀醒神法治疗女性癔症昏厥 38 例. 湖南中医杂志, 1994, 10(3): 16~17

三、焦虑性神经症

焦虑性神经症,简称焦虑症,是以广泛和持续性焦虑和反复发作的惊恐不安为主要特征的神经症性障碍。常伴有显著的自主神经症状和肌肉紧张及运动性不安。

据国外报道,焦虑症在一般居民中的患病率为 2%~4.7%,在精神科患者中,本病占 6%~27%。国内流行病学调查,在 15~59 岁人群中,焦虑症患病率仅为 1.5%左右,远低于国外统计。近 10 年来,作者在临床实践中发现焦虑症的患病率有日渐增多趋向。该症一般女性多于男性,约为 2:1,焦虑症一般预后良好。

中医学对本病的记载散见于“惊恐”、“惊悸”、“怔忡”等病证中,认为情志不遂,气机失调,逐渐导致心气不足、心脉痹阻、神失所养,或肝气郁滞、痰热内蕴、内扰心神所致。临床常见有心气虚血瘀证、心气滞血瘀证、肝郁痰火证等。

【临床表现】

1. 过分的焦虑持续在半年以上

这种焦虑表现为对将来可能发生的、难以预料的某种危险或不幸事件的经常担心,这类患者常为未来的不幸烦恼,终日坐卧不安,心烦意乱,注意力集中困难或感到害怕,以致学习和工作受到严重影响。

2. 运动性紧张

表现为坐卧不宁,来回走动,肢体肌肉紧张,疼痛,紧张性头痛,颤抖无法放松,经常感到疲乏。

3. 植物神经功能亢进

口干、汗出、心悸、手足发凉、发麻、头昏头晕、上腹部不适、尿急尿频等。

4. 警觉性增高

表现为过分关心周围动静,容易受惊和激惹,感觉过敏,怕光、怕噪音,注意力欠集中,失眠等。

5. 急性发作

又称惊恐发作,以反复出现强烈的惊恐发作,伴濒死感或失控感,以及严重的自主神经功能紊乱为特点。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 发作出现在没有任何客观危险的环境中,如正在进行日常工作或生活活动中,突然出现强烈的恐惧感,并伴有自主神经功能亢进症状和运动性紧张。

(2) 发作不局限于已知的或可预测的情景。

(3) 发作间期基本没有焦虑症状,但大多数患者常担心再次发病,而有预期焦虑。

(4) 一个月内至少有3次发作,每次发作不超过2h,且明显影响日常活动。

2. 鉴别诊断

特别要注意排除因心血管病、低血糖、内分泌病、药物或戒断反应和癫痫所致的类似发作,同时应排除妄想、恐怖症、抑郁症等继发的惊恐发作。

【临床治疗】

1. 辨证要点

大凡焦虑症的发病,多与情绪因素有关,可由骤遇惊恐,忧思恼怒,悲哀过极或过度紧张而诱发,多为阵发性、病程较短者,病情较轻,实证居多,但也有内虚的因素存在。若病程日久,久病体虚,心神受损较重者,无精神因素亦可发生,常反复频繁发作,病情较重,多为虚证或虚中夹实,常表现为气虚血滞。

2. 辨证论治

(1) 心气虚血瘀证

主证:骤然发作,紧张恐惧,似有大难临头,死亡迫近感,因而呻吟不已、坐立不安、哀叫叹息、呼吸急促、心跳加快、胸闷或憋闷气促、心悸气短、精神疲倦、失眠多梦、舌暗淡、苔白、脉细弱或结代。

辨证分析:七情内伤、心气不足、鼓动无力、勉强搏动,故心悸气短、精神疲倦;心气虚不足以继续,故呼吸急促、哀叫叹息;心气虚、心血不足、心神失养,故坐卧不安、紧张恐惧;心气不足、胸阳不振、心脉痹阻,故见胸闷或憋闷气促;舌暗苔白、

脉细弱或结代均为心气虚、瘀血痹阻之象。

治法：益气养心、活血通脉。

方药：天王补心丹。

生地黄 30g,五味子 10g,当归 15g,天冬 15g,

麦冬 15g,柏子仁 15g,酸枣仁 15g,人参 10g,

玄参 10g,茯苓 10g,丹参 10g,桔梗 10g。

水煎服,每日一剂,30日为一疗程,病情好转后改丸剂善后。

方药分析：方中的生地黄、玄参、天冬、麦冬滋阴养血、养心安神；人参、茯苓益心气而安心神；柏子仁、远志宁心安神；丹参、当归补血养心、活血通脉,更用五味子、酸枣仁之酸以敛心气之浮动耗散,并能安神；桔梗载药上行以达病所。诸药合用,共奏益气养血、养心安神、活血通脉之功。适用于焦虑证之气血亏虚、心失所养、脉络痹阻之症。

加减法：若胸憋气闷或刺痛、舌暗为胸阳不振、瘀血阻滞,宜加郁金、桂枝、茜草；若紧张不安心气上浮,有临终之感者宜加龙骨、真珠母、生牡蛎；若情绪不稳、急躁易怒、头痛头晕者为肝郁化火之象宜加柴胡、栀子、黄芩或送服丹栀逍遥丸。

(2) 心气滞血瘀证

主治：焦虑时发时止、经久不愈、紧张憔悴、怔忡健忘、恐惧颤抖、精神呆滞、胸部闷痛、脘腹呃逆、面色晦滞、目眶暗青、舌质暗红有斑点或瘀斑、脉沉弦或细涩。

辨证分析：七情抑遏,或过度惊恐、气机郁滞、血行不畅,久则血行滞碍、瘀阻心脉,或久病入络、瘀血内阻,故见焦虑时发时止、经久不愈,并表现出种种瘀血内阻之征象。心气郁滞、血行失畅、心神不宁,故见紧张憔悴、怔忡健忘、恐惧不安、精

神呆滞等证。

治法：活血行滞、镇心安神。

方药：血府逐瘀汤加减。

丹参 15g, 当归 15g, 川芎 9g, 赤芍 12g,
桃仁 12g, 红花 9g, 柴胡 15g, 枳壳 12g,
香附 15g, 郁金 15g, 龙齿 15g, 远志 10g,
琥珀 6g(研末冲), 炙甘草 6g。

水煎服, 每日一剂, 20 日为一疗程。

方药分析: 方中用丹参、当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血化瘀、养血安神; 柴胡、枳壳、香附、郁金行气解郁、理气安神; 龙齿、远志、琥珀安神定志、镇心安神。诸药共奏活血行滞、镇心安神之功。

加减法: 若见心神烦乱、胸中气乱而热、紧张焦虑、失眠多梦、舌红为心火上炎, 灼伤阴血所致, 可送服朱砂安神丸以镇心安神、清热养血。

(3) 肝郁痰火证

主证: 情绪抑郁、焦虑悲急、烦躁易怒、善喜太息、失眠多梦、胸膈满闷、两胁胀痛、痰多而稠、舌红苔黄腻、脉弦或弦滑。

辨证分析: 情志怫郁、肝气郁结、气机失调, 故见情绪抑郁、焦虑悲急、两胁作痛、善喜太息; 气郁日久、气滞痰生、久则化火、痰火内扰, 故见烦躁易怒、胸膈满闷、痰多而稠、失眠多梦; 舌红苔黄腻、脉弦或弦数为肝气郁结、痰火内蕴之象。

治法: 疏肝解郁、清热化痰。

方药: 柴胡疏肝散合小陷胸汤

柴胡 10g, 陈皮 10g, 芍药 15g, 枳壳 10g,
炙甘草 6g, 川芎 5g, 香附 5g, 黄连 6g, 半夏 10g,
瓜蒌实 30g。

水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析:方用柴胡、白芍疏肝解郁、清热为主,配伍枳壳、陈皮、川芎、香附疏肝行气、活血通络,以疏解肝经郁滞,合小陷胸汤之黄连、半夏、瓜蒌,清热化痰,以除胸中痰火之扰;炙甘草调合诸药。诸药合用,共奏疏肝解郁、清热化痰之功。

加减:若心烦不安,小便短赤,大便秘结者宜加酒大黄、栀子、黄芩以清泄三焦之火。若头晕头痛,面红目赤,烦躁易怒者宜加龙胆草、泽泻、菊花、僵蚕以清肝泻火,明目止痉。若痰浊较甚宜加川贝、半夏、白术以化痰祛湿。若头痛如裂,面赤项强宜加牛膝、石决明、夏枯草以平肝潜阳。

3. 经验方药

(1) 化痰安神汤:当归 15g、赤芍 12g、丹参 15g、桃仁 12g、红花 10g、龙齿 30g、石菖蒲 10g、远志 10g、香附 24g、郁金 18g、琥珀 6g(研末冲服)。该方具有化痰安神、解郁通脑之功。适用于焦虑不安、经久不愈、气滞血瘀之证。

(2) 解郁化痰汤:龙胆草 10g、郁金 10g、枳壳 10g、栀子 10g、黄芩 10g、柴胡 10g、瓜蒌 15g、浙贝 10g、龙骨 15g、珍珠母 15g。水煎两次兑匀,分两次温服。该方具有解郁化痰、镇静安神,适用于情志怫郁、焦虑不安、烦躁易怒、痰火不寐之焦虑证。

(3) 菖蒲郁金注射液:清热化浊、芳香开窍。每次 2ml 肌注,每日 1~2 次,或每次 10~20ml 加入 10% 葡萄糖液 500ml 中静滴,每日一次。

【其他治疗】

1. 针刺治疗

(1) 瘀血型:针刺血海、膈俞、心俞、神门、郄门,用泻法,留针 2h,每 15min 捻 1 次。

(2) 心虚夹瘀型:针刺心俞、脾俞,用补法,神门、通里、内关、血海、百会,用平补平泻法,留针 1h,每 15min 捻针 1 次。

(3) 痰气交结型:针刺肺俞、肝俞、内关、合谷、列缺、天突、膻中,均用泻法,留针 2h,每 15min 捻针 1 次。

2. 单方验方

(1) 百合大枣汤:百合 30g、大枣 15g,水煎,放适当红糖,每日 1~2 次,当点心,具有健脾养心安神之功。

(2) 珍珠粉 1~2 克,猪心一个:猪心洗净,将珍珠粉放入猪心内,炖服隔日一次,具有养心安神之功。

(3) 珍珠粉一份,琥珀粉一份,研细末和匀,每日服 1~2g,每日 2 次,十五日为一疗程,具有镇静安神之功,对焦虑惊恐状态特别对儿童焦虑症具有较好的疗效。

【预防与护理】

发病与精神因素有关者采用解释性、支持性心理治疗,要告诫患者此病是功能性疾病,通过治疗,一定能够治愈,并不断鼓励患者树立自信心,按时按量服药,做一些力所能及的劳动,加强体育锻炼或文娱活动,加强对社会能力的锻炼,以转移或分散患者对于疾病的注意力。医护人员可帮助患者建立一些适应良好的行为及消除一些适应不良的行为,同时可采用传统的气功疗法——放松功的锻炼以达到消除焦虑之目的。

【现代研究】

大原浩一(日,1989):综述日本神经症的中医疗法。①常用方剂:菊谷认为神经症的有效方剂有半夏厚朴汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、抑肝散、抑肝散(加陈皮、半夏)、归脾汤;癔病的有效方剂有甘麦大枣汤、抑肝散(加陈皮、半夏)、抑肝散、三黄泻心汤、黄连解毒汤等。松田等认为神经症的常用方剂有半夏厚朴汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、加味逍遥散、抑

肝散、甘麦大枣汤、苓桂甘枣汤、三黄泻心汤、黄连解毒汤、半夏泻心汤、甘草泻心汤、黄连汤、桃仁承气汤、桂枝茯苓丸、四逆散、大柴胡汤、香苏散、归脾汤、加味归脾汤等。②临床疗效：太原等用柴胡加龙骨牡蛎汤和半夏厚朴汤分别治疗神经症 23 例（其中抑郁性神经症 21 例、恐怖症 2 例）及 22 例（其中疑病性神经症 7 例、焦虑性神经症 6 例、恐怖症 4 例、强迫性神经症和神经衰弱各 2 例、癔病 1 例）；结果轻度改善以上者均占 78.3%；显效时间分别为 3~21 日及 5~14 日，均以第 7 天最多；疗效明显、改善率在 50% 以上的症状依次为易怒、易疲劳、心血管症状、全身倦怠、焦虑、抑郁、疑病等，后者依次为呼吸系症状、易怒、失眠、焦虑、心血管症状、易疲劳、性欲减退、烦躁、运动系症状、消化系症状；副作用的发生率分别为 47.8% 及 27.3% 均属轻度，并不妨碍治疗。简井等用半夏厚朴汤和加味道遥散分别治疗胃肠神经症 49 例和 58 例，对胃肠神经症的紧张感、焦虑、烦躁感、抑郁感等都有明显疗效。轻度改善以上者分别为 77.6% 及 84.5%；平均显效时间分别为 7.7 日及 7.9 日；副作用分别为 4.1% 及 6.9%，都属轻度，并不妨碍治疗。更井等和越智等用柴胡加龙骨牡蛎汤分别治疗神经症或抑郁状态 32 例及 36 例；平均年龄分别为 40.5 岁及 41 岁；轻度改善以上者分别为 81.3% 及 69.4%；改善率较高的症状均为抑郁、焦虑、烦躁、失眠等；副作用分别占 15.6% 及 13.9%，也属轻度而不妨碍治疗者。③中医方剂与“证”的关系：本文报道了半夏厚朴汤、柴胡加龙骨牡蛎汤及加味道遥散对各种神经症的疗效高达 77%~85%；对易怒、焦虑、易疲劳、抑郁、烦躁等症状特别有效，副作用较少。

单怀海等(1987)：放松功治疗焦虑症 8 例疗效观察，治疗方法：根据沈鹤年医师所编《调养六合功》，放松训练分为

三个步骤:①调气训练(通过肢体震颤,静立调息和肢体升降开合,调整呼吸达到细匀深长);②松弛训练(通过意念诱导,使机体处于松弛状态);③意守丹田训练(通过意守丹田和腹式呼吸,进一步达到凝神、聚气和宁静大脑的目的)治疗时间为6星期,隔日一次,每次15min。治疗前后用多频道生理记录仪描记患者脑电、皮肤电、呼吸、心率、耗氧量变化。同时采用抑郁和焦虑量表作为心理测定。

结果分析:①病人学会放松训练后,脑电功率谱 α 波明显升高;肌电内功率谱总能量低于训练前水平;呼吸周期和幅度变系系数减少,频率减慢;皮肤电自发波活动减少;心率变慢,耗氧量减少,特别是焦虑和抑郁症状量表评分结果明显低于治疗前(治疗前后,焦虑量表平均分分别为16.5和6.13;抑郁量表平均分分别为13和4.5),有非常显著意义($P < 0.01$)。②根据8例患者症状缓解程度和适应工作能力评定:全愈5例,显著进步2例,无效1例。作者认为:放松功是一种不用药物的良好治疗方法,作为一种行为治疗手段运用于焦虑症,有利于祖国医学心理疗法的发展。

参 考 文 献

1. 大原浩一.神经症的中医疗法(日).国外医学·精神病学分册,1990,(2):127
2. 单怀海等.放松功治疗焦虑症8例疗效观察.气功与科学,1987,(2):8

四、强迫性神经症

强迫性神经症又称强迫症,它是以各种强迫观念、情绪、意向和动作为主要临床相的一种常见的神经症,其特点是患者意识的自我强迫与有意识的自我反强迫同时并存。患者明

处境产生强烈的恐怖情绪,如怕尖锐的利器、怕昆虫、怕广场等。患者认为恐怖情绪的发生是理所当然的,并无强迫或强制的性质,因此采取回避行为。强迫情绪是害怕自己情绪行为失控而出现危险行为。

(2) 精神分裂症:早期可有强迫症状,但患者往往不感到痛苦,强迫内容显荒谬,不要求治疗,随病程的进展,精神分裂症的典型或基本症状越来越明显,故不难鉴别。

(3) 抑郁症:可有强迫症状,而强迫症患者也常合并抑郁情绪,鉴别应分清何者为原发,何者为继发。

【临床治疗】

1. 辨证要点

根据《素问·灵兰秘典论》:“胆者,中正之官,决断出焉”以及“中静之腑喜静而恶躁”之论述,认为人之所以有正确的判断和行动是与胆的决断功能分不开的,结合强迫性神经症表现为强迫的思维形式和强迫的动作方式,与病人的决断功能失常有关,临床上常表现两种类型:一为劳心日久,积成痰浊,痰浊犯胆以致心虚胆怯,心虚不能自主,胆怯决断失常;一为情志抑郁、病及于肝、肝郁气滞、日久不解、气滞血瘀累及于胆,决断失常所致。

2. 辨证论治

(1) 心胆不宁证

主证:强迫思维或动作、紧张焦虑、莫能自主、心虚胆怯、触事易惊、恐惧不安、敏感多疑、虚烦不眠、头昏目眩、舌淡苔白、脉细或弦细。

辨证分析:劳心日久、思伤心脾、脾失健运、积液为痰、痰浊犯胆、胆失决断之能,故思虑不能自主、反复强迫动作;心气亏虚、胆气不宁,故见紧张焦虑、触事易惊、恐惧不安、心悸失

眠；痰浊中阻、清阳不升，故头晕胸闷；舌淡苔白、脉细或弦细为心虚痰阻之象。

治法：养心安神、燥湿化痰。

方药：温胆汤加味。

半夏 15g，竹茹 15g，枳实 10g，陈皮 10g，
生姜 10g，炙甘草 6g，茯苓 30g，麦冬 15g，
远志 10g，龙齿 21g，石菖蒲 15g，琥珀 6g（研末冲服）。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方中温胆汤燥湿化痰、清热除烦，以安“中静之府”，使胆气得以安宁，加茯苓、麦冬、远志、石菖蒲养心安神、通窍降浊；龙齿、琥珀重镇安神。诸药合用使心虚得养、胆气得宁、心神得以安静。

加减法：若胸闷痰多宜加瓜蒌、浙贝清热化痰。性情急躁、心烦易怒宜加柴胡、栀子、龙胆草以疏肝泻火；胃脘胀闷，纳呆食少加砂仁、木香、炒鸡内金以消导和中；夜寐多梦、失眠加酸枣仁、合欢皮、夜交藤以镇静安神。反复动作，不能自主加磁石、牡蛎、天冬以重镇安神。

（2）肝胆瘀滞证

主证：强迫动作或思维不能自主、情绪不稳、急躁动怒、面色晦暗、两胁胀痛或周身作痛、头痛如刺、失眠多梦、舌紫暗或有瘀点，脉弦涩。

辨证分析：情志抑郁、病及于肝、肝郁气滞、日久不解、气滞血瘀、累及于胆、胆气失宁、决断失常故强迫动作或思维不能自主、情绪不稳、急躁动怒、失眠多梦；肝经为瘀血所阻、气血流行失调故两胁作痛，或周身作痛；瘀血阻滞、清阳不升故头痛如刺；舌紫暗、脉弦细为瘀血内阻之象。

治法：疏肝理气、活血化瘀。

方药：血府逐瘀汤。

桃仁 12g,红花 9g,当归 9g,生地黄 9g,
川芎 5g,赤芍 6g,牛膝 9g,桔梗 5g,柴胡 3g,
枳壳 6g,甘草 3g。

水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析：方中当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血祛瘀；牛膝祛瘀血、通血脉，并引血下行；柴胡疏肝解郁、升达清阳；桔梗、枳壳开满行气，使气行则血行；生地凉血清热，配当归又能养血润血，使祛瘀而不伤阴血；甘草调和诸药。本方不仅行血分瘀滞，又能解气分之郁结，使肝胆气滞血瘀得以清除则诸症可愈。

加减法：若反复动作、反复洗手，莫能自主加瓜蒌根、桂枝、白芍、僵蚕以通络止痉而制动。若强迫思维、穷思竭虑宜加菖蒲、天竺黄、麝香以通窍醒神而制虑。

3. 经验方药

(1) 定志安神汤：郁金 15g、胆南星 10g、石菖蒲 10g、远志 10g、丹参 30g、牡蛎 30g、龙骨 30g、桂枝 5g、白芍 30g、炙甘草 6g、大枣 10g,水煎,每日一剂,30 剂为一疗程。该方具有开窍解郁、安神定志之功效。适用于强迫思维为主要临床相的强迫症。

(2) 精制蝮蛇抗栓酶：活血化瘀,1u 加生理盐水 5ml 中稀释,肌肉注射,每日一次,3 个月一疗程。该药使用前应皮试,阴性者方可使用,使用过程中应每周查一次血常规及出凝血时间。

【其他疗法】

1. 针灸治疗

(1) 取太阳、阳白、足三里、三阴交、胆俞、心俞、血海、神

门等穴交替使用。若用电针仪,针刺穴位后,通上微电治疗,疗效更为满意。

(2) 脑功能保健仪: WL-HA-Z 脑功能保健仪是用于改善和增进身心健康的中西医结合保健仪器。它根据脑波同步及经络平衡原理,用特殊编制的声、光信号及电脉冲,分别作用于人体的耳、眼和相关经络穴位,利用声、光信号频率(节律)变化影响和调节人体的脑电活动水平和兴奋水平,有利于减轻紧张情绪,强迫意念,进而减少强迫动作。根据强迫性神经症患者不同的强迫内容,选择“放松信号”、“调整信号”、“平衡信号”以及“用以增强动机,提高生理兴奋和进行心理锻炼”的信号等不同的程序目录进行治疗,每日治疗一次,每次治疗30~40min,12次为一疗程。

2. 单方验方

(1) 核桃肉 30g、大枣 15g 炖服,每日一次。

(2) 朱磁丸: 10~15g,每日 3 次。

【预防与护理】

强迫症患者通常具有以下性格特点:拘谨、非常注意细节和形式、循规蹈矩、过分认真、好思虑、多犹豫、不果断、洁癖等。在此性格基础上,如果长期工作紧张、责任心加重,对新环境新工作的不适应,或遭受意外事故、挫折等不良精神因素的影响,加重了患者的不安全感和不完善感,使其长期处于精神紧张状态,终日忧心忡忡、焦虑不安;为了避免再出问题,以防万一,患者对人处事加倍小心,反复思虑,再三琢磨,事前显得紧张不安,事后又追悔自责,长此下去逐渐形成无法摆脱的强迫症状。为此消除这些不利因素对于预防发病或减轻疾病的发生有十分重要意义。

心理治疗是治疗强迫症的有效方法。目前主要采用行为

疗法,根据强迫性神经症所表现的不同方式分别可采用系统脱敏疗法、模拟法、暴露恐怖情境法、效应预防法、矛盾意向法、厌恶疗法和思维停止法等。此外还要向患者的亲属讲清治疗的意义和方式,以便协助患者进行治疗。尤其对强迫性仪式动作,亲属的协助更为重要。近年来有报道用森田疗法治疗强迫症取得满意效果。

【现代研究】

丁德正(1983):介绍家传三法针药并用,辨证施治治疗强迫性神经症。益气安神法适用于心脾血虚,神失所养所致之症。方用养心脾安神汤,当归、党参、龙齿、酸枣仁、远志、茯神、北五味、菖蒲、莲子、龙眼肉、麦冬、甘草、大枣、琥珀、朱砂。针刺少冲(双)、通里(双)、心俞(双)、脾俞(双)。耳穴:皮质下脑点。养心镇怯法,适用于七情内伤,心胆虚怯,或胆虚痰热上扰所致之症。方用镇怯化痰安神汤(党参、茯神、枣仁、远志、菖蒲、半夏、陈皮、枳实、竹茹、珍珠母、龙骨、海浮石、甘草、朱砂)。针灸心俞(双)、胆俞(双)、神门(双)、通里(双),耳穴:神门、皮质下。疏郁化痰法,适用于情志郁结,痰浊内阻,神机不畅所致之症。方用疏郁化痰汤(柴胡、黄芩、香附、郁金、天竺黄、海浮石、枳实、胆星、远志、菖蒲、薄荷、甘草)。针刺风府、百会、肝俞(双)、心俞(双)、内关(双)、丰隆(双)、太冲(双)。

张向阳等(1994):作者遵循森田疗法的基本原则,并吸取其他心理疗法的优点,结合我国情况,开展了中国式住院森田疗法。应用此疗法治疗21例难治的强迫症,经临床疗效评定SCL-90SAS、SDS测定,全愈率为71.4%,显效率为90.5%,平均随访 7.47 ± 4.13 个月,显示远期疗效较稳定。

参 考 文 献

1. 丁德正. 家传治疗强迫性神经症三法. 辽宁中医杂志, 1983, (4): 29
2. 张向阳等. 中国式住院森田疗法治疗 21 例强迫症的临床报告. 临床精神医学杂志, 1994, (1)23: 24

第四节 癫痫性精神障碍

癫痫俗称“羊癫风”，是一种慢性，发作性神经系统疾病。临床具有突发性、短暂性和反复性的特点，是神经系统的常见病、多发病。据最近 20 年来流行病学调查，癫痫患病率发达国家为 3.5‰～20.0‰，平均为 9.2‰，发展中国家 2.3‰～37.0‰，平均 11.9‰。不论发达或发展中国家，100 人中平均约有一人患癫痫。癫痫伴发精神障碍，其临床表现形式多样，可在癫痫发作前先出现精神症状，也可在癫痫发作时或发作后伴发精神症状，可表现发作性精神障碍，发作间期精神状态完全正常。也可表现持久性精神障碍，轻重不一，轻者仅短暂失神，重者表现精神运动性兴奋、伤人、毁物、幻觉、妄想等症状。

癫痫患者伴有精神症状者为数多少，尚缺乏流行病系统研究，因此很难对此作出患病率和发病率的精确估计。Pond 和 Bidwell(1959)的调查：30%癫痫患者有精神病学问题，7%曾住过精神病院。我国成都对 710 例癫痫患者分析，癫痫伴有持久性精神障碍者占癫痫患者的 12.6%，赵耕源(1963)报道精神病住院患者中，癫痫伴有明显精神异常者占 25.27%。

既往根据对慢性住院癫痫患者观察，错误地认为癫痫患

者最终不可避免地导致人格和智力衰退,这个观点近年来有所改变。研究表明,多数癫痫患者都能过正常或接近正常的生活,2/3的患者并无严重的精神病学问题。

癫痫发作按是否有确定原因分为原发性(特发性)和继发性两大类。继发性又称症状性癫痫,有明显的致病因素,如感染、外伤、新生物、循环障碍、代谢障碍、缺氧、中毒等。原发性癫痫的病因和发病机制十分复杂,至今尚未完全阐明。

本病属于祖国医学“痫证”和“癫证”的范畴。中医认为本病的发生,除与母体怀孕期间胎儿遭受惊吓、秉赋不足或由于产伤等因素有关外,主要是由于情志失调、大惊大恐、饮食失节、劳累过度、温热病后热毒所伤,以及脑部外伤等因素导致脏腑功能失调,气血逆乱,风、火、痰、瘀交杂,侵犯于脑而成痫证。痫证反复发作,痼疾难愈与痰浊和气滞血瘀互相影响关系密切,痰浊停留可致气血不畅,气滞血瘀则津液流通受阻而变为痰浊,痰瘀互结可使痫证反复发作,难以根治。

明清以前癫、狂、痫三证没有明确的区分,明清以后,对痫证的认识有了一个大的飞跃,明确地将癫、痫、狂加以区别,但是由痫证所伴发的精神障碍,尚未见论述。

【临床表现】

癫痫性精神障碍的临床表现主要有以下几种形式:

1. 精神运动性发作

为最常见的一种类型,约占15%~20%病变多在颞叶,故有“颞叶癫痫”之称。临床表现有精神性发作、自动症、神游症、梦游症、意识模糊状态、癫痫性谵妄等。以上症状多呈发作性,发作时间多在数秒至数小时不等,有的可达更长时间,有的发作时伴有轻重不等的意识障碍,情绪改变,行为异常,感知综合障碍,定向力障碍等。发作过后,有部分或全部遗忘,多

数病人间歇期精神状态正常。

2. 分裂性精神病

多数在癫痫发作数年或 10 余年后,出现精神症状,表现妄想状态,以被害妄想、关系妄想、妒嫉妄想为主,有的伴有幻听、幻视、易激惹。有时突然出现冲动伤人,毁物,精神症状时,癫痫发作已减少或完全停止。脑电图检查,出现颞叶病灶,CT、MRI 气脑造影出现颞叶皮质萎缩。

3. 癫痫性痴呆

少数由于长期癫痫发作后,逐渐出现严重智能障碍,思维出现粘滞,使人难于理解他的叙述,甚至出现病理性赘述,理解力和判断力障碍,工作能力逐步丧失,甚至生活自理均有困难。

4. 癫痫性人格改变

这是癫痫特有的精神障碍表现之一,呈慢性进行性特征,具有双重性,一方面表现易激惹、暴躁、凶残、固执、气量狭窄、记仇心重、自我为中心、拘泥小节;另一方面,又循规蹈矩、过分客气、温存恭顺、曲意逢迎。两极性格可以同时存在,也可以在某一时间内,一种性格表现倾向更突出。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断

癫痫发作时精神障碍的特点是:

(1) 病程多呈发作性。

(2) 突然发生,骤然结束,持续短暂。

(3) 可出现在痉挛发作或小发作之前或后,成为发作的一个组成部分。也可以单独发作,癫痫发作期精神障碍一般持续时间虽较长,但临床上也具有明显的癫痫特征。

出现以上各类精神障碍的癫痫患者,病史中常有大、小发作或其他类型癫痫发作,临床诊断一般并不困难;EEG 对本

病诊断有重要的参考价值；详细的躯体、神经系统检查及一些必要的特殊检查，如颅脑超声，CT、MRI、脑血管造影对症状性癫痫诊断有所帮助。

2. 鉴别诊断

须与精神分裂症、躁郁性精神病、癔病、感染性或中毒性精神病等进行区别。虽然这些病与癫痫性精神障碍临床表现相似，但癫痫脑电图多数表现特殊的棘波或慢波幅，过去史和目前临床表现多数伴有运动性抽搐，这是鉴别的重要依据。

【临床治疗】

1. 辨证要点

癫痫性精神障碍是在癫痫病的基础上发病的，因此在临床上应注意抓住如下要点：

(1) 详细了解病史及发病情况以确定诊断：由于痫证与先天因素有关，故需询问其父母体质情况，了解亲属中有无患痫证者以及本人出生时的情况，有无跌仆、脑病史等。

本证的临床表现较为复杂，发作次数有多有少，有日发数次者，有数日发一次者，有数月乃至数年发一次者，但总是反复发作；发作持续时间有数秒到数小时不等；发作程度有轻有重，有的仅表现为木呆无知、不闻不见、不语不动，有的可突然中断活动，手中物体突然落下，或头突然向前倾下而又迅速抬起，或两目上视。重者来势急，卒倒呼号，抽搐，口吐白沫，二便失禁。或伴有精神错乱，行为紊乱等症。临床上应抓住反复发作，生风、失神的表现而确定诊断。

(2) 辨痰浊，瘀血之轻重，正气之盛衰：本证的轻重常与正气的盛衰，痰浊、瘀血的轻重有关。一般初起正气未衰，痰浊、瘀血不重，故发作持续时间短，间歇时间长。如反复发作，正气渐衰，痰浊、瘀血日重，或痰瘀互结，愈发愈频，使正气更

温服。

方药分析：天麻钩藤饮重在平肝熄风、清热安神。方中天麻、钩藤、石决明以平肝阳、熄肝风为主药，以桑寄生、杜仲养肝肾滋肝阴；茯神、夜交藤安神定志，均为辅药。栀子、黄芩清热降肝经之火；益母草清肝均为佐药。牛膝活血、引血下行为使药。合定痫丸驱风止痉、镇静安神。诸药合用，共奏平肝熄风、止痉安神之功效。

加减：若癫痫持续发作，或频繁发作，莫能自制者，宜加蜈蚣、全蝎、僵蚕、地龙干等虫类之品，以祛风止痉。若兴奋躁动，意识模糊者宜加用安宫牛黄丸以醒脑开窍，镇静安神。若行为冲动，急躁易怒者宜加龙骨、牡蛎、代赭石以重镇安神。

（3）心肾亏虚证

主证：长期癫痫发作后逐渐出现严重智能障碍，思维出现粘滞，使人难于理解患者的叙述，甚至出现病理性赘述，理解和判断力障碍，工作能力逐步丧失，甚至生活自理均有困难，伴畏寒肢冷、五心烦热、心悸失眠、耳鸣腰酸、舌淡脉弱。

辨证分析：癫痫发作日久，损及心肾，心肾亏虚、脑窍失聪，故见智力障碍、思维粘滞等精神衰退的症状。心与肾的阴液，阳气均虚故见畏寒肢冷、五心烦热、心悸失眠、耳鸣腰酸、舌淡脉弱等症。

治法：益气补肾、养心益智。

方药：大补元煎加减。

熟地 30g，党参 15g，山萸肉 15g，枸杞子 15g，
当归 10g，杜仲 15g，淮山药 15g，巴戟天 15g，
炙甘草 6g，益智仁 15g，乌药 15g，远志 15g。
水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：大补元煎具有益气补肾、生精养血之功能。方

中人参、山药、炙甘草益气固肾；杜仲、山萸肉、巴戟天温补肾气；熟地、枸杞、当归生精补血，配合益智仁、乌药、远志养心益智。诸药合用，共奏益气补肾、养心益智之功。

加减：若偏阴虚宜加玄参、麦冬、龟板等以增强养阴之力。若偏阳虚宜加仙灵脾、仙茅、鹿茸等以兴奋温阳，振奋精神。若兼见心悸不安，夜寐不佳宜加酸枣仁、麦冬、远志、龙齿以养心安神，宁心定志。

3. 临床经验

(1) 抗痫胶囊：制马钱子、全蝎、僵蚕、地龙干、天竺黄、川贝母、乳香、没药、胎盘粉经炮制碾成粉末分装胶囊，每粒0.3g，每次服5粒，每日3次。该方具有驱风止痉、活血化瘀、化痰安神之功效。用于癫痫运动性发作伴发精神障碍者，在疾病的缓解期，或以长期服用，可起到减少复发，巩固疗效之功。

(2) 若精神障碍明显、兴奋冲动、语言增多、幻听妄想、行为怪异等症状宜用清开灵80~100ml加入10%葡萄糖液500ml中，静脉滴注，每日一次，15日为一疗程。

(3) 癫痫持续状态：牛黄醒脑静10~20ml加入10%葡萄糖液500ml中，静脉滴注，每日一次。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

(1) 针刺疗法：以督脉取穴为主。第一组主穴哑门，配内关(双)、足三里(双)。第二组：大椎、上呈为主穴，大陵(双)、行间(双)为配穴。第三组：陶道为主穴，后溪(双)、丰隆(双)为配穴。

(2) 穴位埋线：命门、大椎、陶道、风池等穴每次取一穴，每穴埋入单长线1~1.5cm，每5~7日为一次，按上述穴位顺序轮流埋入，3个月为一疗程。

(3) 耳针疗法：常用穴位有脑、缘中、耳神门、心、枕、胃、肝等，每次选 2~3 穴，中等刺激，每日一次，连用 10~15 次为一疗程。发作选脑、缘中、心 3 穴，强刺激，发作停止后起针。

2. 单方验方

(1) 鲜橄榄 10kg，加明矾 200g，熬成膏状，每服 10~20g，每日 2 次，早晚各一次温开水送服，长期服用可控制癫痫发作，对癫痫伴发精神障碍有一定临床疗效。

(2) 川郁金、明矾各等量，研末、蜜丸，每日 2 次，每次 12g。

(3) 羊癫风药饼、煅青礞石、制半夏、炮南星、海浮石、沉香、生熟黑白二丑，炒建曲，上药各等分研末，过筛，拌入发好的面中，作为饼子，烤熟，每日 2 个，每个饼约含生药面 6~9g。

【预防与护理】

癫痫的预防关键应把有关治疗本病的知识交给患者及其家属，以取得他们在治疗上与医生配合。应按时按量服药，不可自动减药或突然停药；节制饮水量，进少盐饮食，禁用酒类，不宜进行高空、炉房、水上或水边，机床旁作业以及驾驶车辆等，以免发生危险；尤应告知家属，在癫痫性精神障碍时，往往有发生自伤、自杀、伤人、毁物等危险行为和构成违法行为的可能性，以便及早采取措施。

【现代研究】

黄跃东(1992)等：自制抗痫胶囊(配方见前)治疗小儿癫痫 50 例，经临床观察显效率 75%，总有效率 > 84.61%。该药对失神小发作、类小发作、腹痛型癫痫的疗效较好，对全身性强直-阵挛发作也有效。

洪永根(1991)：介绍自拟安痫 1 号、2 号治疗癫。抗痫 1 号：柴胡、半夏、党参、黄芪、竹沥、僵蚕、贝母、蝉蜕、丹参、陈

皮、茯苓各 10g,枳实 15g、甘草 6g。适用于胆火型,症见癫痫发作伴见舌红、苔黄、脉弦;抗痫 2 号:柴胡、半夏、党参、黄芩、桂枝、白芍、韭菜、僵蚕、贝母、蝉蜕各 10g,甘草 6g、龙骨、牡蛎各 15g。适用于痰火型,症见癫痫发作伴见舌红苔腻、脉弦滑。上药均水煎服,每日一剂,分早、晚 2 次,临床观察 100 例,完全控制者 10 例,有明显进步,但偶尔还有发作者 77 例,无效者 13 例。

陈德明(1989):选用癫狂梦醒汤:桃仁 30g,赤芍、红花、川芎、香附、青皮、陈皮、桑白皮各 15g,半夏、赤子、大腹皮、甘草各 10g,木通 8g。经加工制成片剂,每片 0.3g,每片含生药 1.5g,按 0.5 片/kg 一次的剂量给药,每日 3 次,治疗儿童癫痫,临床观察 100 例,显效者 72 例,有效者 12 例,效差者 10 例,无效者 6 例,总有效率为 94%。

马明磊(1995):介绍采用疏肝解郁,涤痰宣窍,息风化痰之法,自拟息风化痰汤加味(生石膏、生石决明、龙齿各 30g,胆星、菖蒲、枳壳、茯苓、山栀、党参、天麻、黄连、僵蚕、甘草各 10g,蜈蚣 2 条,大枣 7 个。随证加减:晕眩、耳鸣者加荷叶 10g,失眠者加炒枣仁;嗜睡者加生枣仁;肢体不灵活者加桂枝、鸡血藤;心悸多梦者加龙骨、牡蛎;吐白沫,搐风者加紫石英、钩藤、全蝎、天竺黄;毁物加胆星、黑白二丑、龙胆草),每日一次,连服 30~100 剂。病情控制后改做丸药,共治疗癫痫性精神障碍 53 例。临床治愈 25 例,有效 24 例,无效 4 例,总有效率 92.25%。

参 考 文 献

1. 黄跃东等. 小儿抗痫胶囊治疗小儿癫痫 50 例临床观察. 福建中医药杂志, 1992, (2): 17~18

2. 洪永根等. 辨证治疗癫痫病 100 例疗效观察. 陕西中医, 1991, (1): 9
3. 陈德明. 抗痫片治疗儿童癫痫的临床观察. 中医杂志, 1989, (12): 27
4. 马明磊. 中药治疗癫痫性精神障碍 57 例. 陕西中医, 1995, 16 (3): 112

第五节 老年痴呆症

老年痴呆症是指 60 岁以上的老人因大脑器质性病变或持续代谢性损害而出现的感知、记忆、抽象概括能力和创造性思维能力等的严重衰退。

临床上许多疾病都可以表现有痴呆, 最常见的是阿尔茨海默病, 另一种是多发性脑梗死性痴呆(又称脑血管性痴呆), 这两类约占痴呆的 80%~90%。

由于人类寿命的延长, 老年人数与日俱增, 老年痴呆症的发病率也成倍地增长。据国外统计, 65 岁老人痴呆症的发病率, 1980 是 1940 的 8 倍, 且有逐年增长趋势。1984 年日本患老年痴呆症有 50 多万人。1987 年美国患老年痴呆症者达 200 多万人。1988 年我国就高达 1 000 万。据联合国世界卫生组织报道, 65 岁以上老人有 10% 智力障碍, 其中 1/2 发生痴呆, 所以有学者指出, 照此发展下去, 21 世纪老年痴呆症将会成为社会的灾难。目前已越来越引起各国政府的重视。

祖国医学早已有呆病、痴呆的记载, 有些症状的描述散见于“健忘”、“郁症”、“癫症”、“狂症”等。明代医家张景岳在《景岳全书·杂证谈》有“癫狂痴呆”专论。清代医家陈士铎《辨证录》则另立有“呆病门”, 对呆病症状、病因病机描绘甚详, 认为: 肾虚为本, 痰瘀为标。王清任论述老年痴呆症的机制, 认

时期后,才出现精神抑郁而类似痴呆,但有明确的起病时间,病前可找到诱发性精神因素或生活事件,患者关注自己的智能障碍,情绪忧郁或焦虑不安,经过抗抑郁治疗,病情好转,智力障碍亦好转或恢复。

【临床治疗】

1. 辨证要点

老年痴呆症,现代医学虽有老年性痴呆,早老性痴呆,多发性脑梗死性痴呆之分,但就临床表现辨证,都有虚、痰、瘀的证候。老年性痴呆和早老性痴呆均以虚为主,兼有痰瘀。多发性脑梗死性痴呆以痰瘀为主伴有肝风,也有虚实夹杂证者。临床辨证应抓住本虚标实,或虚实夹杂的特点。

2. 辨证论治

(1) 瘀阻脑窍证

主证:情绪躁扰不安、恼怒多言,或呆滞少语、妄思离奇、健忘而易惊恐、头晕头痛、面色暗滞、舌紫苔薄、脉弦细或涩。

辨证分析:年老体弱、脏气虚衰、衰则易于气滞、气滞多致血瘀,或因久病、创伤,使血瘀阻滞脉络、阻塞脑窍、脑神为之所扰,故见情绪躁扰不安、恼怒多言,或呆滞少语、妄思离奇、头痛等症,面色暗滞、舌紫脉涩,均为气血阻滞之象。

治则:活血化瘀、理气解郁、通络开窍。

方药:通窍活血汤加减。

桃仁 15g,红花 10g,赤芍 10g,川芎 10g,
郁金 15g,柴胡 9g,香附 9g,石菖蒲 15g,
葱白 15g,生姜三片,水蛭粉 3g(研粉吞),
琥珀 6g(研粉兑服)。

水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析:方中用桃仁、红花、赤芍、川芎活血化瘀为主

药；葱白生姜合菖蒲、郁金通阳宣窍、化浊醒脑；柴胡、香附疏肝理气，使气行则血行；更用水蛭破瘀逐顽，直达病所；琥珀镇静安神。诸药合用，共奏活血化瘀、理气解郁、通络开窍之功。

加減：若神志模糊、反应迟钝、呆痴顽固，久治鲜效者加麝香少许冲服，以增强通络化瘀开窍醒脑之力。若血瘀重，兼有神疲乏力、精神萎靡不振、纳少等气虚之症宜加人参粉 5g，田三七粉 3g，炒鸡内金粉 2g，按比例装入胶囊吞服，以达益气化瘀消食之功。若久瘀化热、性情急躁、行为冲动、大便秘结宜加栀子、黄连、竹茹、菊花、酒大黄以清泄瘀热。

（2）痰阻心窍证

主证：神识痴呆、朦胧昏昧，或神情抑郁、举止失常、喉中痰鸣、胸闷痰多，或郁闷呆钝与心烦躁动同见，语言颠三倒四、面色晦暗、苔腻脉滑。

辨证分析：本证多因久病面起，素体虚弱、脾胃不足、运化失司、积液成痰；痰浊蒙闭心神故见神识痴呆、语言颠三倒四甚至朦胧昏昧；痰浊积于胸中蒙蔽清灵之窍故见神情抑郁、举止失常；喉中痰鸣、胸闷痰多、面色晦暗、苔腻、脉滑，为痰浊内盛之征象。

治则：燥湿化痰、理气开窍。

方药：温胆汤加味。

橘红 9g，姜半夏 9g，茯苓 9g，枳壳 10g，

郁金 15g，石菖蒲 15g，甘草 3g，生姜 5 片。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：方以半夏为主药，其性辛温而燥，最善燥湿化痰，辅以橘红理气燥湿，使气顺而痰消；茯苓健脾渗湿，俾湿无所聚，则痰无由生；生姜降逆化痰，配郁金、菖蒲、枳壳理气通阳、化痰开窍。诸药合用，共奏燥湿化痰、理气开窍之功。

加减：若病延日久、痰郁化热、口干便秘、痰黄口臭、头痛呕恶者加黄连、竹茹、黄芩、酒大黄以导痰热下行。若见肢体震颤、步态不稳，乃痰瘀滞络化风之象宜加全蝎、僵蚕、地龙干、蝉衣等虫类药物，搜剔通络，化痰熄风。或行为冲动、惊恐不安、夜寐欠佳乃心血瘀阻，心神不宁宜加龙齿、柏子仁、丹参以宁心安神、化痰通络。若神识昏蒙、精神失常严重宜加水蛭、麝香以加强开窍醒脑之力。

（3）肝肾亏虚证

主证：面色憔悴、肌肤不荣、双目无神、呆钝愚痴、记忆减退、头晕眼花、耳鸣重听、两胁隐痛、腰膝酸软、舌红少苔、脉细弦数。

辨证分析：年老体衰、肝肾亏虚、精血不足、髓海空虚、神明失用故见双目无神、呆钝愚痴、记忆减退；精血亏虚，上不能荣于首，故见头晕眼花、耳鸣重听，外不能达肌肤故见面色憔悴、肌肤不荣；两胁腰府仍肝肾之经循经之道，肝肾亏虚经络失养故见两胁隐痛，腰膝酸软。舌红少苔、脉细数为肝肾亏虚之象。

治则：滋补肝肾、安神定志。

方药：左归丸合加味定志丸加减。

生熟地 20g，当归 12g，枸杞子 15g，茯苓 15g，
丹参 15g，白芍 12g，枣仁 15g，山萸肉 15g，
柏子仁 15g，石菖蒲 10g，远志 10g，
阿胶 15g（另烱），龟板 20g（先煎）。

水煎两次兑匀，分两次早晚温服。

方药分析：方中重用生熟地，甘温滋肾以填真阴；当归、枸杞子、山萸肉、炒白芍辛温补肝以养精血；龟板、阿胶为有情血肉之品，大补精髓；丹参、酸枣仁、柏子仁、茯苓、石菖蒲、远

3. 经验方药

(1) 益脑丸(制剂): 人参、田三七、炒鸡内金、土茯苓、胡桃肉、银杏叶、梅片等蜜丸组成, 具有活血化瘀、益气健脑、通窍解毒之功效。该药主要用于治疗老年痴呆症早期或巩固治疗期, 以记忆障碍为主, 伴有失眠、性格改变等症状, 但精神症状尚不空白之老年痴呆症。

(2) 脑康冲剂: 丹参、川芎、当归、僵蚕、益母草等活血化瘀为主的中草药制成, 每日 2 次, 每次 2 小袋(50g), 主要用于多发性脑梗死性痴呆。

(3) 牛黄醒脑静注射液 20ml 加入 10% 葡萄糖液 500ml 中, 静脉滴注, 每日一次, 15 日为一疗程。该法对老年性痴呆、神志不清、精神意识障碍者有较好的疗效。

【其他疗法】

1. 针刺治疗

(1) 主穴: 百会、脑户、风池、大椎、膻中、神门、大陵。配穴: 心脾两虚配心俞、厥阴俞、脾俞、足三里; 肝肾亏虚配肝俞、肾俞、志室、太溪、复溜; 痰阻血瘀配丰隆、公孙、合谷、三阴交; 阴虚火旺配人中、劳宫、后溪、大钟、复溜、行间。

方法: 一般选用主穴 3~4 个, 并随症选用配穴 2~3 个, 以上各穴除任、督两经穴位外均选双侧, 进针得气后, 使用提插捻转补法(行间用泻法), 留针 15min。背俞穴可不留针, 隔日一次, 15 次为一疗程, 一疗程结束后休息一周后继续第二疗程治疗。

(2) 当归注射液穴位注射法: 选肾俞(双)、足三里(双)。每次各穴均注射 1ml 当归注射液, 每日一次, 20 次为一疗程。本法适用于多发性脑梗死性痴呆。

(3) 乙酰谷酰胺注射液穴位注射法: 选哑穴、风池(双)、

肾俞(双)。方法：每次各穴注射 1ml 乙酰谷酰胺注射液，隔日一次，20 次为一疗程。本法适用于有脑萎缩现象者。

2. 单方验方

(1) 将军汤：酒制大黄，量由小到大，一般由 10g 开始，开水浸泡 15min 后服用，每次上午一次，3 个月一疗程。开始服用时大便次数可能增加，但一般一星期后大便转为正常或偏稀，尔后可适当加量。该法治疗老年痴呆症具有破瘀祛积、通达上下、宣泄肠胃之气的功能，同时具有刺激胃肠蠕动，改善毛细血管通透性和调节血流分布的作用，故用于治疗 and 预防老年痴呆症有重要的临床作用。服用时可加适量蜂蜜。

(2) 益脑粥：胡桃肉 15g、大枣 15g、百合 15g、梗米适量，煮粥啖食，每日 1~2 次，作为预防老年痴呆症的保健食疗。

【预防与护理】

老年痴呆症一经发病，有的很难康复，预后较差，因此应力争早期诊断、早期发现、早期治疗，防范未然。如对中老年人或未老先衰者出现失眠、健忘、疲乏等神经衰弱表现时，即宜常服用补肾健脑的中成药和食物；如偏脾虚者可送服清宫八仙糕或清宫寿桃丸；偏肾阴虚者，选用杞菊地黄丸、首乌延寿丹等；偏肾阳虚者选用金匱肾气丸、龟灵集等。还宜常吃核桃仁、花生仁、松子仁、芝麻、蜂王浆、花粉等食品一类补肾补脑、抗老防衰的食物。体力劳动者易发生老年性和早老性痴呆，应鼓励多读书、多学习、多用脑，以连续大脑意志预防痴呆发生；脑力劳动者多患脑血管性痴呆，应适当参加运动和体力劳动，以防止脑动脉硬化。

老年人的生活起居必须有规律，而不可急剧改变，养成一个固定的生活动力模型，如早睡早起、定时进食、解便、合理安排工作娱乐与休息。在膳食营养上强调做到“三定、三高、三低

和两戒”即定时、定量、定质，高蛋白、高不饱和脂肪酸、高维生素、低脂肪、低热量、低盐和戒烟、戒酒。老年人宜多吃一些蔬菜、水果、粗纤维的食物以及豆类食物等。

此外，还可采用音乐疗法和温泉浴、外出旅游等，以开畅胸怀、疏豁神志、舒解郁闷以达修身养性祛病的目的。

【现代研究】

李正树等(1995)：介绍用自拟补肾益脑汤治疗老年性痴呆。共收集44例，随机分两组，治疗组共23例，男14例，女9例，年龄51~88岁，病程2个月~5年。对照组共21例，男13例，女8例，年龄50~84岁，病程1个月~3年。治疗组用生黄芪30g、熟地黄20g、川芎15g、黄精20g、石菖蒲15g、制胆星7.5g、远志15g、菟丝子20g、丹参20g、怀牛膝15g，生龙骨、生牡蛎各30g。肝肾阴虚甚者加生地、枸杞、女贞子；血瘀阻络较重者加穿山甲、红花、赤芍；痰火较重者加竹茹、黄连、茯苓、半夏。对照组给予脑复康10mg，每日3次口服。两组均以一个月为一疗程，每疗程中间歇10~20日。结果经1~3个疗程，治疗组23例中基本恢复5例(占21.74%)，显效8例(占34.78%)，有效7例(占30.43%)，无效3例(占13.04%)，总有效率86.96%。对照组21例中，基本恢复1例(占4.28%)，显效4例(占19.05%)，有效6例(占28.57%)，无效10例(占47.62%)，总有效率52.28%。两组总有效率经统计学处理， $P<0.05$ ，有显著性差异。

王惠仙(1995)：介绍用辨证论治老年性痴呆38例。脾气虚衰、痰瘀痹阻17例：治宜健脾益气，化痰祛瘀，方用洗心汤加味，党参、淮山药、生半夏(先煎)、生南星(先煎)、茯神、石菖蒲、远志、丹参、川芎、水蛭、陈皮。肝肾亏损、痰瘀痹阻14例：治宜补肝肾健脑髓，化痰祛瘀，方用还少丹化裁，熟地、杞子、

萸肉、龟板、苡仁、红花、赤芍、生半夏(先煎)、石菖蒲、天竹黄。肝旺痰火、瘀血痹阻 7 例：治宜泻火化痰、祛瘀安神，治以梔连导痰汤加减，生半夏(先煎)、生南星(先煎)、竹茹、茯苓、朱砂(冲)、陈皮、莪术、三棱、黄连、焦山栀、礞石滚痰丸(吞)、红花。治疗结果：精神症状大部分消失 13 例，精神症状部分消失或减轻 17 例，精神症状无改善或恶化 6 例。

曾伯海(1995)：介绍用辨证治疗老年性痴呆症，其中重度痴呆 35 例，中度痴呆 52 例，轻度痴呆 23 例，病程最短者 6 个月，最长者 10 年。中医辨证：肝肾阴虚型 50 例，治以滋阴养血、调补肝肾，治以知柏地黄丸加减，知母、黄柏、熟地、丹皮、当归、山药、萸肉、龟板、阿胶、茯苓。脾肾亏损型 30 例，治以健脾补肾、益气生精，用金匱肾气丸加减，熟地、萸肉、山药、白术、枸杞、苡蓉、黄芪、丹皮、茯苓、陈皮。气滞血瘀型 30 例，治以理气行滞、活血化瘀，方用桃仁四物汤加减，桃仁、红花、赤芍、当归、香附、木香、川芎、地龙、地鳖虫、陈皮。痰浊阻窍型，治以健脾、豁痰开窍，方用洗心汤加减，半夏、菖蒲、竹茹、南星、天竹黄、远志、茯苓、陈皮、香附、砂仁。每日服一剂，连服 3 个月为一疗程，停药 2 个月，再进行第二个疗程。治疗结果：一个疗程结束后，大多数患者临床表现有所好转，记忆障碍情况有所减轻。对病人进行智能测定发现：25 例显效(积分 20～25 分)，占 22.7%；54 例有效(10～20 分)，占 49.1%；31 例无效(10 分以上)，占 28.2%；总有效率为 71.8%。

参 考 文 献

1. 李正树等. 补肾益脑汤治疗老年性痴呆 23 例. 吉林中医药, 1995 (5): 6~7
2. 王惠仙等. 辨证论治老年性痴呆 38 例疗效分析. 实用中医药杂

志,1995,11(6):12~13

3. 曹伯海等. 辨证治疗老年性痴呆症 110 例疗效观察. 浙江中医杂志,1995,30(12):541~544

第六节 颅脑外伤所致的精神障碍

颅脑外伤所致的精神障碍系指头颅遭受直接或间接的暴力作用,造成脑组织损伤,从而产生精神障碍和后遗的综合征。

中医学对本病记载散见于“瘀血头痛”、“头部外伤”、“癫狂”、“癫痫”等病症中。中医学认为该证是由于脑部受损,瘀血阻滞、窍络不通所致。

【临床表现】

1. 颅脑损伤急性期的临床表现

(1) 意识障碍: 颅脑损伤患者均有不同程度的意识水平下降。表现为嗜睡,短暂而轻度的意识模糊,也可在外伤后出现较为严重的意识障碍,浅昏迷或昏迷。

(2) 记忆障碍(遗忘综合征): 患者意识障碍恢复后,常常出现记忆障碍,对意识障碍期间的经历不能回忆。遗忘的时间与外伤同时开始。

(3) 其他精神障碍,在意识障碍恢复以后,可以表现情绪不稳,对声、光敏感,容易激动不安、兴奋、躁动、欣快、不自主的哭笑,或者表现恐惧、抑郁、困惑、淡漠、懒散,或有冲动行为,有的病人在外伤后 3 天内出现癫痫大发作。

2. 颅脑损伤后远期的精神障碍

(1) 神经症样症状: 又称外伤后脑衰弱状态,主要表现为头痛、头昏、疲乏、情绪不稳、易激惹、注意力不集中、记忆力减退、思维迟钝与睡眠障碍,有的病人表现情绪低沉、抑郁,对

(1) 气滞血瘀是发生本病的主要机制：头颅外伤多因直接撞击所致，也可因间接撞击引起。如从高处跌下，身体其他部位着地，暴力经脊柱向上传致颅部；或因外力作用迫挤胸腹，使压力骤然上升，气血壅激而上，致使脑部损伤。无论直接或间接的头部损伤，其病机都是动扰脑髓，损及神明，轻则大脑受震、激壅气血，致神明失司；重则气闭血凝、清气不升、浊气不降，致神明壅阻。脑部受损，瘀血阻滞、窍络不通、痛有定处而无体止；气血运行不畅，瘀血内停，蒙蔽清窍而致眩晕昏仆。若病程日久、延续不愈，则伤后恶血留内、瘀阻经脉、耗伤气血，阴血不足无以养心，致神失所养，而出现种种精神异常之表现。脑髓为瘀血所阻，脑窍不通则见痴呆等证。

(2) 应分清急性期与恢复期的治疗原则：颅脑外伤急性期所出现的意识障碍、记忆障碍，可能危及生命，故应急则治其标，以活血通络，开窍醒脑为主。恢复期的治疗应根据遗留症状之表现、病情之深浅、败血留滞，以及所累及之脏腑的情况，具体辨证论治。

2. 辨证论治

(1) 瘀阻脑窍证

主证：头部急性创伤后，颅内出血，表现为意识不清、神志模糊，或昏不知人、记忆不清、烦躁不安、头痛头晕、恶心呕吐、而色晦暗、舌紫暗、脉弦涩或细涩。

辨证分析：急性头颅创伤，血溢于脑窍，阻滞脑络、闭塞清窍故见意识不清、神志模糊、记忆不清、烦躁不安、头痛头晕、恶心呕吐等症状；而色晦暗、舌紫暗、脉涩为瘀血内阻之象。

治法：通窍活血、醒神开窍。

方药：通窍活血汤加味。

川芎 12g, 赤芍 9g, 红花 12g, 桃仁 15g,
麝香 0.15g(冲), 五灵脂 10g, 蔓荆子 10g,
火葱果 15g, 生姜 3 片, 大枣 7 枚。

水煎两次兑匀, 冲入麝香, 分两次温服, 同时并送服安宫牛黄丸一丸, 不能口服者, 给鼻饲。

病情严重者应给予脱水、激素、止血及颅脑手术等治疗, 术后均可配合应用中药治疗。

方药分析: 严重创伤, 血溢于脑窍、瘀血内闭, 危及生命, 方中以赤芍、川芎、桃仁、红花活血化瘀为主药; 生姜、老葱、麝香行散走窜, 以助活血药发挥作用; 加入五灵脂、蔓荆子行气止痛, 为辅药; 大枣和血养阴为佐使药。诸药合用, 具有活血通窍、行瘀通经之功效。因病情严重、神志不清, 故配合安宫牛黄丸, 安神开窍、苏醒神志。临床运用确有功效。

加减: 若外伤严重, 颅内积血者宜加水蛭粉 2 克(分 2 次冲服)以活血化瘀。若头晕头痛, 大便干结者宜加大黄、天麻、石决明、钩藤、菖蒲以平肝潜阳, 泻热通腑。若晕厥者可加用至宝丹冲服。

(2) 气血瘀滞证

主证: 情绪不稳、神志呆滞、精神抑郁、少语或不语、思维迟缓、行为笨拙、记忆力减退、头痛如刺、胸胁胀痛、舌质暗红或有瘀点瘀斑、苔薄白或黄、脉弦涩。

辨证分析: 头部创伤、气乱阻滞、瘀血内停、气血瘀滞、窍络不通故见情绪不稳、呆滞、抑郁、思维缓慢、行为笨拙、记忆力减退等症。气滞血瘀、经络不通, 故见头痛如刺、胸胁胀痛。舌质暗紫、脉弦涩, 为气滞血瘀之象。

治法: 理气解郁、活血化瘀。

方药: 逍遥散加味。

柴胡 10g, 当归 10g, 赤芍 10g, 白术 10g, 茯苓 10g,
薄荷 7g, 佩兰 15g, 红花 10g, 桃仁 10g, 炮姜 10g。
水煎两次兑匀, 分两次早晚温服。

方药分析: 当归、赤芍活血化瘀、养血柔肝; 柴胡疏肝解郁; 茯苓、白术、甘草健脾渗湿; 炮姜与归、芍相配, 以调和气血, 加薄荷少许者取其疏散条达之性, 因有瘀血阻滞, 故加佩兰、红花、桃仁活血化瘀、醒脑开窍。

加减: 若头痛甚者加全蝎、僵蚕以加强通络止痛之功; 若头晕头重、呆滞淡漠宜加石菖蒲、郁金以醒脑开窍; 若口苦烦躁、情绪不稳者加黄连、竹叶以清心安神。

(3) 肝阳上亢证

主证: 情绪激动、烦躁不安、易激惹、行为冲动、伤人毁物、或头痛如震、辗转不安, 甚则突然昏仆、不省人事、四肢抽搐、口吐白沫、舌暗红、苔黄、脉弦数。

辨证分析: 创伤之后, 败血留滞, 肝阳亢盛, 迫扰于上故见情绪激动、烦躁易怒、行为冲动, 或头痛不安等精神运动性兴奋症状。肝气暴亢, 甚则化风, 风阳内动故突然昏仆、不省人事、四肢抽搐、口吐白沫等癫痫样发作证候。舌暗红、苔黄、脉弦数为败血留滞、肝阳上亢之证。

治法: 平肝潜阳、活血化瘀。

方药: 羚羊钩藤汤加味。

羚羊角粉 3g(冲服), 钩藤 30g, 桑叶 15g,
菊花 15g, 生地 30g, 白芍 30g, 甘草 5g,
贝母 10g, 竹茹 12g, 茯神 15g, 桃仁 10g,
红花 10g, 丹参 10g。

水煎两次兑匀, 分两次早晚温服。

方药分析: 方中羚羊角咸寒, 入肝、心经, 有较强的平肝

熄风作用,又善清热;钩藤苦微寒,入肝、心包经,清热平肝、熄风定惊,两药合用,则清热凉肝、熄风止痉作用更强,共为主药。桑叶、菊花协助主药清热熄风;阳亢则生火、火旺则生风、风助火势、风火相煽、耗伤阴液,故以白芍、生地、甘草酸甘化阴、滋养阴液,以平肝筋、缓解挛急;阳热亢盛,每易灼津生痰,故用竹茹、贝母清热化痰;热郁内盛、上扰心神故以茯神宁心安神。因外伤败血留滞故加红花、桃仁、丹参活血化瘀。诸药合用,共成平肝熄风、清热定痉、活血化瘀之剂。

加减:若烦躁不安、行为冲动宜加龙骨、牡蛎、生铁落以重镇安神;恶心呕吐、大便秘结宜加大黄、代赭石以和胃降逆;若癫痫性发作加全蝎、僵蚕、地龙干、天麻以祛风止痉。

(4) 肾气亏虚证

主证:精神萎靡、思维迟钝、目光呆滞、记忆力严重减退、头晕目眩、耳鸣、耳聋、腰酸腿软、舌淡苔薄、脉细弱。

辨证分析:肾主骨生髓通于脑,“脑为髓之海”,创伤日久,必致肾精不足、脑髓不充、精神失养故见精神萎靡、思维迟钝、目光呆滞、记忆力严重减退等精神衰退之症状;肾气亏虚、髓海不足故见头晕目眩、耳鸣、耳聋;腰酸腿软、舌淡苔薄、脉细,为肾气虚弱之象。

治法:补肾健脑、益髓生精。

方药:滋阴大补丸。

熟地 60g,牛膝、山药各 45g,山茱萸、杜仲、茯苓、巴戟天、五味子、小茴香、肉苁蓉、远志各 30g,石菖蒲、枸杞子各 20g。

水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析:方中重用熟地滋阴填精,集牛膝、山茱萸、杜仲、巴戟天、枸杞子、肉苁蓉补肾壮阳之品填精益髓、振奋精

神；淮山药、茯苓健脾渗湿、以资生化之源；五味子、远志养心安神；小茴香、石菖蒲辛散通窍。诸药合用具有补肾生精、益髓健脑之功效。

加减：若伴有骨蒸潮热、足膝疼热、舌红脉数乃阴虚火旺之象宜加炒黄柏、炒知母、地骨皮以滋阴清热或改用大补阴丸滋阴降火；若心惊恐惧、烦躁不安宜加酸枣仁、龙骨、牡蛎以安神镇惊；若败血留滞、头痛如裂者宜加红花、桃仁、僵蚕、全蝎以活血化瘀、止痉止痛。

3. 经验方药

(1) 急性严重创伤，昏迷不醒可选用牛黄醒脑静 10～20ml 加入 10% 葡萄糖液 500ml 中，静脉滴注，每日一次。病情严重者可重复一次，有颅压升高见恶心呕吐、颈强、瞳孔缩小应配合应用甘露醇或呋塞米。

(2) 活血止痉散(经验方)：明矾 50g、礞砂 50g、桃仁 30g、黄芪 30g、全蝎 30g、天麻 30g、炒枣仁 30g。上药共研细末制成散剂，成人每日 2 次，每次 5g，小儿减量，适用于脑外伤性癫痫。

(3) 化瘀清脑汤(经验方)：桃仁 12g、红花 12g、川芎 10g、当归 10g、丹皮 10g、赤芍 15g、佩兰 15g、蔓荆子 10g、羚羊角 2g、甘草 6g，水煎，每日一剂，适用于颅脑损伤后遗症伴有精神障碍者。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

(1) 肝阳上亢证：选百会、风池、太冲、至阴、足窍阴、太陵等为主穴，均行泻法。

(2) 气滞血瘀证：选百会、膻俞、心俞、至阴等主穴，均用泻法，另选外关、合谷、太冲行平补平泻法。

待疾病。

【现代研究】

王永恒(1989):对 104 例颅脑损伤意识障碍患者,使用安宫牛黄丸对照观察。结果:加用安宫牛黄丸治疗组有效率为 76%,常规治疗组为 41%,两组疗效比较 $P < 0.05$ 。经临床观察认为,安宫牛黄丸对颅脑损伤意识障碍患者有明显兴奋作用。当患者意识障碍处于 5~6 度时,用药后意识好转最快。安宫牛黄丸治疗组有效的 79 例中有听力者 71 例,占 90%,无效者听力均未恢复。有听力,说明大脑皮质脱抑制开始,逐渐清醒,此时应用安宫牛黄丸可明显兴奋大脑皮质而加速清醒,疗效显著。但意识障碍达 7 度以上和脑疝形成的患者,应用安宫牛黄丸无一例有效,说明安宫牛黄丸对大脑皮质处于完全抑制状态时,疗效不佳。

安丽娟等(1987):采用活血化瘀散治疗 715 例脑外伤性癫痫,方剂组成:明矾 50g、硼砂 50g、桃仁 30g、黄芪 30g、全蝎 30g、天麻 30g、炒枣仁 30g。上药共研细末制成散剂,成人每日服 2 次,每次 5g,小儿减量。观察结果:715 例脑外伤性癫痫,基本控制 187 例,占 26%;有效 395 例,占 55%;无效 133 例,占 18.6%;总有效率 81.4%。认为该方疗效优于目前临床上的其他抗癫痫药,又无副作用,对脑外伤后记忆力减退有明显改善作用。

吴丕中(1994):介绍应用活血醒脑汤配合支持疗法治疗脑外伤昏迷 21 例。全部为住院患者,其中男 13 例,女 8 例,年龄最小者 8 岁,最大者 62 岁;闭合性外伤 16 例,开放性外伤 5 例;浅昏迷 3 例,中度昏迷 14 例,深昏迷 4 例。方用红参 20g、黄芪 30g、石菖蒲 15g、郁金 15g、胆星 6g,以水 300ml 煎取 200ml,每次以 50ml 鼻饲,每日 4 次。随证加减:中度昏迷

加肉桂 4g、丹参 10g；深昏迷加肉桂 6g、丹参 10g、僵蚕 10g、竹沥 10g。治疗结果总有效率为 95%。

参 考 文 献

1. 王永恒. 安宫牛黄丸治疗 104 例颅脑外伤意识障碍临床观察. 中西医结合杂志, 1989, (9): 726~727
2. 安丽娟. 活血化瘀散治疗 715 例脑外伤性癫痫. 实用中医内科杂志, 1987, (1)83: 84
3. 吴丕中. 活血醒脑汤治疗脑外伤昏迷 21 例小结. 湖南中医杂志, 1994, 10(3): 17~18

第七节 儿 童 多 动 症

儿童多动症简称多动症,是指小儿智能正常或接近正常,其主要表现为年龄不相符的注意力易分散,注意广度缩小,不分场合的过度活动,情绪冲动并伴有认知障碍和学习困难的一组综合征。

据国外文献报道,该病的发生率在学龄儿童中达 5%~10%,在我国儿童多动症的患病率大约在 1.3%~3%左右,男孩比女孩更多见,约为 4:1~9:1。

中医学对本病的记载散见于失聪、健忘等疾病中。

【临床表现】

儿童多动症的症状多种多样,并常因年龄、所处环境和周围人对待态度的不同,而有所不同。

1. 活动过度

大都开始于幼儿早期,进入小学后因受到各种限制,表现得更为显著。有部分儿童在婴儿时期就开始有过度活动,他们表现格外活泼,会从摇篮或小车里向外爬,当他们开始学步

时,往往是以跑代步,患儿稍大,看小人书看了不几页,又捡一本,或干脆把书撕了,有时翻箱倒柜,搞得乱七八糟;进入小学后,患儿上课时小动作不停,屁股在椅子上扭动,把书本涂得不象样子,他们的手闲不住,凡能碰到的东西总要碰一下,因喜欢招惹别人,常与同学发生争吵或打架,又因患儿好插嘴和干扰大人的活动,易引起大人的厌烦,活动过度最惹人注目。

2. 注意力集中困难

这种小儿的注意力很易受环境的影响而分散,因而注意力集中的时间短暂。他们在玩积木或其他游戏时,往往也显得不专心。上课时专心听课的时间短暂,老师布置的作业常听不清,以致做作业时常出现遗漏,倒置和解释错误,他们对来自各方的刺激几乎都起反应,不能使无关刺激滤过,所以注意力难于集中。由于注意力集中短暂和注意分散是多动症最经常出现的症状,所以又称为注意缺陷障碍。

3. 情绪不稳,冲动任性

多动儿童由于缺乏克制能力,常对一些不愉快刺激,作出过分反应,以致在冲动之下伤人或破坏东西,他们需要什么,必须立刻满足。他们的情绪不稳,会无故叫喊或哄闹,又无耐心,做什么事情都急急匆匆,冲动任性是多动症的突出而又经常出现的症状,为此,有些学者将其作为核心症状来看待。

4. 学习困难

多动症儿童的智力水平大多正常或接近正常,然而由于以上症状,仍给学习带来一定困难,临摹图画时,他们往往分不清主体与背景的关系,不能分析图形的组合,也不能将图形中各部分综合成一整体,有些多动儿童将“6”读成“9”或把“d”读成“b”,把“an”写成“na”,“郎”写成“陆”,“党”写成“堂”等,甚至分不清左或右,前者的改变,属于综合分析障碍,后者

属于空间定位障碍。他们还有诵读,拼音,书写或语言表达等方面的困难,多动症儿童未经认真思考就回答,认识欠完整,也是造成学习困难的原因之一。

【诊断和鉴别诊断】

因到目前为止,尚无明确的病理变化作为诊断依据,所以目前仍主要是以患儿的家长和老师提供的病史,临床表现特征、体格检查(包括神经系统检查)精神检查为主要依据。

1. 诊断

(1) 症状标准:与同龄的大多数人相比下列症状更常见,需具备下列行为中的八条:

- 常常手或脚动个不停或在座位上不停扭动(年长或少年仅限于主观感到坐立不安)。
- 要其静坐时难以安静坐。
- 容易受外界刺激而分散注意力。
- 在游戏或集体活动中不能耐心地排队等待轮换上场。
- 常常别人问话未完即抢着回答。
- 难于按别人的指示去做事(不是由于违抗行为或未能理解所致),如不做完家务事。
- 在作业或游戏中难以保持注意力集中。
- 常常一件事未做完又换另一件事。
- 难以安静地玩耍。
- 经常话多。
- 常打断或扰乱别人的活动,如干扰其他儿童的游戏。
- 别人和他(她)说话时常常似听非听。
- 常常丢失在学校或家中学习和活动要用的物品(如玩具、铅笔和作业本)。
- 常常参与对躯体有危险的活动而不考虑可能导致的后

果(不是为了寻求刺激)。

(2) 病程标准:通常为7岁前起病,病程持续6个月以上。

(3) 排除标准:不是由于广泛性发育障碍、精神发育迟滞、儿童期精神障碍、器质性精神障碍、神经精神系统疾病和药物副作用等引起。

(4) 严重程度分类

① 轻度:症状符合或稍微超过诊断标准所需症状,仅有微小的或没有学校和社会功能的损害。

② 中等:症状和损害在轻度和重度之间。

③ 重度:超过诊断标准所需症状很多,有明显而广泛的或学校或家庭和伙伴关系的社會功能的损害。

2. 鉴别诊断

有六种主要病症出现类似多动症的症状,应予鉴别:精神发育迟滞;孤独障碍;抑郁症;慢性社会环境问题引起;抽动秽语综合征或多种抽动综合征;其他行为障碍,如品行障碍、对抗行为等。

【临床治疗】

1. 辨证要点

(1) 先天不足及后天失护两大致病因素:现代医学认为本病是因先天不足及后天失护两大因素所致,所谓先天不足系指孕妇妊娠期、围产期的各种疾病影响胎儿正常发育,造成胎儿禀赋不足。后天失护多因产伤和婴儿期高热、上呼吸道感染等疾病,以及外伤、饮食不节、社会与心理方面的不良因素,伤害了小儿“稚阳稚阴”之体。

(2) 阴阳失调,脏腑功能不足,瘀血内阻,是其主要的发病机制:《素问·生气通天论》云:“阴平阳秘,精神乃治”。人

体正常生命活动和神志状态,是阴阳保持对立统一协调关系的结果。反之,阴阳失调则是机体神志反常的基本病理之一,儿童多动症的主要症状是神不定、志无恒、情无常、性急躁等神志异常的表现,其实质则属于阴阳失调,临床上则可分为阴虚阳亢与虚阳浮动两类。小儿素体形质柔脆,阴津不充,加之发育迅速,对阴津所需甚多,因此每易形成阴虚阳亢的病理变化,常见神志不守,烦急喜语,多动不停,喜凉恶热等一系列症状。同时也与阳气盛衰相关,若阳虚不能根于阴,则发生外浮,浮则动,小儿称之为“纯阳之体”,实则阳气未充,故其阳气或因先天不足,或因后天失护,损伤而虚,虚则外浮神动,于是出现神志不宁,多动多语等一系列症状。

儿童多动症的一系列临床症状,多与精神、思维、情感有关,现代医学认为主要是脑功能轻微失调,而中医理论则认为与儿童脑髓不足与肾阴稚弱相关,而病证之发生,则又是以心为主导兼及肝肾脾等脏腑的病理变化,表现为这四脏生理功能失常的反映。

此外,因产伤、颅脑损伤或跌倒损伤以及罹患疾病等多种因素而致血行不畅,瘀血内停,脑海失养,神动智变,心神不宁而引起的以神思涣散,注意力不能集中,活动过多,学习困难,伴面青唇紫、毛发不荣等为主要表现的瘀血内阻型多动症在临床上亦较多见。

2. 辨证论治

(1) 瘀血内阻证

主证:神思涣散、注意力不能集中、学习困难、多动不安、冲动任性、神情恍惚、毛发枯荣、青筋显露、巩膜有青灰色伤斑甚则而色青紫、舌质偏暗或有瘀点、舌下脉络瘀阻、脉沉涩或细涩、结代。

辨证分析：脑为精神元神之府，由髓汇集而成，主管人体精神意识和思维活动，而脑与脏腑关系甚为密切，脑之功能活动需要脏腑的精微气血作为物质基础。正如《灵枢·平人绝谷篇》所曰：“五脏安定，血脉和利，精神乃居”。肾藏精，主骨生髓充脑，若产伤，颅脑受损或跌倒损伤以及罹患疾病等多种因素而致血行不畅，甚至停滞凝聚，或离经之血积于体内，影响气血运行以致新血不生、髓海不足、神智失聪，而出现注意力不集中，学习困难等，又人体精神活动的正常维持，赖阴阳的平衡与协调，即所谓：“阴平阳秘，精神乃治”（《素问·生气通天论》）。阳主动，阴主静，两者充盛和谐，动静结合，相辅相成，使情志动静正常而不病。若瘀血内阻，新血不生，阴血不足，阳气无所附，虚阳因之外浮而动，以致出现多动不安，冲动任性等症，病久入络，血脉瘀结，气滞不行，出现巩膜青灰色瘀斑，青筋显露等现象，血脉瘀结，气血不荣，故神情恍惚，毛发枯干，甚则面青唇紫。舌质青紫，或有瘀点、舌下静脉瘀阻、脉沉涩或细涩、结代等均为瘀血内阻、气血不畅之征象。

治法：活血化瘀，养血生精，宁神益智。

方药：活血安神汤。

桃仁 10g，红花 10g，川芎 5g，赤芍 5g，
石菖蒲 10g，益智仁 10g，山萸肉 10g，熟地黄 10g，
黄精 10g。

水煎两次兑匀，分两次早晚各一次温服。

方药分析：方用桃仁、红花、川芎、赤芍活血化瘀、舒通血脉，使之气血调和则精神自安；山萸肉、熟地黄、黄精滋阴养血、补肾益精，使之肾气健、意志坚，以补先天不足；石菖蒲、益智仁开窍益智，使之恢复其聪慧。诸药合用具有活血化瘀、养血生精、宁神益智之功效，临床运用每每获效。

加减：若好动不宁、行为冲动加龙骨、牡蛎以重镇安神；若精神疲乏、心悸气短，伴气虚症状者加黄芪、当归以益气养血；若纳呆食少、面色萎黄、四肢乏力宜加党参、白术、茯苓、淮山药以健脾益气；若兼见五心烦热、少寐多梦、身体羸瘦、舌红少苔为兼阴虚阳亢之候宜加龟板、生地、知母、黄柏以育阴潜阳。

(2) 阴虚阳亢证

主证：神思涣散、急躁易怒、多动多语、冲动任性、难以自控、注意力不能集中、指甲发泽不荣、口十咽燥、盗汗、舌质红、少苔或无苔、脉细数或弦细。

辨证分析：该证型主要病机为阴阳失调、肾阴不足、肝阳偏旺之证。造成肾阳亏乏的主要原因多为先天(肾阴)不足，或后天损伤(肾阴)。肾主骨生髓，脑为髓之海，肾之阴精不足，脑髓失充，又可累及心神，故有思维短暂、注意涣散、记忆不强、心神不宁、学习困难等；肝藏魂，肝阳亢旺，魂失所藏，则有神荡无主、夜寐不安、梦游梦呓、少于谋虑、性情急躁易怒、冲动。该证型患儿之证候，一派躁动之象，如神思涣散，难以自控，冲动急躁，多动不安，攀跃登高，不知腠腴羞涩，粗暴少礼而不分亲疏，舌红少苔，脉数弦细等，其阳亢之象实本于阴泽虚乏，实为阴虚阳亢。

治法：滋养肾阴、平肝潜阳、宁神益智。

方药：左归饮加味。

熟地 20g，山萸肉 10g，枸杞 10g，茯苓 10g，
淮山药 15g，炙甘草 6g，知母 10g，黄柏 10g，
龟板 15g，女贞子 10g，生龙牡 15g，石菖蒲 10g。
水煎两次兑匀，分两次温服，每日一剂。

方药分析：本方为壮水之剂，主真阴肾水不足、阴虚阳亢，或神不守舍之证。方中以熟地为主药，入肝肾二经，填骨

髓，长肌肉，补五脏内伤之不足，强骨长志，滋肾水，益真阴；张景岳治形质之证首选首任，谓其性禀至阴，气味纯静，“阴虚而躁者，非熟地之静不足以镇之”。辅以山萸肉、枸杞，山萸固精秘气强阴、安五脏、通九窍，枸杞平补肝肾、益精聪智，两味相偕，滋补肝肾之阴，使水旺以制火；佐以茯苓、山药、炙甘草，滋养脾胃之阴，使土润可以养肺滋肾、阴平则阳秘；方中加知母、黄柏、龟板，增其滋阴潜阳壮水功能，女贞子、生龙牡平肝潜阳，重镇安神，石菖蒲化浊通窍、宁神益智。全方合用，共奏滋阴潜阳，镇静安神之功。

加减：若神思涣散，注意力不集中，记忆力差宜加益智仁、乌药以益智通窍。若夜寐不安，磨牙切齿，手足搐动者宜加酸枣仁、夜交藤、钩藤、白芍以平肝止痉、镇静安神。

(3) 阳气不足证

主证：神思涣散，注意力不能集中，多动但不冲动，神疲乏力，面色萎黄，纳少便溏，或夜寐多梦，腰膝酸软，形寒肢冷，舌淡苔润，脉濡弱或虚弱。

辨证分析：禀赋不足，伤食或病后失养，致脾气虚弱，心气耗损，脾为至阴之脏，其性静，藏意，在志为思，脾虚则静谧不足而思虑不周，言语冒失，兴趣多变，虽然自悟而不能自制。《灵枢·本神》中说，“因志面存变谓之思”，思虽为脾之志，但亦与心有关，故心脾不足则见神思涣散。心主血藏神，心血之生成必赖于心气之化生，血脉之运行又赖心气之推动，两者相互影响，气虚则血亦不足，血虚则气亦衰微，心血不足，心神失养，则见面色少华，心惊健忘，心气不足，则见神疲乏力、惕然而惊。脾虚运化失职，则面色萎黄、纳呆便溏、舌质淡苔白、脉濡弱皆为心脾不足之象。

若是由于小儿先天不足，肾之虚亏，或由后天久病及肾，

苦寒清心泻火,半夏和胃降逆、燥湿祛痰为主药;陈皮理气和胃、解郁祛痰;茯苓淡渗利湿、健脾安神;竹茹清热除烦、开郁涤痰;枳实行气导痰;生姜散痰浊通窍络;甘草、大枣调和诸药。诸药合用,化痰而不助热,清热而不寒滞,热去痰消,温和少阳之胆气,则胆气宁,精神安,诸症自除。

加减:若烦躁不安,面赤口臭,大便秘结者宜加大黄、黄芩、栀子以清热除烦,若痰多胸闷,情绪不稳者宜加礞石、沉香以逐痰开窍。

3. 经验方药

(1) 静安汤口服液(制剂):处方同上,每次10~15ml,每日3次,适用于瘀血阻滞型小儿多动症。

(2) 醒脑静注射液:每次4ml,肌肉注射每日一次,15日为一疗程。该药用于小儿多动症伴见急躁易怒、多言多语、行为冲动等精神运动性兴奋症状。

(3) 熟地黄30g、山萸肉30g、龙齿10g、川菖蒲5g、丹参10g、僵蚕10g、佩兰10g、益智仁10g、甘草5g,水煎两次兑匀,分两次温服。该方用于体质虚弱之儿童多动症患者。

【其他疗法】

1. 针灸治疗

主穴:内关、太冲、大椎、曲池。

配穴:注意力涣散配百会、四神聪、大陵穴;活动过多者配定神、安眠、心俞;情绪不稳、烦躁不安者配神庭、膻中、照海穴。

手法:均为泻法,或平补平泻,不加灸,每日或隔日一次,10次为一疗程。

2. 单方验方

(1) 淮小麦30g、生地10g、红枣10g、百合10g、炙甘草

6g,水煎服每日1剂。

(2) 红枣10枚、黄精20g、龙眼肉15g,熬汤作辅食多用于心脾两虚证。

(3) 胡桃肉、荔枝干炖瘦肉用于肾虚、先天不足型多动症,为食补之用。

【预防与护理】

随着多种治疗方法的应用,儿童多动症的预后是较好的,但如不治疗,多动症儿童到成人时,大约有1/3发展为:①多动症的残留症状;②反社会的人格障碍;③酒精依赖;④癔病、焦虑症和一些类似精神分裂症。因此应引起家长的重视。

儿童多动症的治疗除药物外,应积极配合心理治疗,主要为认知行为治疗。该疗法对控制多动行为、冲动控制和侵犯行为有较好的效果,有条件应该让多动症儿童参加社会化的技能训练,增加儿童与社会接触的机会。同时可从渐进的躯体训练项目得到益处,指导他们控制冲动和侵犯行为,使他们听从指导,增强自尊心和自信心,如参加健身、田径运动、游泳及网球等项目。

此外,父母双方需要特殊的教育,以了解如何以较和谐的方式与孩子相处在一起,学习如何选择较合理的期望水平,父母必须学习如何建立良好的方式限制某些行为,也指导其完成一些家务劳动并负一定责任,这些方法均有利于儿童多动症的康复。

【现代研究】

静灵口服液治疗儿童多动症(1989):全国16个医疗、科研单位,共观察治疗儿童多动症“肾阴虚,肝阳亢”证患儿557例,其中男性454例,女性103例,男女之比为4:1,年龄最

小者4岁,最大16岁,平均年龄9.5岁,病程最长16年,最短者半年。557例全部采用静灵口服液治疗,3~5岁每日10ml,6~14岁每日20ml,15岁以上每日30ml,分早晚2次服,在治疗过程中,始终未加用其他药物或疗法,30日为一疗程。治疗结果,临床治愈144例(占25.8%),显效127例(占22.8%),有效246例(占44.2%),无效40例(占7.2%),总有效例数517例,总有效率92.8%。其中见效最快者6日,最慢者60日,疗程最长者180日,最短者20日。其中症状疗效:注意缺陷的总有效率97%,活动过多91%,学习困难88.2%,冲动行为87%。经治疗后,学习成绩普遍提高和稳定。静灵口服液主要药物组成:熟地、山药、女贞子、五味子、茯苓、丹皮、泽泻、远志、龙骨等。

张横柳等(1990):内服小柴胡汤加减(柴胡6~12g,黄芩5~10g,象牙丝10~15g,黄芪30~60g,党参10~15g,女贞子10~15g,淡竹叶5~10g)治疗儿童轻微脑功能障碍综合征(MBD)80例为中药组,同时以单服哌醋甲酯治疗MBD20例为对照组。结果:中药组有效率为86.25%,对照组有效率为90.0%,两组疗效比较 $P>0.05$ 。无显著性差异,但中药组副作用出现远少于对照组,同时在改善智商、遗尿、眼眶黧黑等方面,中药组优于对照组,研究还表明韦氏儿童智力量表中的言语分量表是MBD的诊断和疗效观察的一项客观指标。

参 考 文 献

1. 冷方南等.主编《儿童多动症临床治疗学》.北京:中国医药科技出版社,1989
2. 张横柳等.儿童轻微脑功能障碍综合征的中医治疗初探——附100例分析.中西医结合杂志,1990,(5):278~279

第八节 更年期精神病

更年期精神病,是指初次发病于更年期,临床症状以焦虑、抑郁、紧张和猜疑为主要特征,并伴有自主神经和性腺内分泌功能障碍,多数起病缓慢,少数急性起病,一般以女性多见,年龄男性 50~60 岁,女性 45~55 岁。常见有更年期综合征、更年期抑郁症和更年期偏执状态等三种类型。

中医学对本症记载散见于“郁证”、“脏躁”、“经断前后诸证”等病症中。

【临床表现】

1. 更年期综合征

主要表现为内分泌及植物神经功能紊乱和神经衰弱等症状。病人常诉头痛、头晕、心悸、胸闷、情绪不稳、易激惹和疲劳感等。并伴有身体忽冷忽热,尤其面部灼热感、多汗、食欲不振、便秘、月经失调和性功能减退等症状。有的表现抑郁和痛苦表情,病程较长,有的可发展为更年期抑郁或偏执状态。

2. 更年期抑郁

起病较慢,多数由更年期综合征发展为抑郁状态,焦虑不安、搓手蹬足、坐卧不宁、惶恐不可终日、似有大祸临头、自责自罪、疑病观念,对身体上微小变化或不适,则被认为发生不治之症,危在旦夕,常为此不停纠缠医护人员,反复诉说躯体不适,可出现消极自杀或自伤行为。

3. 更年期偏执状态

以各种妄想为主要症状,常见有嫉妒妄想、疑病妄想、虚无妄想或被害妄想等,有的伴幻听或内感性不适。由于妄想的支配,可产生拒食、自伤或自杀等行为。

气渐虚，冲任脉衰，失去了生殖功能，脏腑的功能也逐渐减退，机体平衡失调，百病由生，肾气虚衰中又有偏肾阴虚，偏肾阳虚之不同，久之阴损及阳，阳损及阴，可致肾阴肾阳俱虚，因而中医视肾虚为更年期综合征的基本病机，治疗中必以肾为论治根本。

气滞血瘀：并不是所有妇女进入更年期后都出现更年期精神障碍，本病的发生发展受体质、孕育、营养、社会环境、精神状态等因素的影响。有人认为女子以肝为先天。肝藏血，主疏泄，特别是愤怒和抑郁常使肝的疏泄功能失常而出现肝气郁结，气机失调，进而可出现肝血瘀结，气滞血瘀的各种病理现象，突出表现为健忘、不寐、多梦、烦躁、易怒、胸胁痞满，甚至暴躁发狂等情志障碍的病症。

痰湿内阻：肾气虚衰，脏腑功能失调，往往导致水湿津液在体内气化异常，积聚成痰湿，成为有害的病理性产物。痰湿内扰可见眩晕失眠、情绪烦躁、胸闷惆怅，或多猜多疑，甚则出现神智呆滞、语无伦次、哭笑无常等精神障碍的症状。

(2) 中西参合提高诊断正确率：更年期精神病所列诸症，并非每一个具体患者全部具有，各类证候也往往轻重不一，参差出现，持续时间或长或短，因此要求对于具体的病情进行具体的分析，进而辨证求因，审因立法，分清主次，以法定方。西医对本病的诊断，强调结合年龄特点，月经变化，尤其是精神和自主神经系统功能紊乱为主的症状为主要依据。妇科检查可见生殖器官出现不同程度的萎缩，全身的第二性征亦渐见衰退现象。在对本病进行诊断时，可中西医相互参考以提高诊断准确率。

2. 辨证论治

(1) 阴虚阳亢证

主证：潮热汗出、心烦易怒、头晕头痛、手足心热、失眠盗汗、腰酸耳鸣、月经量少或闭经、舌红少苔、脉弦细数。

辨证分析：值经断之年，肾气渐衰、冲任亏损、阴血不足，复以平时劳心过度，营阴暗耗，阳失潜藏。肾阴亏虚，水不涵木，肝阳上亢，则见腰酸耳鸣、头痛、眩晕；阴虚内热，故手足心热；虚火内扰，则心烦易怒、失眠盗汗；阴虚火旺、虚火上炎，故潮热汗出；肝肾阴耗，冲任空虚故月经量少或闭经；舌红少苔、脉弦细数均为阴虚内热之象。

治法：补益肝肾，滋阴潜阳。

方药：六味地黄汤加味。

熟地 20g，山萸肉 15g，泽泻 10g，山药 20g，
丹皮 15g，茯苓 12g，龙骨 15g，牡蛎 15g，
石决明 15g，白芍 15g。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：“壮水之主，以制阳光”，“精不足者，补之以味”。方中重用熟地，甘温，滋肾填精为主；山药甘平，补益脾阴而固精；山萸肉酸温养肝肾而涩精，两药相辅，合熟地滋肾阴、养肝血、益脾阴。肾阴亏虚、虚火上炎、故配泽泻清泄虚火；茯苓淡渗脾湿，丹皮清泄肝火，合为佐使。加龙骨、牡蛎、石决明、白芍滋阴潜阳以平抑阳亢之势。

加减：若阴虚火旺，骨蒸潮热，加知母、黄柏以滋阴降火；若耳鸣目眩加菖蒲、磁石、五味子以滋阴通窍；头痛甚者加蔓荆子、白芷、菊花以平肝祛风止痛；腰膝酸软，加川断、桑寄生、牛膝以补肾壮腰。

若肾阴亏虚而不能上济心火，则心火亢盛导致心阴虚，而见心悸失眠、烦躁不安、多梦易惊、情志异常、口燥咽干，治宜滋肾宁心安神，方用补心丹。

若肾阳虚衰,温煦失常,证见面色晦暗、精神萎靡、疲倦无力、畏冷肢寒、腰背酸痛、舌淡苔薄白、脉沉细无力。治宜温补肾阳,方用右归丸。

(2) 气滞血瘀证

主证:情绪不稳、心烦易怒、反复无常、胸胁胀痛或周身刺痛、潮热汗出、心悸失眠、恶梦连连、心中烦热、头痛头晕、焦虑抑郁、舌青紫或有瘀斑、脉弦而涩。

辨证分析:妇人绝经之年,经历了经、孕、产、乳几个阶段,导致肝血屡伤。常因七情内伤,使肝的疏泄功能失常而出现肝气郁滞、气机失畅,故见情绪抑郁,胸胁胀痛;气滞血瘀,瘀久化热,上扰心神故见潮热汗出、情绪不稳、心烦易怒、反复无常、心悸失眠、恶梦连连;瘀血阻滞、气滞于内、清阳不升,则见头晕头痛、焦虑抑郁。舌青紫或有瘀斑、脉弦涩均为瘀血阻滞之象。

治法:活血化瘀,理气解郁。

方药:血府逐瘀汤加味。

当归 9g,川芎 5g,赤芍 6g,地黄 9g,牛膝 9g,
柴胡 9g,枳壳 6g,甘草 3g,桔梗 5g,桃仁 12g,
红花 9g,香附 9g,鸡血藤 30g。

水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析:血府逐瘀汤重在理气解郁、活血化瘀,加香附、鸡血藤,调经理气,养血活血,以达到理气不伤气,祛瘀不伤血之目的。

加减:若焦虑抑郁重者,加合欢皮、忘忧草、百合、大枣以解郁安神;失眠多梦、易怒善惊,加琥珀,以活血散瘀、镇静安神;心烦急躁、口苦咽燥加栀子、淡豆豉,以清热除烦;心悸不安,加丹参、远志,以活血安神;食欲不振,纳呆胀闷,加神曲、

玫瑰花,以消食和中,理气化浊。

(3) 痰湿内阻证

主证:头晕头沉如裹、面部虚浮、身肿或四肢浮肿、胸闷、坐卧不安、大便溏薄、惊悸多梦、甚则神志呆滞、语无伦次、猜疑善惑、哭笑无常、舌淡胖大、苔厚腻或湿滑、脉缓沉迟。

辨证分析:肾气虚衰,脾阳不振,运化失司,津液水湿停留而化为痰湿,痰湿上蒙清窍,则见头晕头沉如裹;水湿不化,溢于全身,则见面部虚浮、身肿或四肢浮肿;痰阻中焦,则纳呆胀闷、坐卧不安、大便溏薄;痰湿内扰,痰迷心窍,则见惊悸多梦、神智呆滞、语无伦次、猜疑善惑、哭笑无常等精神异常的表现;舌淡胖大,苔厚腻,脉缓沉迟均为脾虚失运、痰湿内阻之象。

治法:祛湿化痰,健脾和胃。

方药:温胆汤加味。

陈皮 12g,茯苓 15g,半夏 10g,甘草 6g,
竹茹 10g,枳壳 10g,合欢花 15g,厚朴花 10g,
仙灵脾 10g,炒白术 10g。
水煎两次兑匀,分两次温服。

方药分析:方用温胆汤燥湿化痰、清热除烦,加厚朴花、炒白术理气健脾;仙灵脾益肾温阳;合欢花解郁安神。诸药合用具有标本兼治、相得益彰。

加减:若纳呆腹胀,加神曲、大腹皮、莱菔子,以消食和中、行气利湿;心悸不安,加远志、柏子仁、龙齿,以安神定志;痰迷心窍、精神异常加南星、石菖蒲、郁金、贝母,以化痰开窍。

3. 经验方药

(1) 刺五加注射液 20~40ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日一次,15 日为一疗程,周日休息。适用于更

年期综合征,主要表现为内分泌及自主神经功能紊乱和神经衰弱等症状。

(2) 健脑忘忧汤(制剂,方药见前)主要适用于更年期抑郁症。

(3) 女贞子、炒枣仁、生地、白芍、枸杞、杭菊、黄芩、生龙齿、珍珠母各等分,制蜜丸,每次 6~9g,每日 2 次,3 个月为一疗程。主要用于更年期综合征。

【其他疗法】

1. 针灸治疗

(1) 阴虚阳亢型

主穴:太溪、三阴交、太冲、水沟、内关。

配穴:头痛加列缺,头晕加印堂,汗多加合谷、复溜。

(2) 气滞血瘀型

主穴:血海、三阴交、天枢、水沟、内关、章门。

配穴:兴奋躁动加十宣、人中、足三里、内关等。

(3) 痰湿内阻型

主穴:丰隆、地机、足三里、蠡沟、水沟。

配穴:忧郁状态加少商、隐白。

(4) 耳针

取穴:卵巢、屏间、神门、下脚端、脑、心、肝、肾。

刺法:每次选 3~4 穴,中等刺激,隔日针刺一次。

2. 单方验方

(1) 浮小麦 30~90g、大枣 30~90g、炙甘草 10g,加水浓煎后,去甘草(药渣),一次服下,并淡食大枣及浮小麦。适用于以忧郁、烦躁为主要表现的更年期综合征。

(2) 红枣 10~20g、龙眼肉 30g,糯米适量,水煎当粥,入睡服,具有健脾安神之功效。

(3) 鲜鳖一只(250g 左右)、枸杞 30g,炖服,每 2~3 日一次,10 次一疗程。具有滋阴补肾之功效,治疗更年期综合征,疗效显著。

【现代研究】

张文等(1990):采用活血化瘀药为主自制养血宁神丸治疗更年期综合征 100 例,对照组 30 例。治疗方法:养血宁神丸用当归、川芎、丹参、益母草、五味子、生地、朱茯神、合欢皮等 10 味中药制成蜜丸,每丸重 9g,每日 3 次,每次 1 丸。对照组服维生素 E50mg,每日 3 次,两组均以 20 日为一疗程,观察 2 疗程。养血宁神丸组:治愈 76 例,好转 22 例,无效 2 例,总有效率为 98%。对照组:治愈 2 例,好转 12 例,无效 16 例,总有效率为 46.7%。两组治疗期间未用其他药品, $P<0.001$,非常显著性差异。经观察养血宁神丸对更年期综合征的临床症状有明显改善作用,并有降低血压,改善舌象,改善心电图指标等作用,一般服药 10 天后即可见效。

廉南等(1990):运用中药补肾法治疗更年期综合征的同时,为观察活血药对传统补肾疗效的影响,在部分患者中加用活血之品,并与单纯补肾法进行对照观察,每组各 30 例。活血补肾观察组:女贞子 20g,枸杞 15g,桃仁、红花各 12g,枣皮 12g,当归 9g、鸡血藤 20g。单纯补肾对照组:女贞子 20g、枸杞 15g、生地 20g、枣皮 12g、天冬 15g。用法:两组患者分别将上述处方水煎沸 1h 左右,取汁约 300ml,晨起时服用。2 个月后总结疗效。治疗结果:活血补肾观察组治愈 5 例,显效 11 例,好转 8 例,无效 6 例;对照组治愈 3 例,显效 4 例,好转 9 例,无效 14 例。两组结果经卡方检验 $P<0.05$,有显著性差异。作者认为,配用活血药物后能够提高补肾药治疗更年期综合征的临床疗效。可能与活血药物能增加血流量,改善微循环等作

用有关,由此提出,补肾法治疗更年期综合征,当以加用一定的活血药物为宜。

郑国平等(1990):文章观察更年期综合征女性血中高密度脂蛋白亚组分和其他脂质含量的变化,并重点观察中药补肾佐活血治疗对上述脂质含量的影响。观察组口服滋肾镇摄佐以活血的中药(生熟地、何首乌、枸杞子、菟丝子、淫羊藿、山药、枣仁、珍珠母、鸡血藤等),水煎,每日一剂,平均疗程为两个月,对照组不服用任何药物。实验研究结果表明:滋肾镇摄佐以活血的中药能有效地缓解更年期综合征症状。同时有使抗动脉粥样硬化的高密度脂蛋白升高的作用。

参 考 文 献

1. 张文等.养血宁神丸治疗更年期综合征 100 例.陕西中医,1990,11(9):405
2. 廉南等.活血补肾法与补肾法治疗更年期综合征临床观察.云南中医杂志,1990,(3):22
3. 郑国平等.中药对更年期综合征女性高密度脂蛋白亚组分和其他脂质含量的影响.中医杂志,1990,(1):30

第九节 睡 眠 障 碍

人生的三分之一时间是在睡眠中度过的,睡眠与健康的关系历来受到人们的重视。近年来对睡眠的生物学基本过程的研究有了重要突破,在诊断和治疗睡眠障碍方面有许多进展,自从 50 年代 Aserins 及 Kleitman 应用脑电波检查区分出睡眠的一种特殊状态——异相睡眠以后,对睡眠分期以及各睡眠周期中的生理、生化、内分泌的改变也都有了比较详细的了解,世界上已建立了多个睡眠研究中心,并从睡眠脑电波

的改变中探索不同精神疾病及药物反应的特点。对精神疾病的诊断与精神药物的作用机制提供了许多有价值的资料。现已了解到,睡眠并不是神经细胞的完全抑制,而是改变其活动方式。某些部分处于失活状态,而另一些部分却被激活,它是一种主动调节重新组合以及整顿的过程,睡眠也关系到清醒。失眠会部分地影响到清醒,而清醒的质量也决定着睡眠的质量,这是一条十分基本,但常被遗忘的原理,研究睡眠与醒觉的障碍,具有重要的临床意义,本章节讨论的主要是失眠症和嗜睡症。

一、失眠症

失眠症是持续相当长时间的对睡眠质和量的不满意状况。睡眠时间的长短不能作为判断失眠严重程度的标准,对失眠的焦虑恐惧心理可形成恶性循环,从而导致症状持续存在。引起失眠的原因可有躯体因素、生物药剂因素,亦可由其他神经精神疾病所引起,但最常见的原因是精神紧张、焦虑恐惧、担心失眠所致,有称为原发性失眠症。此外,如白天生活的影响,个性人格特征,自动不良睡眠习惯以及遗传因素等都可成为引起持续失眠的原因。近年来,国际上对睡眠“生物钟”机制受到重视。由于环境影响,人为地延长了昼夜节律也可产生失眠。

中医学对本病的记载散见于“不寐”、“不得眠”、“不得卧”的病证中。

【临床表现】

失眠症临床表现有入睡困难、睡眠不深、易惊醒、自觉多梦早醒、醒后不易入睡、醒后感到疲乏或缺乏清醒感、白天思睡等。患者常对失眠感到焦虑和恐惧,严重时还可影响其工作效率和社会功能。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 以不易入睡,或睡而易醒,甚则彻夜难以入寐等失眠为主要临床症状。

(2) 本病常兼见头晕、头痛、心悸、健忘、梦多、易于激动及烦躁等临床表现。

(3) 多发生于脑力劳动者,以中年为多见,且起病缓慢,其发病与精神因素关系较为密切。

(4) 神经系统检查无明显的阳性体征,机体无明显器质性病变。

2. 鉴别诊断

诊断失眠症需排除各种躯体疾病或其他精神疾病所伴发的症状。焦虑症以入睡困难为主,抑郁症常表现顽固性早醒。由于患者对失眠严重程度往往有估计过重的倾向,睡眠脑电波检查有助于了解实际情况和变化特点。

【临床治疗】

1. 辨证要点

失眠的主要病机是机体脏腑阴阳失调,气血失和,以致心神不宁。如《灵枢·大惑论》曰:“卫气不得入于阴,常留于阳,留于阳则气满,阳气满则阳蹻盛,不得入于阴则阴气虚,故目不瞑矣。”《灵枢·营卫生会篇》认为:“老者之气血衰,其肌肉枯,气道涩,五藏之气相搏,其营气衰少而卫气内伐,故昼不精,夜不瞑。”《医林改错》提出“夜不安者”是因“血府血瘀”,强调了瘀血不寐的病机。失眠虽然病因病机各有不同,但总以虚实论证,虚证多属阴血不足,心脑失其所养,临床特点为体质瘦弱,面色无华,神疲懒言,心悸健忘,多因脾失化源,肝失藏血,肾失藏精,脑海空虚所致。实证为火盛扰心,或瘀血阻滞,

热重而大便不通者，可加服礞石滚痰丸，降火泻热，逐痰安神。

(3) 心肝火旺证

主证：情绪激动、烦躁不安、心烦意乱、辗转难眠、口苦咽燥、小溲短赤、舌红苔黄、脉弦数。

辨证分析：失眠与情绪变化最为相关，肝主疏泄，情志所伤每致肝气郁结，气郁化火，上扰心神，所谓肝木有余，必致心火亢盛，心肝火旺，则见情绪激动、烦躁不安、心烦意乱、辗转难眠；心火上扰、下移小肠，故见口苦咽燥、小溲短赤；舌红苔黄、脉弦数均为心肝热象的表现。

治法：疏肝泻火，清心安神。

方药：龙胆泻肝汤。

龙胆草 6g，黄芩 9g，栀子 9g，泽泻 12g，
木通 9g，车前子 9g，当归 3g，生地黄 9g，
柴胡 6g，生甘草 6g。
水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：本方为清泻肝火的代表方，适用于肝胆实火或心肝火旺所致的失眠症，方用以龙胆草苦寒泻肝胆实火为主药；黄芩、栀子苦寒泻火，协助龙胆草以清肝胆湿热，共为辅药；泽泻、木通、车前子清肝利湿，引火从小便而出，肝藏血，肝有热则易伤阴血，故用当归尾活血，生地养血益阴；柴胡疏畅肝胆，甘草调中和药诸药相伍，共奏清肝泻火，安神镇惊之效。可加茯神、龙骨、牡蛎以镇惊定志，安神入眠；如胸胁胀，善叹息者，加郁金、香附疏肝解郁。

加减：若患者平时多疑善虑、多愁善感，为肝郁气滞，常见夜难入眠、多梦易惊、胸胁胀满、善喜叹息、舌红、脉弦，当从疏肝解郁，泄热除烦，常用丹栀逍遥散。

(4) 心脾两虚证

主证：失眠、多梦易醒、或早醒不能再睡、心悸健忘、体倦神疲、纳食呆滞、面色少华、头晕目眩、精神不振、舌质淡、脉细弱。

辨证分析：本证多见于病后体虚，或年老体弱、气血不足，或因思虑过度、劳伤心脾所致。伤于心则阴血暗耗，神不守舍；伤于脾则食少形瘦，血气难复。心脾两虚，血不养心，神不守舍，故失眠，不易入睡、多梦易醒、心悸健忘；气血不足，不能上养于脑，清阳不升，则头晕目眩；血虚不能上荣于面，则面色少华，舌质淡；脾虚失运，则饮食无味；血少气虚，故精神不振、肢倦神疲、脉细弱。

治法：补益心脾，养血安神。

方药：归脾汤加味。

党参 10g，黄芪 18g，白术 10g，茯神 10g，
炒酸枣仁 18g，龙眼肉 10g，木香 6g，当归 12g，
远志 10g，甘草 6g，大枣 10 枚，生姜 3g，
丹参 12g，琥珀 6g(研末冲)。
水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：笔者常用归脾汤加丹参、琥珀治疗虚症失眠，取得显著疗效。归脾汤具有补益心脾、养血安神之功效，加入丹参、琥珀活血安神，安魂定志。盖心主血脉，脾主运化，气血亏虚，很容易引起气血瘀滞的现象，故在补益中加入活血化瘀之品，常常疗效倍捷。

加减：若患者平时心气亏虚、遇事善惊、失眠多梦，或心悸心慌、容易惊醒、舌淡脉细者，当以益气安神为主，可用安神定志丸(《医学心悟》)；若偏心血虚者，可选用酸枣仁汤(《金匱要略》)、甘麦大枣汤(《金匱要略》)。

(5) 心肾不交证

主证：心烦不寐、难以入睡、头晕耳鸣、五心烦热、咽干盗汗、口舌生疮、腰膝酸软、舌红脉细数。

辨证分析：心主火，肾主水，心火下降，肾水上升，水火既济，心肾交通，阴阳平衡，神宁眠安，睡眠才能正常。若由于情欲妄动、相火偏亢，或年老肾阴亏损、心火偏旺，均可导致水亏于下，火炎于上，水不得上济，心火不得下降，心肾无以交通，而见心烦不寐，难以入睡；肾水不能上滋清窍，则见头晕耳鸣；肾虚精亏，腰脊不充，则腰膝酸软；心肾阴虚，虚火内生，则见五心烦热，盗汗，咽干，口舌生疮，舌红脉数。

治法：交通心肾，清心安神。

方药：交泰丸。

黄连 9g，肉桂 3g 蜜丸。

上药为一日量，每晚一次。

方药分析：方中以黄连清心降火，少佐肉桂，以引火归元，交通心肾，神安而眠。

加减：若以心阴虚为主可用天王补心丹（《摄生秘剂》），若以肾阴虚为主者，可用六味地黄丸（《小儿药证直诀》）加夜交藤、酸枣仁、合欢皮、茯神之类，以安神宁志，补心滋肾。若阴虚火旺明显，宜用黄连阿胶汤（《伤寒论》）。

3. 经验方药

（1）安神活血汤（制剂，见前）每次服 30ml，晚上加倍，对顽固性失眠有较好的疗效。

（2）健脑忘忧汤（制剂，见前）每次服 30ml，晚上加倍，适用于失眠症伴见抑郁症状者。

（3）竹茹 10g、枳实 10g、陈皮 10g、半夏 10g、茯苓 10g、大枣 7 枚、丹参 30g、琥珀 6g 研末冲，水煎服每日一剂。笔者常在该方的基础上加减运用，疗效显著。失眠一症，病情复杂，有

些失眠很难分清虚实,常以虚中夹实,或实中有虚。由于该病病程较长,加上与情绪因素关系密切,很容易造成气血功能失调,而兼有气滞血瘀的现象,使病情更趋复杂,难以治愈。笔者在临床辨证施治的基础上以丹参、鸡血藤、茜草根、延胡索、赤芍、琥珀等活血化瘀之品加减,每每取得较显著的疗效,此为《内经》“疏其血气,令其条达,以致和平”之意。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

(1) 针刺治疗

针刺常用穴位:内关、神门、安眠、足三里、后溪。常用配穴:风池、百会、丝竹空、中脘、脾俞、肝俞、三阴交、心俞、肾俞、关元、气海、行间、命门。上述穴位可选主穴1个,配穴2~3个,交替选用,均用轻刺激,留针10min左右,其中关元、命门、气海、足三里等穴,可并用灸法。

辨证施针,心脾两虚型:补三阴交、神门、心俞、膈俞、脾俞;心肾不交型:补肾俞、太溪,泻心俞、劳宫;痰火内热型:泻神门、三阴交、肝俞、丰隆、足三里;气滞血瘀型:泻神门、血海、肝俞、期门;心肝火旺型:泻神门、内关、三阴交、肝俞、太冲、行间。每次选3~4穴,交替针刺,7~10日为一疗程。

(2) 耳针疗法

耳针疗法对失眠也有较好疗效,选穴心、肾、神门、皮质下、脑、脑干等,根据辨证,病属何种脏腑,选用相应耳穴,如肝、脾、心等;对属实证者,手法宜重,类似泻法;对属虚证者,手法宜轻,类似补法。

另外有报道,在耳穴上贴敷酸枣仁、冰片等治疗失眠症,也取得一定疗效。

2. 单方验方

中努力睁大眼睛凝视某个目标,当眼皮困乏时,抑制过程则渐渐地弥散,使其渐入梦境。亦可应用情景疗法,如居住环境的幽静,也是治疗失眠的必要条件,居住环境应尽量避免噪音,优美舒适的环境可给人美的享受,使人心情轻松愉快,有利于失眠症的治疗。

治疗本症远不是解决一个失眠症状的问题,而是要帮助病人改变社会、家庭以及病人自身的行为方式,重建心理平衡的整体措施,例如运用行为疗法帮助患者纠正不良的摄生行为,做到睡前不吸烟、不喝酒、不饮浓茶、咖啡等刺激性的东西;思想上保持恬静,人睡前不谈论易于兴奋和忧伤、愤怒的话题;适当参加一些劳动、体育锻炼,注意生活规律,按时休息,养成良好的睡眠习惯;亦可应用气功静默疗法等,使病人抑制与兴奋过程逐渐趋于协调,以期达到入睡的目的。

【现代研究】

马有度等(1989):对374例失眠患者随机分为复方酸枣仁安神胶囊(主要药物酸枣仁、延胡索等,重庆中药厂提供,每丸重0.5g,相当原生药5g)、朱砂安神丸及安眠酮3组治疗,总有效率为84.5%、67.06%、81.61%。结果表明:复方酸枣仁安神胶囊,疗效优于朱砂安神丸, ($P < 0.005$),而与安眠酮相仿($P > 0.05$)。睡眠脑电图及动物实验表明:复方酸枣仁安神胶囊疗效可靠,作用迅速安全无毒。

孔秀媿等(1992):介绍用丹栀枣仁汤治疗不寐52例,其中男性30例,女性22例,脑力劳动者36例,体力劳动者16例,年龄最大83岁,最小10岁,以30~40岁为最多。方药组成:丹皮、栀干、炒枣仁、夜交藤各10g,柴胡3g,生龙骨、生牡蛎(先煎)各30g。每日一剂两煎,一煎午睡前服,二煎睡前半小时服。适用于不寐伴有多梦、心烦、健忘、倦怠疲乏、急躁易

怒、头晕心悸等症状。结果 52 例病人中有效 42 例,占 80.77%;无效 10 例,占 19.23%。作者认为:不寐以肝郁化火,火扰心神,神不安藏为常见之因。丹栀枣仁汤用丹皮、栀子清肝泻火;生龙牡以重镇安神;酸枣仁、夜交藤养心安神,少佐柴胡疏畅肝胆之气。全方共达疏肝泻火安神之效。

张俊学等(1995):介绍血府逐瘀汤治疗不寐。共 35 例,患病时间最短 4 个月,最长 3 年。以血府逐瘀汤为基本方加减治疗,每日一剂水煎,停用其他一切药物。如多虑烦闷加香附、青皮之类疏肝理气,如表情冷默,脉迟缓乃寒凝血瘀,宜加丁香、吴萸。治疗结果:全愈 31 人,占 88.57%;好转 3 人占 8.57%;无效 1 人,占 2.86%;总有效率达 97.14%。服药最少者 7 剂,最多者 64 剂。

参 考 文 献

1. 马有度等.复方酸枣仁安神胶囊治疗失眠症疗效观察及药理研究.中西医结合杂志,1989,(2):85~87
2. 孔秀妮等.丹栀枣仁汤治疗不寐 52 例效果观察.安徽中医学院学报,1992,(11)2:19
3. 张俊学.血府逐瘀汤治疗不寐临床观察.中医药学报,1995,(1):28

二、嗜睡症

嗜睡指不分昼夜,时时欲睡,呼之能醒,醒后复睡的病证。常与心理因素有关。其发病原因主要由于阳气不足,瘀血阻窍或痰湿困扰所致。

嗜睡在历代文献中名称各异,最早《内经》称为“嗜卧”、“喜眠”、“目瞑”、“多卧”。《伤寒杂病论》称之为“欲寐”、“多眠睡”、“欲卧”等名,现今称之为多寐、嗜睡、嗜寐。

【临床表现】

嗜睡症常与心理因素有关,患者每天出现睡眠时间过多,或睡眠发作持续一个月以上,脑电波检查为正常睡眠脑波,睡眠觉醒后可出现短暂意识模糊状态,心率及呼吸节律增快,常可伴有抑郁情绪。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 患者以不论昼夜,不分场合地点,精神萎顿,随时都可能入睡,呼之亦能觉醒,但未几又已入睡为主要临床症状。

(2) 本病常兼见情绪抑郁、神疲乏力、头晕纳少、四肢倦怠等症状。

(3) 多见于中年以上的患者,尤以老年、肥胖之人或妇人发病率较高。

(4) 神经系统检查无明显的阳性体征,体检一般少见器质性病变。

2. 鉴别诊断

典型的嗜睡症并不难诊断,首先应排除有明显原因的疾病。如脑瘤、脑积水、颅脑损伤、脑炎、中毒等,主要应与发作性睡病作鉴别,后者呈发作性,且日间的睡眠难克制。

【临床治疗】

1. 辨证要点

嗜睡的辨证要点,首先辨清证候的虚实,虽然本病以阳气虚衰为主要病机,但由于病程较久,症状复杂,往往虚中夹实,实中有虚,久病气血留滞,而见阳虚夹瘀;脾肾虚弱,运化无权,痰湿内阻,而见虚证夹痰夹湿。本病以阳气虚衰为本,瘀血,痰浊,湿邪为标,临床上以本虚标多见。

2. 辨证论治

(1) 阳虚血瘀证

主证：怠惰嗜睡、神倦欲寐、面色㿔白、形寒肢冷、纳少便溏、气短乏力、形体虚胖、懒言少动，伴病程日久、头晕头痛、舌质紫暗或胖紫、有瘀斑、脉涩或沉细。

辨证分析：病后体虚、阳气不足，或年高久病、劳伤过度、精血亏虚、命门火衰、阳气不振、精神衰惫，故怠惰嗜睡。阳气虚，则无以煦丽肢骸，故面色㿔白、形寒肢冷。肾虚火衰，脾失温煦，脾肾阳衰，健运无权，则纳少便溏、气短乏力、懒言少动、形体虚胖。阳气虚衰，精血亏少，鼓动无力，则容易气血留滞、气滞血瘀、脉络不通，则头晕头痛；瘀血阻滞，阳气痹阻，则神倦嗜睡。舌质紫暗或有瘀斑，均为瘀血之象。脉沉细而涩为阳虚血瘀之象。

治法：温阳提神，活血通络。

方药：肾气丸合通窍活血汤加减。

桂枝 6g，炮附子 10g，干地黄 12g，山萸肉 10g，
赤芍 10g，川芎 6g，桃仁 10g，红花 6g，
老葱根三节，麝香 0.1g。
水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方中以附子、桂枝温补肾阳，地黄、山萸肉滋补肾阴，取张景岳之“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷”之义，为治病之根本。佐以赤芍、川芎、桃仁、红花，活血化瘀；麝香、葱白通阳开窍，醒脑提神。诸药合用，使阴阳调和，阳气振奋，气血通畅，醒神开窍，则嗜睡可愈。

若肾精亏虚、耳鸣耳聋、善忘、神情呆滞者宜送服左归丸（《景岳全书》），以滋肾填精，补髓健脑。若心气虚衰、心悸气短、健忘易惊，治宜益气养血，补心醒脑，方用养心汤（《证治准绳》）。

(2) 脾虚痰湿证

主证：精神萎靡、昼夜嗜寐、神倦肢怠、面色萎黄、胸闷脘胀、纳少便溏、体形肥胖、舌淡苔白、脉虚弱或沉滑。

辨证分析：脾虚气弱，运化无权，脾气不足，清阳不升，脑神不振，故神倦肢怠、嗜睡不醒；脾虚生化无源，气血亏虚，则面色萎黄；脾虚失运，水湿停滞，水谷不化精微而成痰浊，痰浊痹阻，阳气不振，脑神不展，则精神萎靡，昼夜嗜眠；痰浊壅滞，气机不畅，故胸闷多痰，形体肥胖为痰湿之体，舌淡苔白或白厚、脉虚沉滑，为脾虚夹痰湿之象。

治法：健脾益气，化痰醒脑。

方药：砂仁六君子汤合温胆汤加减。

人参 10g，白术 12g，茯苓 12g，半夏 10g，
陈皮 9g，木香 6g，砂仁 9g，竹茹 10g，枳实 10g，
甘草 6g，石菖蒲 10g。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方中以四君子健脾补气；二陈汤化痰和中；木香、砂仁醒脾开胃，竹茹、枳实清痰热除烦止呕，下气宽胸；石菖蒲化浊开窍醒脑。诸药合用，共奏健脾益气，化痰醒脑之功。

加减：若痰郁化热者，加黄芩、黄连、黛蛤散、胆南星以清化痰热；若食欲不振、胸闷脘痞、头重如裹为湿困脾土，运化失司，湿浊停留之象，宜加苍术、藿香、厚朴，以健脾燥湿，化湿和中；若病情较重，脾气下陷、气短脱肛者，上方去木香、砂仁，加黄芪、升麻、当归、柴胡，以升提中气，益气养脑；若气血俱虚、气短心惊、面白无华者，改服人参养荣汤以补气养血。

3. 经验方药

(1) 参附注射液 20~40ml 加入 10% 葡萄糖溶液 500ml 中，静脉滴注，每日一次，15 日为一疗程。适用于阳虚型嗜

睡症。

(2) 细辛 5~30g、附子 10~60g、桂枝 10g、佩兰 15g、苍术 15g、川芎 10g、郁金 15g。用法：细辛、附子逐渐加量，先煎半小时后加入其他药物，水煎两次兑匀，分中午、晚上温服，每日一剂，30 日为一疗程。治疗嗜睡症有良效。

(3) 精制蝮蛇抗酸酶 0.5u，加入生理盐水 5ml，肌肉注射，每日一次，15 日为 1 疗程（注意事项同前）。适用于嗜睡症及瘀血症状明显者。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

(1) 取百会、心俞、足三里、三阴交，用平补平泻针刺手法治疗嗜睡效佳。

(2) 取百会穴，用艾条灸法；心俞、肾俞、神门、足三里、三阴交等穴，用针刺补法，治疗心肾阳虚之嗜睡症。

(3) 取穴四神聪、心俞、内关、脾俞、中脘、足三里；肾气亏虚者加肾俞、照海，针刺手法用补法，两日一次，2~3 周为一个疗程。适用于心脾不足之多寐。

2. 单方验方

(1) 佩兰 30g，水煎，每日一剂，该方为家传验方，治疗嗜睡症效果良好，具有活血化瘀，化浊醒脑之功。

(2) 商陆花阴干，捣末，日暮水送服 6g，治疗人心昏塞，多忘喜卧。

(3) 大麦蘖一升、川椒 30g 并炒后过筛，留川椒合干姜 60g 研末，每服 2g 开水送，每日 3 次，治脾虚多寐，食后则欲睡之病人。

(4) 生枣仁 30g、绿茶 60g，以生姜汁涤浸泡后炙微焦为散，每服 6g 水煎温服，治肝热多寐。

10g、石菖蒲 15g、半夏 10g、苏子 15g、甘草 10g、三仙各 15g、莱菔子 15g。(3)湿热中阻型：治法清热化湿，方用甘露消毒丹加减，用药黄连 10g、黄芩 15g、梔子 15g、半夏 10g、川朴 15g、陈皮 15g、菖蒲 15g、芦根 15g，并酌情加入香附、郁金等，并加冰片 0.03g，每日 2 次冲服，助菖蒲开窍醒神。(4)阳虚型：治法补益中阳，方用理中丸之类，用药党参 30g、白术 20g、陈皮 20g、茯苓 20g、柴胡 15g、黄芪 50g、当归 20g、阿胶 15g。

参 考 文 献

1. 马献图等. 麻黄临床新用. 陕西中医函授, 1994, (5): 9
2. 王桂荣等. 中医药治疗多发性嗜睡证 20 例. 黑龙江中医药, 1995, (3): 16

第十节 气功偏差所致精神障碍

气功锻炼过程中发生偏差而引起的精神障碍近年来并不少见，古代医书上称之为“走火入魔”、“气功病”、“禅病”等，如清·张璐在《张氏医通·入魔走火》中所说：“炼士坐功运气之走火，衲子参堂打七入魔”。指的就是因练气功、打禅所引起的精神障碍。

气功在古代称之为导引术，几千年来它在增强人类体质和治疗疾病上发挥了一定作用。气功通过“入静”和冥想(默念)达到包括脑部在内全身松弛的目的，属于放松疗法。由于目前形成的气功流派甚多，而且追求的目的不在于放松，不恰当地强调要达到“特殊功能”境界，从而产生偏差“走火入魔”，引起多种形式的精神障碍。

【临床表现】

1. 感觉障碍

指练功者并未明显精神失常,而仅有一些感知障碍,即所谓“特异功能”。练功者体验到“气”或“真气”在体内运行,能感受到周围人发生的“气”,自己的“气”也可影响别人,有的练功者感到肢体麻木,酸胀感,在“气”的影响下,患者出现过多或保持特殊体态,在练功场地可观察到各种各样的情感爆发和运动行为表现。

2. 精神障碍

可分为分裂样精神障碍、类癔症样综合征、类神经症综合征、以及气功诱发精神分裂症。

(1) 类分裂样精神障碍:多呈急性起病,患者可有言语零乱、幻听、被害、被控制妄想,内感性不适,行为紊乱等。病期短暂,经脱离现场,中断锻炼并给予适当治疗后很快恢复。症状内容与气功有可以理解的联系。

(2) 类癔病综合征:多为被暗示性强的女性练功者,第一次上场即可通过暗示诱发癔症样发作,存在有恋爱、婚姻或家庭矛盾者尤易发生。表现形式有哭笑发作、痉挛抽动、缄默少动、肢体软弱、失音、视力下降等。

(3) 类神经症综合征:患者感“气”在体内流窜、躯体不适、焦虑、抑郁、失眠、多梦、头痛、头晕等。

(4) 气功诱发精神分裂症:既往有精神分裂症病史者,气功可促使其复发,也可使有易感素质的人初发。此时患者幻觉和妄想内容怪异,与气功无联系,病程持久。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点

(1) 根据病因与症状出现的关系进行判断:根据病人及家属的主诉病状,询问、检查其致异原因,怀疑为走火入魔者,则事前必有气功锻炼史,一般发病紧接在气功之后,临床症状

内容与气功有联系,但可受暗示影响而改变。如果仅有心理、情感、行为等异常,而无练功史,则不能诊为走火入魔。

(2) 根据病人性格特征及家族史进行分析判断:在有练气功史及走火入魔的症状时,可对其性格及家族史进行调查,因为临床证实,被暗示性强,易感性强的人练功容易出现偏差而导致精神障碍,家族中有精神病史的人,偏差的发病率也高,平时有心理障碍,人格不健全的人,练功也易发生此症。

2. 鉴别诊断

气功所致的精神障碍应与反应性精神障碍、癔病、神经症以及精神分裂症相鉴别,鉴别的要点在于疾病的发生与练气功有否密切的关系。

【临床治疗】

1. 辨证要点

《张氏医通·神志门·入魔走火》曰:“……至于修真练气之士,不求自然之旨,刻以吐纳为务,乃至气乱于中,火炽于外,内外怔忡,痞逆,躁扰不宁等患。”练气功主要是调整气息,气息流畅,血脉通行,则可强身益体。大凡练功之士,有因急于求成,心情浮躁,心猿意马,不能入静;有因气之引导不正确,引起气乱于内,莫能自制;有因素体痰火较盛,练功过度,气引痰火内扰;有因肾气不足,竭尽练功,耗伤精血,阴亏于下,阳亢于上,诸种原因均可引起气血逆乱,气滞血瘀,或夹痰夹火,内扰心神而致走火入魔。故治疗上应着重内调气血,外驱痰火,中安心神,以冀理气活血,化痰泻火,安神定志之功,临床常见气滞血瘀型、痰火内扰型和阴虚火旺型。

2. 辨证论治

(1) 气滞血瘀证

主证:情绪不稳、哭笑无常、猜疑紧张、幻觉妄想、胸胁满

（2）痰火内扰证

主证：性情急躁、行为冲动、伤人毁物、狂乱无知、气窜难制、痰多胸闷、口苦而臭、头痛目赤、溲赤便结、舌红苔黄厚腻、脉弦滑。

辨证分析：素体阳盛，或素嗜醇酒烟草，恣食高粱厚味，痰湿壅盛，练功之时，不得静养，心猿意马，以致气机紊乱，夹痰夹火，内扰心神，痰火内扰，心神失控，故性情急躁、行为冲动、伤人毁物、狂乱无知；气不归经，难以自制，则自觉周身气乱窜气外泄、不能自制；痰浊内阻，胸阳不振，则痰多胸闷，痰火上扰清窍，则口苦而臭，头痛目赤；溲赤便结、舌红苔黄厚腻、脉弦滑乃痰火壅热之象。

治法：化痰泻火，清心安神。

方药：小陷胸汤。

黄连 6g，半夏 10g，瓜蒌 30g。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方中瓜蒌甘寒滑利、清热涤痰、宽胸散结，使痰热下行为主药；黄连苦寒泻火，直清心中邪火为辅药；半夏辛温降气化痰与黄连相伍，辛开苦降，善清胸脘之痰火。药味虽少，但功宏力专。

加减：若痰浊较盛、神识不清、胡言乱语，宜加南星、贝母、石菖蒲或送服礞石滚痰丸以逐痰开窍；若行为冲动、大便秘结宜加大黄、芒硝、厚朴、枳实以泻阳明实热；若兴奋躁动、莫能自制、狂越伤人、体形壮实者可酌用龙虎丸，使其吐泻交作，清荡痰火实热以顿挫其势。

（3）阴虚火旺证

主证：精神抑郁、思维迟钝、注意力不集中、喃喃自语、惊悸恐惧、幻听幻视、伴见五心烦热、口干咽燥、失眠盗汗、舌红

少苔、脉细数。

辨证分析：素体肾阴亏虚，复因练功未得要领，精神紧张过分，追求着意，欲求发功，竭尽所能，暗耗精血，精血不足，脑海失养，则见思维迟钝、注意力不能集中；精血亏虚，心神失养则精神抑郁、喃喃自语、惊悸恐惧；阴虚则虚火上炎，故见五心烦热、口干咽燥、失眠盗汗；舌红少苔、脉细数为阴虚内热之征象。

治法：滋阴降火，养血安神。

方药：知柏地黄汤加味。

盐知母 10g，盐黄柏 10g，熟地黄 30g，
山萸肉 20g，干山药 18g，光泽泻 10g，
白茯苓 10g，牡丹皮 10g，丹参 10g，酸枣仁 30g，
琥珀 6g（研末冲）。

水煎两次兑匀，分两次温服。

方药分析：方用熟地滋肾填精为主，辅以山萸肉养肝肾而涩精血，山药补益脾阴而固涩，三药合用以达三阴并补之功。配茯苓淡渗脾湿，以助山药之益脾，泽泻清泄肾火，并防熟地之滋腻，丹皮清泄肝火，并制山萸肉之温；知母、黄柏苦寒入肾，以制炎炎之虚火；丹参、酸枣仁、琥珀活血养血安神，镇静安神，诸药参合，以达滋阴降火，养血安神之功。

加减：若兼痰热未清者，可加全瓜蒌、胆南星、天竹黄以清痰热。若兼心神不定，恐惧不安，可送服定志丸以安神定志。若午后潮热，骨蒸烦躁可加白薇、地骨皮以清虚热。

3. 经验方药

（1）静安汤（制剂，见前）该方具有活血化瘀、安神通窍之功，对气滞血瘀所致的走火入魔有较好的疗效。

（2）清心化痰汤：黄连 6g、栀子 6g、玄参 20g、生地 20g、

麦冬 10g、大黄 10g(后下)、郁金 10g、菖蒲 10g、胆星 10g、代赭石 20g(先煎)、珍珠母 20g(先煎)、丹参 10g、甘草 3g。该方具有泻火镇狂、开窍醒脑、理气降逆、调和阴阳之功效。练功失当,必然导致三焦气机之逆乱,气乱无摄,痰火作祟,神明被扰,故治宜上、中、下三焦并行。

(3) 清开灵注射液 60~80ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中,静脉滴注,每日一次,15 日为一疗程。

【其他疗法】

1. 针灸疗法

治法:以理气安神,宁心开窍为主,佐以随证配穴,毫针刺用平补平泻或泻法。

(1) 气滞血瘀型:采用理气活血,疏通经络,清心安神法。

取穴:百会、人中、内关、足三里、血海、间使。

(2) 痰火内扰型:采用化痰清热,安神开窍法。

取穴:百会、人中、间使、丰隆。

(3) 阴虚火旺型:采用滋肾平肝,解郁安神。

取穴:百会、人中、合谷、太冲透涌泉。

加减:幻听、幻觉加翳风、听会、听宫;拒食,加素髻、地仓、足三里;抑郁消极,加临泣、大敦;情绪激动,加行间、合谷;头昏头痛加太阳、攒竹、印堂、风池;妄想,加风府、本神;气乱窜,周身不适,加气海、关元。每日针一次,10~12 次为一疗程。

2. 单方验方

(1) 凌霄花阴干为末,每服 6g,每日 2~3 次。具有凉血治血,祛风安神之功,用于气功偏差初期,精神症状尚不十分明显者。

(2) 桃花 30g、蚕蛹 30g、大枣(去核)15g,焙干为末,每服

5~10g,每日3次,具有活血化瘀、镇静安神之功,对气功所致精神障碍,自觉周身气感十分明显,不能自制者有效。

(3) 太子参 12g、石菖蒲 10g、郁金 10g、姜半夏 15g、龙齿 15g,水煎服,每日1剂。本方具有益气安神,化痰开窍之功。用于因体质虚弱,练功不当,所致气虚痰阻之精神异常者。

【预防与护理】

预防气功所致的偏差,首先要练功者本身与气功指导两方面进行预防,同时应做好练功前准备工作。

1. 练功者

(1) 练功前应认真学习、研究所要练习的功法,掌握注意事项与各种功法禁忌与适应证。

(2) 作为练功者,要把练功过程中的各种情况随时告知气功医师,以便及时得到指导。

(3) 以气功为治病目的者,一定要详叙病情,确定是否合适练功,适合者则安排练功计划,练习过程要遵医嘱,不可任意更改。

(4) 练功者应有气功医师指导,要平心静气,循序渐进,切不可急于求成,随心所欲,否则很容易出现偏差。

(5) 对练功中产生的异常感觉和幻觉,要及时请教有关人员暂时停止练功,在情绪不佳、工作劳累、环境不适的情况下,应暂时停止练功。

(6) 静功与动功相结合锻炼,既能预防,又能治疗轻度偏差,有利于强身壮体。

2. 气功指导者

(1) 气功指导者应是受过专业培训,对气功锻炼有一定的经验,能够全面地指导练功者进行练功的职业气功师。

(2) 对于要求练气功者,要认真审核其是否适宜,对病情

及精神状态不适应练功者,不进行气功指导。

(3) 当练功者在练功过程中产生的异常感觉或幻觉时,不能轻易加以赞赏和诱导,应及时劝告,暂停练功,进行必要的纠偏措施。

(4) 出现偏差者,应及时请其到医院就诊。

3. 练功前的准备工作

练功前的各项准备工作很重要,为了练好功法,收到预期效果,防止偏差等不良情况的发生,准备工作不容忽视。

(1) 做好练功前的思想准备,使情绪稳定下来,停止原来的一切活动和思考。

(2) 选择幽静环境,无论室内、室外,光线不要太强,空气要清新、流通,避免直接吹风,注意保暖,以免受凉,感冒。

(3) 准备好练功用的卧床,座椅和适宜的场地,力求舒适。

(4) 宽衣解带,排除身上硬物。

(5) 先排空胃肠,解除大小便。

【现代研究】

黄跃东等(1988):中医辨证治疗 40 例重症“走火入魔”,分 4 型辨证治疗。痰火内扰型:治宜化痰泻火,清心安神。方药菖蒲郁金汤合安宫牛黄丸。针灸取穴,间使通支沟、丰隆、太冲。痰湿内阻型:治以祛痰化湿,开窍定志。方用导痰汤合滚痰丸。针灸取穴,人中透龈交、内关、太冲。气滞血瘀型:治以理气化瘀,活血安神。方用达营汤。针灸取穴印堂、合谷、三阴交。阴虚火旺型:治以滋阴降火,养血安神。方用天王补心丹。针灸取穴印堂透心区、三阴交、内关。随证加减,兴奋躁动加煅礞石、海浮石、地龙干;不寐加苦参根、徐长卿;大便秘结加大黄、元参;多言痴笑加天花粉、制乳香;幻听妄想重用茯神、小

春花、凌霄花；自觉气乱窜，难于自制加沉香、旋复花。经中医辨证综合治疗总有效率 85%。

许予民等(1993)：介绍用针刺治疗练功偏差 18 例，均为男性，病程最短两个月，最长一年。诊断标准，有习练气功史，并因此而造成身体异常反应，如胸闷，腹胀，头昏头痛，烦躁失眠，有的身体中有气窜感及游走性局部疼痛，甚至出现神志方面的异常。作者介绍两种针刺方案：一为冲任气机逆乱，脏腑功能失调，治则调冲任，理脏腑。取穴气海、内关(双)、太冲(双)、足三里(双)；另一种为气逆向上，壅遏不利，治宜清泻降逆。取穴：太冲、委中、风池、合谷、太阳均取双侧。治疗结果：痊愈 6 例，显效 8 例，有效 2 例，无效 2 例。认为本病症以气机紊乱为主要病机，而针刺又以调气调神为先，在治疗上多用平补平泻手法，意在调经气和阴阳。

吕立江等(1994)：作者介绍辨证施治气功纠偏 52 例，临床诊断主要以气血逆乱，气机阻滞，真气走失，气机逆行，惊动入魔为辨证依据。分为气乱型、气滞型、气泄型、气逆型、“入魔”型等五型，分别采用外气引导法，对症点穴按摩，针灸与中药相结合的综合方法进行施治，有效率达 96%。

参 考 文 献

1. 黄跃东等. 中医辨证治疗 40 例重症“走火入魔”. 福建中医药杂志, 1988, (4): 12
2. 许予民等. 针刺治疗练功偏差 18 例. 云南中医学院学报, 1993, (4): 37~38
3. 吕立江等. 辨证施治气功纠偏临床分析. 中国气功, 1994, (7): 29~30

第六章 精神科急症的中医处理

当精神病患者的症状或行为可能危害到自身或他人,导致伤残或死亡,或其躯体情况处于危急状态时,都应视为精神科急症。在急症急救抢救过程中,应根据患者的病情状况,采用中医或中西医结合的方法等措施,进行及时地有效地处理。常见有兴奋状态的急症处理,抑郁状态的急症处理,意识模糊状态的急症处理,癫痫持续状态的急症处理以及精神药物急性中毒状态的处理等。

第一节 精神科急症处理的一般原则

一、急则治其标

“急则治其标”对生命垂危的精神病患者是首要的原则,应先观察患者的生命体征,即脉搏、呼吸、血压及疾病的严重程度,对有危及生命的危险因素,应予以优先诊治,如心、肺、脑的复苏,抗休克治疗等。对精神药物急性中毒的患者应尽快清除毒物,解除药物对机体的毒副作用,并及时采取对症支持疗法。

二、严密观察,控制病情

经急症抢救,患者生命征象平稳后,一方面要继续严密观察病情,积极处理;另一方面要控制精神症状,应根据病情分别采取病因治疗、对症治疗、心理治疗和躯体治疗等措施。紧急控制精神症状,主要采用中西医结合的方法,剂量从小量开始逐渐增加用量,对于老年、儿童及合并躯体疾病的患者,更

当谨慎使用。

三、保护患者,控制危害

对精神紊乱明显而难于管束的患者,医务人员首先要保持镇静,应迅速采取安定患者的有效措施,必要时可采取保护患者,约束其行为,以保护患者的安全,并与其他患者隔离。同时及时地使用药物等治疗。对有如自杀、自伤、冲动、毁物、行凶杀人等情况都应予特别注意,在保护病人安全的同时,也要注意周围人的安全。

四、尽早诊断,判断预后

要在做好精神检查的同时,重点做好包括神经系统在内的体格检查,判明疾病属器质性或功能性,需要尽早做出诊断准确估计病情的严重程度与危害性,及时作出相应的处理。应注意判断病情的发展与预后,及时防范,杜绝意外事故的发生。

五、完善急救设备,确保环境安全

急救室应具备安全环境,并备有完整的急救设备,如洗胃机、人工呼吸器、气管插管、气管切开、心电监护等,医务人员要具备急救抢救能力。要有健全的急救制度及急救药品,以适应急救抢救工作的需要。

第二节 精神科急症处理

一、兴奋状态的急症处理

【临床表现】

急性起病的精神疾病,不少表现为兴奋躁动状态,当程度严重时,需要紧急处理,否则不仅可危及病人安全,也可以危及家庭、社会安全,常见有:

1. 协调性精神运动性兴奋

病人的言语动作增多,是与其思想情感活动的亢进相一致,并和环境密切联系协调,这种活动增多是有目的和可理解的,多见于躁狂症、反应性精神病。

2. 不协调性精神运动性兴奋

其活动单调杂乱,缺乏明确的目的性,使人不易理解,可伴有意识障碍或突然发生冲动行为见于精神分裂症和症状性精神病。

【处理措施】

1. 对兴奋躁动状态及暴力行为的处理

医护人员首先要持镇静的态度,此时病人往往强烈反抗,拒绝检查与治疗,必要时可采取保护病人,约束其行动,以保护其安全。但应避免约束过久,造成损害,应有专人在旁看守,加强护理,防止意外。

2. 兴奋躁动病人中,有属心因性及癔症性激动的处理

应同时考虑心理问题,应取得家属合作,消除心因,避免病人发作时盲目惊恐,产生不良暗示。

3. 药物治疗

(1) 中医治疗

安宫牛黄丸:每次1~2丸,每日一次,严重者每日2次。具有清热解毒,豁痰开窍,镇静安神之功。

酒大黄 30~60g,鲜竹沥水 300ml,两药合用,煎煮至150ml,分3次服,以利为度,具有荡浊祛瘀,镇静安神之功。用于兴奋躁动之急症病人。

瓜蒂散:瓜蒂(炒黄),赤小豆各一份。研细末和匀,每服3~5g,顿服,不吐者稍增量,待吐则停服。精神兴奋状态的病人,往往吐后,症状可明显减轻。此为涌吐剂,易伤胃气,只宜用于实证。

龙虎丸：牛黄、巴豆霜、白砒各 0.9g，朱砂 0.3g。除朱砂外余药共研细末，糯米糊为丸，朱砂为衣，每丸 0.15g。每服一丸。龙虎丸药力峻猛，服后常大吐大泻，主要用于精神运动性兴奋患者。体弱者慎用。

清开灵注射液：60~120ml 加入 10%葡萄糖液 500ml 中静滴，每日 1~2 次，具有清热解毒，醒脑开窍，镇静安神之功。适用于兴奋躁动，思维紊乱，幻觉妄想，行为怪异等阳性症状明显，急性或亚急性发作的精神病人。

(2) 西医治疗：应选择强效抗精神病药物，及早控制其兴奋躁动，通常选用安全而有效、镇静作用强的吩噻嗪类及丁酰苯类抗精神病药。吩噻嗪类药物，首选氯丙嗪；必要时可将氯丙嗪合并异丙嗪使用，或采用常温冬眠治疗。应注意体位性低血压，过大剂量可致迷睡状态。应用时要密切观察病人的反应以及心率、呼吸、血压。丁酰苯类药物氟哌啶醇对控制兴奋激越和攻击性是有有效的药物。上述处理措施可以减轻或控制症状，但若产生暴力行为的精神疾病原发症状没有控制，仍可再次出现暴力行为，因此，这类患者应尽快入院对其疾病进行系统治疗为宜。

4. 其他

对已有躯体衰竭或器质性、症状性精神病所致的兴奋、药物敏感性强，不宜用强效抗精神病药，此时可考虑用地西泮。

二、抑郁状态的急症处理

【临床表现】

自杀企图与行为是抑郁患者最危险的症状，可出现在症状严重期，也可出现在早期或好转期。躁郁症的抑郁状态患者，自杀决心大者，往往事先有周密自杀计划，行动隐蔽，以逃避家属或医务人员的注意，故应高度警惕。

至宝丹：每次 2 丸，每日 2 次，具有清热开窍，化浊解郁之功。

菖蒲郁金注射液：每次 2 毫升肌注，4～6h 一次；或每次 10～20ml 加入 10% 葡萄糖液 500ml 中静滴，每日 1～2 次，具有芳香化浊，解郁开窍之功。

参附注射液：40～60ml 加入 10% 葡萄糖液 500ml 中静滴，每日 1～2 次，具有振奋精神，益气回阳之功。

(2) 西医治疗：对各类抑郁症，抗抑郁剂都具有较好的疗效，使用后情绪得以好转，迟钝和抑郁现象将会改善，常用有：三环类，如阿米替林、丙咪嗪、多虑平。对顽固性抑郁可用四环素类麦普替林及氯丙咪嗪，或于症状改善时继以口服上药。抗抑郁剂出现疗效需要数天以至数星期，故开始阶段可并用适量地西洋、奋乃静等具有镇静作用的精神药物。

4. 电休克治疗

电休克治疗对原发性抑郁症、心因性抑郁症等均有较好效果，特别是对严重抑郁而有自杀危险者，收效较速，可予考虑。一般隔日做一次，症状好转，可将治疗间隔期延长，一个疗程不超过 12 次。

三、意识模糊状态的急症处理

【临床表现】

患者处于意识模糊状态时，对周围事物不能正确感知，定向力发生障碍，因此行为缺乏目的性，可出现意外冲动，在谵妄状态时可在幻觉或妄想等病态感知和思维支配下，产生自伤伤人行为而需要急诊。因此，对有自伤伤人，行为紊乱的患者急诊时，需要检查患者是否有意识障碍的存在。

意识模糊状态常见可由下列疾病引起：如躯体疾病及各种感染、中毒、急性脑器质性疾病、癫痫持续状态，以及癔症发

作的情感暴发。朦胧状态、急性反应性精神病较常见。

【处理措施】

1. 详细检查,分析病因

对于意识障碍的患者要注意其器质性疾病基础的存在,要了解有关病史,作详细的体格检查,注意发现神经系统异常体征,给予必要的实验室检查,查找意识障碍的原因。

2. 明确诊断,积极治疗

应尽快明确诊断及积极而合理地治疗引起意识障碍之原发疾病,同时给予营养支持治疗及对症处理,首先要有效地维持呼吸和循环,及时解除其心力衰竭和呼吸系统感染等因素,减轻脑缺氧,常能使急性脑综合征得到改善。

3. 药物治疗

(1) 中医治疗

安宫牛黄丸:每次1丸,每日1~2次,清热开窍,豁痰解毒。

紫雪散:每次1.5~3g,每日2~3次,清热开窍,镇痉安神。

至宝丹:每次1~2g,每日2~3次,清热开窍,化浊解毒。

清开灵注射液:40~100ml,稀释后静脉点滴,清热解毒,醒脑开窍。

牛黄醒脑静:20~30ml加入10%葡萄糖液500ml静脉滴注,醒脑开窍,安神镇静。

(2) 西医治疗:对处于谵妄兴奋紊乱的患者,需考虑使用镇定药物,一般先采用地西洋肌内或静脉注射,必要时可用小剂量抗精神病药,如氟哌啶醇肌内注射。或用氯丙嗪合并异丙嗪肌内注射,一旦症状有所控制,则改为口服小剂量奋乃静,以控制兴奋。巴比妥类可加重意识障碍,应避免使用。

4. 特别护理

对意识模糊的患者,需专人看护,防止患者自伤、伤人必要时宜安排特护或家属陪住以加强患者的安全管理。

四、癫痫持续状态的急症处理

【临床表现】

癫痫持续状态是一种持续的意识障碍,此种状态多出现于癫痫患者连续大发作后,或癫痫患者突然停药抗癫痫药物,此时患者意识障碍程度深,防卫反射消失,对周围环境丧失定向力,其诊断要点为:

- 患者有癫痫病史,突然停药(抗癫痫药)或不合理用药治疗史。

- 发作的特征,符合癫痫大发作的表现。

- 发作频繁,发作间歇期处于昏迷状态。

- 部分患者可出现大汗、高烧。

- 严重患者,因连续的癫痫大发作,引起脑缺氧、脑水肿,出现较严重的神经系统体征。

【处理措施】

1. 药物治疗

(1) 中医治疗

安宫牛黄丸:每次1丸,每日1~2次,清热开窍,豁痰止痉。

神犀丹:每次3~6g,每日2~3次,清热解毒,开窍定惊。

牛黄醒脑静:10~20ml加入10%葡萄糖液500ml静脉滴注,开窍醒脑,止痉安神。

菖蒲郁金注射液:每次2ml肌注,4~6h一次;或每次10~20ml稀释后静脉点滴,清热化浊,芳香开窍。

清开灵注射液：80～100ml，稀释后静脉滴注，清热化痰，醒脑开窍。

(2) 西医治疗：迅速控制癫痫发作是主要的，抗癫痫药的选择原则以速效、短效的药物为主。

静脉注射地西泮是首选药，可稀释液后缓慢静脉注射以控制抽搐，松弛肌肉，如发作能终止，可行肌内注射。

如用地西泮后未能控制抽搐，可使用异戊巴比妥钠，该药控制癫痫发作的效果强，但副作用大，有呼吸循环系统疾病和肝肾功能严重不全的患者，应尽量避免使用或慎用。注射此药时，应有专人观察呼吸和心率情况，如发现呼吸变浅或心搏弱，心率变慢，应立即减慢注射速度或停止注射，对儿童及老人酌情减量。

苯巴比妥钠可在给地西泮的同时，开始用苯巴比妥钠。

使用多种抗癫痫药仍未控制发作时，可用乙醚吸入。

2. 对症治疗

包括减轻脑水肿，防止脑疝形成；保持呼吸道通畅；降低高热；纠正水、电解质和酸碱平衡；维持呼吸循环功能及加强护理工作；保护患者安全。

五、精神药物急性中毒的处理

精神药物的急性中毒，在急症中占有较高的比例。多为精神患者在消极情绪支配下用以自杀，或在幻觉，妄想的支配下吞服大量药物，也有患者误服过量或患者家属小孩误服这类药物者。如果抢救及时而恰当，大部分病例能脱险获救，其中以抗精神病药中毒占多数，其次为抗抑郁药。精神药物急性中毒的一般抢救原则是相同的，主要是支持治疗和对症治疗，通常无特殊的拮抗药物，只要熟悉下列原则就能抢救大部分患者。

【一般抢救原则】

1. 清除被吞服的药物

(1) 洗胃：洗胃是清除留在胃内药物简便而有效的方法，不论患者是否昏迷，也不论服药时间长短，一般都应洗胃，由于精神药物能延长胃的排空时间，特别是抗精神病药物和三环类抗抑郁药物有外周抗胆碱能作用，引起胃肠蠕动减慢，即使服药时间较长，甚至超过 24h 以上者，仍以洗胃为安全，通常用 1：5 000 高锰酸钾溶液 5 000～10 000ml，反复清洗，直至洗出液体的颜色不变为止。

(2) 催吐：仅适用于服药时间短，意识清醒，合作的患者，有意识障碍者禁用。抗精神病药物均有镇吐作用，药物性催吐往往失败，但是如果让患者大量吸入 1：5 000 的高锰酸钾溶液，然后用压舌板刺激患者的软腭，则可引起呕吐。

(3) 活性炭：50～100g 放入水中，洗胃后鼻饲，可阻止药物吸收。

(4) 利尿：有些药物以原形从尿中排出，如苯巴比妥等，这些药物可溶于水，与血浆蛋白结合较为疏松，利尿药能增加其排泄。其他的脂溶性药物，如格鲁米特、短效巴比妥、地西洋、三环类抗抑郁药，与蛋白质结合紧密，从尿中以原形排出者不多，利尿的价值不大，利尿药可用呋塞米静脉注射，或 20%甘露醇静脉滴注。

2. 解毒和护肝

要保证充足的液体摄入量，保持电解质及酸碱平衡，无特效解毒剂一般常用葡醛内酯（肝泰乐）及大量维生素 C 护肝，对服毒时间较长，药物已吸收者，有条件的可采用透析法或血液灌流排出毒物。

3. 防止并发症

环类药物中毒时更易发生。

正确及时地处理心脏复苏,并于心脏复苏后作进一步严密观察。

此外,及时判断与正确处理肺水肿、少尿和急性肾功能衰竭、脑水肿、感染及防止临床复发或“反跳”,对抢救成功也极为重要。

4. 中枢兴奋药的应用

催醒剂一般不作常规用药,因可诱发癫痫,贝美格(美解眠)、甲氯芬酯(氯酯醒)、哌醋甲酯(利他林)等可适当用于昏迷较深的患者。呼吸、循环功能不全时,一般采用咖啡因、尼可刹米肌注,必要时可联用山梗菜碱、乳酸氨力农、哌醋甲酯(利他林)等。

5. 中医治疗

至宝丹:每次1~2g,每日2~3次,清热解毒,化浊开窍。

紫雪散:每次1.5~3g,每日2~3次,清热解毒,开窍安神。

生脉注射液:30ml加入25%葡萄糖液20ml中,静脉注射,每10~20min1次,直到血压回升,改为静脉点滴,对抗精神药物中毒性休克,心律紊乱均有效。

参附注射液:20ml加入25%葡萄糖液20ml中,静脉注射2~3次后,用参附注射液100ml加入5%葡萄糖液500ml中,静脉点滴,日1~2次,主要用于抗休克治疗。

清开灵注射液:40~100ml,稀释后静脉点滴,清热解毒,醒脑开窍。

第七章 祖国医学的心理疗法

祖国医学在《内经》时代就建立了以古典辩证哲学为基础的生物——心理——社会自然医学模式。通过漫长的医疗实践,总结出了一整套的心理疗法。针对精神疾病的病因,个体特性和社会环境,而分别采用疏泄开导法、反相调治法、气功“参禅”法、修身养性法等治疗方法。

一、疏泄开导法

疏泄开导法是指运用各种方式以疏泄、开导,改善或调整患者的精神情感状态,使不良的心理得以纠正,七情得以调畅的治疗方法。适用于因心理因素所致的病症。这类病症多因长期思维活动(思念)、持续的消极情绪和情感(忧、愁、悲、恨)等原因而引起。其病理基础是“嗜欲无穷,而忧患不止,精气弛坏,荣泣卫除”(《素问·汤液醪醴论》)。

1. 语言开导法

语言开导法是通过言语、劝说、安慰、保证以疏泄感情,使患者发泄心中怨情,从而消除患者的焦虑、紧张、恐惧,给患者提供心理支持的一种治疗方法。

语言刺激对心理、生理都会产生较大的影响,正确地运用这一治疗方法,对患者进行启发诱导、劝说、解释、宣讲疾病的知识,分析病因病理,能够解除患者的疑虑,调动患者战胜疾病的信心,促进身体康复。使用的方法是“告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦”(《灵枢·师传》)。“告之以其败”,即通过诊察分析患者的心理和行为,然后针对性地

指出疾病的危害性,唤起患者对疾病的注意,使其重视疾病,树立认真接受治疗的态度,这是心理治疗的第一步。“语之以其善”,是分析疾病的预后和转归,指出只要治疗及时恰当,是可以很快恢复健康的。“导之以其所便”,是指导患者积极配合医生进行治疗、休养、锻炼、调摄的方法。“开之以其所苦”,是指开导、疏泄患者的情怀,解除其抑郁、消极、顾虑的心理状态,使其做到勿忧勿悲,情绪稳定的治疗方法。使用本法时,要注意开导的艺术,首先须做到话语恳切简单。若开导落入俗套,称赞缺乏诚意,虽说悦耳,但却无法契入患者的心。华丽的词句通常是多余的,最简单的称赞,得体的劝说、启发能令人感动。其次是开导不宜轻率,陈腔滥调的劝说鼓励是不会产生效用的;未经思索便脱口而出的劝说亦是徒劳的。例如开导时对患者说:“嗨,你不要着急”或者说“开朗些”,这即使是发自内心的劝说,也难以令人感动。医务人员与患者谈话、散步时,切忌打官腔,以圣贤自语,发号施令,而应以平等、温和、商量的口气进行交谈。在不同的时间、地点,都要注意患者的心情,尤其对于个人隐私,谈话更应注意场合,这样即使是几句简单的话语,常可产生较大的影响。

本法的适用还依赖于医生的威信,亲切的谈话,生动的比喻,才能疏导、影响患者的心理活动,以恢复心理上的平衡。唐·孙思邈开创了与患者“共语”的方法,提高患者的“受入性”。这种“共语”实际上是医患之间的平等、友好、亲切的对话;“受入性”即是患者对医生心理治疗的接受能力。《灵枢·师传》曰:“入之情,莫不恶死而乐生”,只要开导得法,医患之间有了“共语”,是可达到促进心理康复的目的。

语言开导法可分为一般性语言开导治疗和个别深入的语言开导治疗,一般性语言开导治疗是一种适用于精神科及内、

外各种各类患者,简而易行的心理治疗方法。它具有支持和加强患者防御功能的特点,通过解释、鼓励、安慰、保证和暗示等一般性心理治疗,能使患者增强安全感,由于得到保护和受到鼓励,可减少焦虑和不安。个别深入的语言开导治疗是由医生有计划有步骤地通过会谈方式和患者单独进行的一种心理治疗,这种治疗的主要内容是:从患者的历史出发,广泛收集有关材料,对于有疑问和具有关键性的问题,必须复查核实,通过详细的客观分析,采取启发诱导的方法,帮助患者寻找其发病原因,在患者家属和其他有关方面的积极配合下,鼓励患者建立信心,加强自我锻炼,克服病态症状,提高适应能力,最后达到全愈的目的。这种治疗有祛除病因和预防复发的作用,这种方法主要适用于某些神经官能症、心因性疾病和性格障碍基础上的精神疾患。

2. 顺意从情法

顺意从情法是指顺从患者的情绪、意志,满足患者身心的必要需求,以改善其不良的情感状态,纠正心身异常的一种治疗方法。《荀子》曰:“凡入有所一同,饥而欲食,寒而欲暖,劳而欲息,好利而恶害,是人之所生而有也,是无待而然者也,是禹桀之所同也”(《荀子·荣辱》)。阐述了每个人的基本需求是生而具有的,目欲视物,耳欲闻声,饥而欲食,渴而欲饮,寒而欲衣,劳而欲息,病而欲医等,都是人类最基本的生理需求。而理想、前途、爱情、婚姻、家庭、求学、就业等等,又是人类社会生活的必然反映。对于那些因外界条件所限,或因个人精神过分压抑而胆怯、内向、愿望难遂,积久而形成的精神疾病,治疗时应尽可能地予以满足其心理要求,不能强制的废止,这对于精神疾病的康复显得尤为重要。所以《素问·移精变气论》告诫,对积郁成疾的精神疾病的治疗要“以从其意”。张景岳亦提出

我国现存最早的医书《五十二病方》曾提到祝由疗法达30余处,《内经》中有“移精变气论”专篇的记载,至元、明时期,祝由则被列为医学十三科之一。“祝由”可由一定权威性的人物,通过讲述患者发病的原由,指导纠正不良的精神状态;亦可通过行为,舞蹈等祝由形式,调动患者积极的因素,转移患者对痛苦的注意力,使恶劣的精神状态得到调整改善,从而形成良好的精神内守的状态,以移易精气,变利气血,恢复正常的生理功能。“祝由”这种方法往往易被认为带有较浓厚的迷信色彩,但其移易患者的注意力,改变其精神状况的方法还是可取的。可改用一种既无迷信色彩,又能使患者信服的方法,用以“移易精气,变利气血”仍是必要的和可行的。

移精变气法主要适用于因惊惑所致的病证。如症见妄识幻想,惊恐迷惑,情志不遂,深情爱恶等以及某些因情志刺激而发生的轻微小疾。如《医学正传》曰:“祝由……可治小病,或男女人神庙惊惑成病。或山林溪谷冲斥恶气,其证如醉如痴,如为邪鬼所附,一切心神惶惑之证,可以借咒语以解惑安神而已”。可见,在精神疾病的治疗中,只要设计巧妙,施治得当,取得患者的信服,是可收到满意疗效的。移精变气法所采用的祝由方法与现代心理学常用的催眠疗法等相似。

4. 暗示诱导疗法

暗示诱导疗法是指用含蓄、间接的方法对患者异常的心理状态施加影响,诱导患者接受医生的治疗意见,树立某种情感,去改变其原有的情绪和行为的一种治疗方法。

暗示诱导法与语言开导法有相似之处,但暗示诱导法作用于情感和意志方面,是在患者不知不觉中进行的;而言语开导法是在患者知觉的情况下进行的,两者同中有异。

暗示诱导法就其施示者而言,分为两类,即自我暗示和他

暗示。暗示诱导法主要是“他暗示”法。医生在诊病处方用药的全过程中,一言一行,举止仪态对患者有着极大的暗示诱导作用。如对病情和预后的回答时,讲“没关系”、“可治”等语,可调动患者的积极情感,增强患者对治愈疾病的信心和希望,这就是常说的“医人之情”。若患者偶有所得,能自我开导,以理遣情,这种自我暗示,对疾病的治疗也是有帮助的,此即所谓“患者之情”。

就其暗示的施行方式可分为语言暗示和借物暗示两类。前者借语言、神态、表情、动作以暗示,如医生的语言和善,信心十足,表情轻松,神情自然,操作熟练,动作轻巧,则是一种积极的暗示;反之,皱眉弄眼,唉声叹气,一筹莫展,语言粗暴,操作笨拙,则是一种消极的暗示。借物暗示是借助一定的药物或物品,暗示出某种事物和现象,去满足患者的心理需要和消除患者的疑虑。使用本法须洞察病情,语句中肯,有较高的艺术性和说服力,切不可令患者有所觉察,让其在无意中消除异常的心理状态,达到治愈疾病的目的。

在现代所用的暗示疗法与中医学暗示诱导法雷同,也是用于神经症患者为多,特别是对于那些体诉多于主诉,而又经各方面的检查仍不能发现相应器质性变化的患者,使用暗示疗法确实收到桴鼓之效。

二、反相调治法

反相调治法是针对因激情所致病症而运用某种治疗方式,对患者的心理和情感产生一定的强制作用的治疗方法。这类病症多因一时性的猛烈的、暴发性的强烈情感所引起,如狂喜、暴怒、大恐、骤惊等。在病理上常产生“气伤”、“气上”、“气下”、“气乱”的变化。治疗时就须用另一种情感去抑制这种情感,以打破患者情志上的恶性循环,从而建立新的良性循环。

反相调治法是祖国医学心理治疗的一大特色,有着重要的临床意义。

1. 以情胜情法

以情胜情法是指运用一种情志活动,去调节因某种情志刺激而引起的疾病,以消除情志障碍,纠正不良心理的一种疗法。中医学认为精神与形体,情志与情志之间,在生理上、病理上存在着相互影响的辩证关系。其发病与情志的偏盛有关,故治疗时应“以其胜治之”(《素问·脉要精微论》)使其归于平衡。《医方考》亦记载:“情志过极……须以情胜”。在“情胜”的具体应用方法上,《儒门事亲》提出了“以五行相胜之理治之。”人有五志,分属五脏,五志五脏间存在着五行制胜的规律。人的情志活动是以五脏精气为物质基础,并在心的主宰下进行的,所以情志相胜是通过五脏相胜来采用反相调治的手段实现的。以情胜情疗法,除五行相胜疗法外,还有阴阳相胜疗法。本疗法的具体运用如下。

(1) 悲胜怒:《内经》:“怒伤肝,悲胜怒”。指出怒的情感须用悲的情绪去治疗。陈无择说:“怒伤肝,其气出”。怒是一种勃发粗犷的情感,易导致人体气机逆乱。肝主疏泄,性喜条达,肝疏泄条达与否对人的精神活动影响极大。郁怒不解则“气逆于上”(《素问·举痛论》),引起内脏气机紊乱,出现胁痛、口苦、头痛、心烦、呕逆等症,甚则横克脾土或反侮肾水。悲为肺所主,肺主宣发肃降,肺气以清肃下降为顺。在五行中肺金克肝木,《素问·阴阳应象大论》张介宾注曰:“忧则气消”,“悲则不怒,是其征也”(《儒门事亲》),唤起患者的悲伤情感,以治疗郁怒的精神疾病。

(2) 恐胜喜:指用恐吓以治疗因喜乐过极所致的精神疾病的一种疗法。喜归心属火,喜本为好事,但是“正复为奇,善

复为妖”(《老子·五十八亲》),凡物太过,其气偏激皆为患。“喜伤心”(《素问·阴阳应象大论》),喜太过则气缓,心气耗散则“神惮散而不藏”(《灵枢·本神》),症见健忘、失眠、多梦、喜笑不休。恐属肾主水,在五行中肾水克心火;在病理上“恐则气下”(《素问·举病论》),“恐可以治喜,以迫惧死亡之言怖之”(《儒门事亲》)。运用惊恐、惧怕之类的刺激去治疗某些强迫症和忧虑症,使患者在惊惧、羞畏的情感中逐渐解除其“神散”症状,如《素问·调经论》曰:“出针视之,曰:我将深之”,就是施恐治病的最早记载。

(3) 喜胜忧:指用喜笑欢乐使患者精神喜悦,以治疗忧怒悲哀所致的精神疾病的一种疗法。忧归肺属金,忧是预感或曾经过某种不顺意的事情,沉浸在担忧愁郁的不良心境中。“预事而忧……忧伤肺,其气聚”(《三因极一病证方论》),肺之治节失常,气衰不行,郁而生病;郁久化热化燥,或生痰、致瘀。症见胸痛胸胀、纳少。喜属心主火,在五行中心火克肺金;“喜则气缓”,“喜则气和志达,荣卫通利”(《素问·举痛论》),忧怒悲哀的情感能受到调节,故《素问·阴阳应象大论》张介宾注曰:“喜则神畅,故胜忧也”,临床上常“以谑浪褒狎之言娱之”(《儒门事亲》),用喜去唤起病人精神上的喜悦,欢快,这对精神疾病的康复期调治以及抑郁症、神经症的治疗有着积极的作用。

(4) 怒胜思:指用激怒患者的情绪,以治疗因忧思气结所致的精神疾病的一种疗法。思归脾属土,陈无择说:“思伤脾,气留不行,积聚在中脘,不得饮食,腹胀满,四肢怠惰”即所谓“思则气结”(《素问·举痛论》)之病。因为思之过甚,可以使人的行为和活动调节发生障碍,使气不行而结滞,或阴阳不调,尤其易导致脾伤而气结于中。症见纳少,大便溏,神疲乏力。怒属肝主木,在五行中肝木克脾土,在病理上怒则气上。《素问·

环境类似的信息特别过敏,当记忆信息与外界环境类似的信息有感应共鸣的条件时,就会重新激发原情志所致病症。骤遭恐怖和暴力事件的袭击后,人们所表现出的剧烈的激情反应,常在很长一段时间内仍“心有余悸”,甚至惶惶不可终日。对于这种精神疾病的治疗,须使用以惊治惊法。“惊”法即用强烈的惊恐惧怕的精神刺激,去转移和逐渐消除患者对恶性刺激的注意力,以调节紊乱的气机,使气血通畅,阴阳调和。《内经》还提出了“惊者平之”的治则。“平之”即平常之法,用重复同样的刺激,以增强患者对这种刺激的耐受力,习惯了,使之见怪不怪,正如张子和所说:“‘惊者平之’。平者常也,平常见之必无惊”(《儒门事亲》)。这种治法与现代医学之行为矫正疗法的“系统心理脱敏疗法”很相似。系统心理脱敏疗法常用于纠正因受外界恐怖事件,或暴力行为的突然刺激所导致的恐惧反应扩散。脱敏的方法,可因病而异,不尽然都必用“惊”去“平之”。此外,即使不是因惊而致病,仍可用惊的方法治之。如《灵枢·杂病》曰:“哆……大惊之,亦可已”,就是这一方法的应用。

以惊治惊法的使用,应注意如下几点:

(1) 了解恐惧的起因。

(2) 指导患者适应对恐惧刺激的松弛反应。

(3) 巧妙地施用惊的方法,逐渐加强刺激度,使患者获得一种习惯于接触“有害”刺激信息时,即可达到脱敏的目的。

临床上只要使用得法,并注意了上述几点,就会收到满意的效果。否则,盲目施用,不但与疾病无益,还易导致新的惊恐病症,这是不可忽视的。

5. 威慑镇定法

指用威慑行为诱起患者恐惧的情感,以镇定异常的精神

状态的一种心理疗法。古代医家多用于患者自身无法控制的心身病症。治疗时常采用恐怖境地,从威严仪容,高声锐语,严酷刑具等向患者展示或施用,使患者在这威慑事件刺激下,促使精气内收,神志平安,理智恢复。

在施用本法时,也应注意刺激量、刺激时间和患者的具体情况,灵活选用,不可妄施其法,以免造成新的心理障碍。

三、气功“参禅”疗法

气功“参禅”疗法是以自身为对象,凭借意念而“入静”,从而达到神静、息调、身轻的一种心理疗法。气功“参禅”疗法借意念为主导,有意识地松弛机体,宁静思想,稳定情绪,调整呼吸,达到自我调控心理-生理活动,来纠正心身失调,所以又有人称之为“意念疗法”。气功“参禅”疗法分气功和“参禅”两种。

1. 气功疗法

气功,古代又称吐纳、导引。吐纳指口吐浊气,鼻纳清气,即通过呼吸以调息;导引指“导气令和,引体令柔”。以意念主导体内之气的运行,使其吐浊纳清,气和体柔的活动称之为气功。

气功的特点是“入静”、“松弛”,通过主观意识来引气循经运行,使经络疏通,气血调和,同时吐出浊气,纳入真气。

练功时首先要“调心”、“练意”。做到“净神不乱思”(《素问·异法方宜论》),身体放松入静,排除杂念,“气随意行”,“意气合一”,这样可消除精神紧张,祛除异常的心理状态。其次要“调气”、“练形”。《素问·上古天真论》曰:“呼吸精气,独立守神,肌肉若一”。呼吸均匀,吐故纳新能使气血调畅;加强运动,锻炼体魄,增强体力,使形体矫健,如此而达到祛病健体延年的目的。气功疗法在神、形、气中,把调节心神放在十分重要的地位,因此,练功时应予掌握。

气功的种类较多,如《诸病源候论》记载了 213 种不同的导引方法,适用于 110 种病症的治疗。使用时应针对患者的不同病症,灵活选用不同的练功方法,这些宝贵的健身之术,被现代实验证实,对改善中枢神经系统、呼吸系统、消化系统、血液循环系统和内分泌系统的功能有明显的作用,祛病健身的效果越来越明显,使用范围越来越广,成为中外人们所喜爱的强身之术。

2. “参禅”

古代有称坐忘、静功。“坐忘”即坐而忘掉一切,《庄子》有颜回坐忘说:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘”。“坐忘”时要达到坐而“离形去知”,不知肉体的存在,即是不但要静坐,而且要澄心。“静坐”是手段,澄心是目的,通过澄心,以实现“恬淡虚无,真气从之,精神内守”(《素问·上古天真论》)的境地。可见“参禅”的基本特点是澄静空心,以此来调整人体姿势,宁静思想,调匀呼吸,调和心神,以松弛机体达到祛病健身的目的。

如何做到神清志专呢?《内经》曰:“清净则志意治”。为此,古代医家强调应清除六害,即薄名利、禁声色、廉货财、损滋味、摒虚妄、除嫉妒。若患者能恪守如上忠告,清净无为,知足常乐,就可达到神清志专的精神境界。在练功时要稳定情绪,意守丹田,达到自我调控心理活动。若“志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五藏不受邪”(《灵枢·本脏》)。“参禅”疗法具有身心兼调,身心同养的作用,适用于因紧张、焦虑、妄想、妄求等精神因素所引起的精神疾病。现代医学认为气功“参禅”疗法是一种低能代谢的储能反应过程,可使中枢神经的紧张性有所下降,自主神经系统的功能得以调整,从而促进“内环境稳定”,对抗心现应激。所以本法可调节情绪,改善心理机

能,故是治疗精神疾病不可缺少的方法之一。

四、修身养性法

修身养性法是通过调情志、摄精神、戒嗜欲,益身心来养身防病的一种治疗方法。人之性包括一个人的气质、性格特征,它对个体情感活动起着决定性的作用。善于养性之人,能使情志调畅,刚柔相济,阴阳平和,所以修身养性对改善患者的心理素质,预防和阻止精神疾病的发生发展有着重要的临床意义。

修身与养性是统一的。嵇康《养生论》曰:“修性以保神,安心以全身,爱憎不栖于情,忧喜不留于意,泊然无感,而体气和平。”修身养性的目的是使精神内守,心神凝定,而心神调理冲和适度,则体内环境安和统一,身体安康。《孙真人卫生歌》曰:“卫生切要知三戒,大怒、大欲、并大醉……世人欲知卫生道,喜乐有常嗔怒少,心诚意正思虑除,顺利修身去烦恼”。强调了人体情志的剧烈波动对身心健康的影响,并着重指出修身养性有利于心理健康,故从治疗学的意义上讲,修身养性疗法是从根本上对精神疾病进行治疗。

1. 修德养性

人生活在思想感情极为丰富的社会环境里,善、恶、美、丑,千奇百怪的事情都是客观存在的,人体不可避免地会受到不良情感的刺激。在这不良刺激下,如何进行自我防御,有效地调节自身的精神活动,以祛病延年呢?杨上善曰:“修身为德,则阴阳气和”,“德全者,血气和顺”。指出修德养性能陶冶情性,使气血和顺,气机调畅,改善人的心身功能。

加强自身身心和道德修养,正确对待自我、他人和社会,热爱社会、热爱生活、热爱事业。在社会生活中做到无贪欲,无妄想,有“先天下之忧而忧,而后天下之乐而乐”的高尚情操;

的心态,才能达到养心静神的目的。

3. 陶冶情操

闲情逸致指借情境等趣事陶冶性情志趣,以创造良好的心境,培养高尚情操,改善心身素质,以移易情性,修养心身。古代医家十分重视闲情逸兴,《理渝骈文》曰:“七情之病也,看花解闷,听曲消愁,有胜于服药者矣”;龚廷贤《寿世保元》亦曰:“诗书悦心,山林逸兴,可以延年”等都是对闲情逸兴的论述。其具体方法颇多,概括言之,有如下几点。

(1) 习诗学文:欧阳修曰:“学书为乐”。《古今嘉言》将“观书”作为闲情逸致的重要内容。古人认为“读义理书,习诗学文”可提高自身素质,通情达理,心胸宽广,增强对自我意识的调控能力。所以《管子·内业》曰:“凡人之生也,必以平正,所以失之必以喜怒忧患。是故止怒莫若诗”。

(2) 书画调趣:《老老恒言》曰:“笔墨挥洒最为乐事”,培养书画情趣,可激起对大自然的眷恋,对人生的热爱,仿佛已置身于美好的意境之中,对陶冶性情,改善和协调异常的心理状态有良好的作用。

(3) 音乐冶情:《古今嘉言》把“听琴玩鹤”作为述齐斋十乐之一。是陶冶情性的常用方法。《管子·内业》曰:“去忧莫若乐”,荀子亦曰:“乐也者,乐也,人性之所以不能免也。且足以感动人之善心”。一曲动人的音乐可以疏解郁闷,陶冶情感,唤醒良好的心理状态。祖国医学把角、徵、宫、商、羽五种音分别归属五脏,并用来调整脏腑的生理功能。在古典医籍中有诸多的记载,如《备急千金要方》曰:“弹琴瑟,调心神,和性情”,用“听曲消愁”来寄托思想,调整人体异常的情志,其功有时确实“胜于服药矣”。从现代的认识看,音乐在医学上的治疗作用是有依据的。因为人的应激能力具有素质的多样性与量的差

异性,这种差异有天赋素质的原因,亦与人体后天实践的广泛性,以及自身的主观能动性有重要联系。而音乐的本质就在于对听觉的和谐美的创造。那么音乐治疗的“意义在于用一种和谐的美的社会存在,决定或重构一种和谐的美的心态,它不断地排除不切身心的心理,以提高心身机体的应激能力。”目前,音乐疗法在国内外的医院里,不同程度地得到应用。美国有100多所大学相继开展了音乐治疗专业研究,这说明音乐治疗已被世界医学所重视。在生活节奏日益紧张的现代社会里,人们更需要内心的宁静与解脱,更需要保持心理的平衡。正由于音乐戏剧能有效地使听者摆脱焦虑不安,获得内心宁静与休息的效果,所以音乐治疗的作用不可低估。

(4) 颜色娱性:《内经》依据五色配五脏的原理,认为肝胆合青色,心小肠合赤色,脾胃合黄色,肺大肠合白色,肾膀胱合黑色,并进一步指出五色对情志的调节有积极的作用。这一构想已初步被现代科学所证实。美国生物社会研究所所长斯超士博士认为颜色对人体的心理可以产生直接的影响,“颜色的电磁波能够对垂体和松果体腺以及下丘脑起反应”,而这些器官能调节和控制人体的基本功能和情绪的内分泌系统。在西德已设计一种仪器,能将各种颜色变成电磁波,经过放大,输送到人体中,进行治病。

此外,闲情逸致的方法还有弈棋、种花、旅游、品茶、交友等,临床上可因人因病而灵活选用。

4. 回归社会

(1) 家庭关怀:人生活的环境包括自然环境和社会环境。社会环境又包括小家境况,工作、地区生活境况等。家庭是社会群体的基本单位,夫妻情感、父子、婆媳、翁婿间的关系是否和谐,会引起相应的情绪反应。结婚绝不是爱情的结束,而是

深厚爱情的开始,夫妻情感要在生活中不断吸取新的营养,来培植,来丰富。不要放纵自己的弱点、缺点,要善于保持自己的吸引力,不断地丰富家庭生活乐趣,使爱情之树常青。

尊重人、爱护人、照顾人,把自己的幸福与配偶、子女和家庭的幸福凝集在一起,家庭就会和睦,不易激起波折,生活就幸福,心情就愉快。否则就会使家庭乐趣之源枯竭,导致或加重心身疾病。

(2) 劳逸结合:劳动就业不单纯是提供生活资料和取得报酬,更重要的是通过劳动为社会尽义务,从而获得心理上的满足。不良的劳动环境,噪音、公害污染,睡眠节律频繁变动,繁杂的人事关系等,都会影响到职工的心身健康。简单重复的操作易导致精神抑制和疲劳。有报道说,从事不到一分钟就重复一次操作的工人,要比间隔 3~30min 才重复一次操作的工人多患失眠、肠胃病和抑郁症。从事紧张危险的工作,使精神过度紧张,易罹患神经症、哮喘、震颤和痉挛,以及消化系统疾病。

此外,隔离和孤独的环境,如果没有高度事业心和责任感的支持,这种环境常易导致厌倦,诱发精神疾病。

(3) 安居乐业:环境污染,如超量的噪音、振动、粉尘、气味、高温、冷冻、潮湿、拥挤、放射性物质等理化刺激的延续,均会影响人的生理状态,改变人的情绪和行为。

努力改善劳动环境,减轻劳动强度,使人们心境安详、沉着,情绪稳定、工作愉快,对于精神疾病患者来说是十分必要。劳逸适度可防止神经系统出现功能性障碍;体育活动和文娱生活可消除疲劳,增进心身健康。

对于那些不能就地治疗好的精神疾病,应主张患者移居秀丽的湖光山色之滨,或至乡村静处休养,或躲开情志损害之

处,以免触景生情,重新勾起不良心境和紊乱的情绪活动。总之,运用此法的目的,主要是要消除周围情景中不利于健康的刺激因素。当然,人与人之间的纠纷磨擦,更多的还是要通过自我努力,加强个性的修养,主动地去改善和调节那些不利的刺激因素,促进精神疾病的早日康复。

经脉篇：胃足阳明之脉。病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处，甚则登高而歌，弃衣而走。

病能论：帝曰：有病怒狂者，此病安生？岐伯曰：阳气者，因暴折而难决，故善怒也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：夺其食即已，使之服生铁落为饮，夫生铁落者，下气疾也。

【评议】 以上为《内经》之论狂，其中谓为病名者有之，谓为症状者有之，谓为病机者亦有之，且亦有治法。在古代医籍中，除将“狂”列为一种特殊疾病外，其他在临床上，每将其作为一种症状来描写，如“热病发狂”，“谵语发狂”，“畜血如狂”等等，但溯其命名之由来，仍最早始于《内经》，且论之亦较详，后代之论狂症者，莫不以《内经》为宗，且推崇备至，直至于今，在医学教材中，仍以为此为病名之章目。

《内经》对狂症之治疗，虽有“夺其食”与服“生铁落饮”之方法，惜乎未能尽详，后世之所谓“夺其食”即“禁食”，即“低血糖治疗”等等云云，俱为臆测之词。至于“生铁落饮”之内容，更未言及，《医学心悟》中之“铁落饮”，虽属宗自《内经》，但亦为一家之体会，国内虽有此方之报道，然对兴奋狂妄之控制，并不能立竿见影，因此临床对此方运用，仍有可商之处。

2. 《内经》论癫

奇病论：人生而有病癫疾者，病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令于发为癫疾也。

厥论：阳明之厥，则癫疾也，欲走呼，腹满，不得卧，而赤而热，妄见而妄言。

癫狂篇：癫疾始生，先不乐、头重痛，视举目赤，甚作极已而烦心、候之于颜。

邪气脏腑病形篇：肺脉急甚为癫疾。

宣明五气篇：邪入于阳则狂，搏阳则为癫疾。

【评议】 《内经》对癫之叙述较少，且亦含糊笼统、症状亦不突出、治法丝毫未提，且文字亦有费解之处，如《奇病论》“精气并居”四字即费解，故亦不能确定其病种之所属，有认为是痫症者，有认为是独成一病者，惟其与“狂”成为阴阳二证相对性之疾病，则自《内经》而下，至今尚

无人对此说加以反对。

3. 《难经》

二十难云：重阳者狂，重阴者癫。

五十九难云：狂癫之病、何以别之，然狂之始发，少卧不饥、自高贤也，自辨智也、自倨贵也，妄言好歌乐、妄行不休是也。癫疾始发，意不乐，僵仆直视，其脉三部阴阳俱盛是也。

【评议】 难经亦宗《内经》之论而来，其说虽简，含义极深，虽至今日，其重阴重阳之论，为精神病树立两大纲领，仍具有极大之科学价值，惜未能加以进一步发挥。不能如现代“阴性症状”与“阳性症状”之学说引人入胜。此外对狂之叙述，颇似情感性精神病躁狂症之夸大妄想（内经同）但对癫之叙述，则较为模糊，“意不乐，直视、僵仆”之症象，很难确定其为何病，癫痫有之，癔症有之，精神分裂症木僵状态亦可有之，但与狂症相对立，特别为“重阴”“重阳”之说，则较《内经》更为明确。

4. 《金匱要略》

金匱·五脏风寒积聚篇：阴气衰者为癫，阳气衰者为狂。

【评议】 金匱论癫狂与阴阳之关系，颇难理解。按一般常理，阴气衰必然阳气盛，相反阳气衰自亦必阴气盛，因而金匱所论、与内、难重阳重阴之义不符，以及与后世诸家之学说俱不相同，故甚有讨论之必要。盖伤寒、金匱同为仲景所著，仲景伤寒论序云：“撰用素问九卷、阴阳大论、八十一难……等。”可见仲景既用《内经》《难经》，其学说当不致与内、难相违，伤寒既如此，金匱当亦必如此，故可断言仲景与内、难绝无相违之处。《医宗金鉴》言：“癫狂之条有错文、阴阳二字相互差误”，此说深为有理，考《伤寒论》之有错文者并非无有。例加“伤寒脉浮滑，此为表有热、里有寒、白虎汤主之。”此条经文，亦殊为费解，以致后世学者，多有论其文字有差别者，非为“寒”与“热”之差，即为“白虎”与“白通”之别，金匱之论癫狂，立意亦同乎此，若云其为“正气”之阴衰“阳衰”者，则属偏颇之言，令人难以置信。故《金匱》此条应为“阳气衰者为癫、阴气衰者为狂”。

5. 《脉诀》

恍惚之病定癫狂，其脉实牢保安吉，寸关尺部沉细时，如此未闻入

救得。

【评议】 王叔和对此方面之记载，共有三节，上二节则似属谵妄（症状性精神病），此节则标明为癫狂，其以脉论病，未可全靠。

6. 《诸病源候论》

风狂候：狂发或欲走，或自高贤称神圣者，此风邪入并于阳、阴阳气相并所致。

风邪候：发则不自觉知，狂盛妄言，悲喜无度。

鬼邪候：言语错谬，或啼笑惊走，或癫狂昏乱，或喜怒悲哭，或大惧怖、如入来逐，或歌谣咏啸，或不肯言语等。

鬼魅候：好悲而心自动，或心乱如醉，狂言惊怖、向壁悲啼，梦晤喜厌，或与鬼神交通。

【评议】 巢氏病源，多为病源与症状之记载，甚少言及治法。但据本篇之所云，亦可分为阴阳癫狂两大类，其风狂候，则与阳狂相似；其风邪候、鬼邪及鬼魅候，又与阴癫表现相同，特别在鬼邪候中，标明为“癫狂昏乱”（颇似现代之精神分裂症）。有关此类症状之记载，始于《巢源》，故而巢元方之功不可没。

7. 《千金方》

诸百邪之病源起多涂，其有种种形相，示表癫邪之端，而见其病，或有默默而不声，或复多言而漫说，或歌或哭，或吟或笑，或眠坐沟渠，嗜食粪秽，或裸形露体，昼夜游走，或嗔骂无度，或蜚虫精灵，手乱目急，如斯种类癫狂之人，令针灸与方药并主之。

【评议】 千金方突出行为紊乱，冠以“邪病”之名，其对症状之描写，以脱离现实为显著，最后言其类于癫狂，但对病因与机现，以及临床辨证，只字未提，说明此种疾病，临床就以症状为主，较为独特，主张针药并用，惜未能道出针药之具体内容，未免遗憾。

8. 《外台秘要》

风邪入血，使入阴阳二气，虚实不调。若一实一虚，则令血气相关，气并于阳则狂，发则欲走，自高贤称神圣者是也。

【评议】 外台立论虽简，但所提问题，则较突出。一为指明“风邪入血”，对后世之启发甚大，论癫狂之由于血家受病或气血不调者，王焘为

此一学说之首创者。一为强调阴阳二气虚实不调，因而致病，此说虽宗自《内经》，但可谓发《内经》之秘而大之。

9. 《河间六书》

多喜为癫，多怒为狂，喜为心志，心热甚则多喜而为癫，怒为肝志，故肝实则多怒而为狂。

【评议】 河间学说，首创心、肝、喜、怒、癫、狂之分，为此前诸家所未道。

10. 《东垣十书》

狂言者，大开口与人言，语所未尝见之事；谵语者，合目自言，言所尝见行之事；郑声者，声战无力，造字出于喉中，此三者之别也。

【评议】 东垣所述，以症状为主，而未定其为疾病，更未作“癫狂”来论证，此在其他疾患中，亦可伴有此种情况之出现。

11. 《丹溪心法》

癫属阴、狂属阳、癫多喜而狂多怒，癫者神不守舍，狂言如有所见，经年不愈，宜以“人事治之”。

【评议】 丹溪之论，乃根据河间之学说而来，首创“人事治之”之理论，并有“活套”之一系列方法。光《内经·阴阳应象大论》及《师传篇》之理论而大之，开前人所未道，实为精神病治疗-心理治疗之杰出者，此在其医案中，可以证之。

12. 《儒门事亲》

肝屡谋，胆屡不决，屈无所伸，怒无所泄，心血日涸，脾液不行，痰迷心窍，则成心风，属虚者多。

【评议】 张子和首创“痰迷心窍”论，阐发病理之机，为后世所宗，至今仍影响极大，在其《儒门事亲》中，有不少治疗精神病之精彩医案，除药物治疗外，尚有心理治疗与行为治疗同时并用，堪称古代精神病学之名家。以后又云“心风属虚者多”，并不囿于“攻下”之一隅，子和之求实之处，即在于此。

13. 《医学正传》

狂为痰火实盛、癫为心血不足，多为求望高远不得志者有之，此二证者，若神脱而目瞪如痴愚者，吾未如之何也已矣。

【评议】 虞搏首创精神创伤(环境刺激)对疾病所起之诱发作用,较前人更胜一筹,并指出如病至晚期,及痴呆阶段者,则亦缺乏良好之治疗方法,其叙述虽较简单,但立论则较为精辟。

14. 《证治要诀》

癫狂由七情所郁,遂生痰涎,闭塞心窍,不省人事,目眈不瞬,妄言叫骂,甚则逾垣上屋,裸体打人。

【评议】 戴思恭将癫狂合论,且将七情内扰与痰迷心窍合并为致病之因,但在症状描写上,界限又不够分明。

15. 《医学纲目》

狂谓狂言妄走也,癫谓僵仆不醒也,各自一证。然经有言狂癫疾者,有言狂互引癫者,有言癫疾为狂者,此则又皆狂癫兼病,今病有妄言妄走,顷时前后僵仆之类。有僵仆后,妄见鬼神,半日方已之类,是以癫狂兼病者也,狂邪癫痛不欲眠卧,自贤自智,妄行不休。

【评议】 医学纲目对癫狂之论证,繁琐不清,界限难明,但归纳之后,可发现如下几点问题:

① 其言“狂言妄走”,与诸家之论狂相同。② 其言癫“僵仆不醒”,则又与《难经》之“僵仆直视”相似,但并无抽搐、角弓反张之描写,故又与“痫”症不符。③ 其言相互引发:“癫疾为狂”、“狂疾为癫”,则为临床阴阳二症之相互转变。④ 其言先僵仆后又妄言,则又颇似今日所见之木僵型精神分裂症与癔症之发作。⑤ 最后指明“自贤自智,妄行不休”,则又明显地近似躁狂症之征象。综观所述,姑不论其对诊断界限之划分,是否清楚,但对症状之观察,似乎较前人已更进一层。

16. 《医学入门》

癫者异常也,平日能言,癫则沉默,平日不言,癫则呻吟,甚则僵仆直视、心常不乐,此阴虚血少,心火不宁。狂者凶狂也,轻则自高自是、好歌好舞,甚则弃衣而走,逾垣上屋,又甚则披头大叫,不避水火、且好杀人。此心火独盛,阳气有余,神不守舍,痰火壅盛使然。

【评议】 李梴以阴虚、阳盛,为癫狂发病之机理,其论癫之反常情况,为其独特之见解;其论癫之“僵仆直视”,则根据《难经》而来。其对狂之论述,则为精彩绝伦之作,共分三类:一为自高自是,好歌好舞,有似

乎近代临床所见之“轻躁狂症”，二为弃衣而走，逾垣上屋，则似情绪极为兴奋之躁狂症；三为披头大叫，不避水火，则为极度严重之躁狂症，由轻而重，层次分明，虽寥寥数语，已揭狂症证之真谛。

17. 《古今医统》

古方每以癫痫并治出方，乃大误也。盖癫为心病，而属实者为多，痫为五脏兼病，而属虚者多；心风者，非若外风入中，甚言其变常无定，恍惚不仁、而心之病，诚若风之魔也。此皆七情、五志久逆而生，而与癫痫又不同矣。

【评议】 古今医统以癫与痫别为两病，指出以往分类之非，并论癫专属心病，痫则五脏俱病（此中含有发则为五痫之义），比较以前又推进一步。除此以外，则又立“心风”之名，但对症状及治法，均语焉不详，是故心风之名，不乐为后世医家所采用。

18. 《证治准绳》

癫者或狂或愚，或歌或笑，或悲或泣，如醉如痴，言语有头无尾，秽洁不知，积年累月不愈。

狂者病之发时，猖狂刚暴，如伤寒火实发狂，骂詈不避亲疏，甚则登高而歌，弃衣而走，踰垣上屋，非力所能，或与人语所未尝见之事。如有邪祟依附者是也。

【评议】 《证治准绳》集前人各家学说，参合自家之心得，综合而归纳之，各病俱然，不独对癫狂如是，故后世对王肯堂之评价极高，云为：“既详且备”。其对癫狂之叙述，简洁扼要，论证精详，对症状之描写，鲜明突出，界限清楚，精彩实际，在以往紊乱中理出头绪，堪为纲举目张，故后世医家论癫狂宗师王肯堂之论者，十之八九，包括近代之中医教材，亦均以此为准则，故王肯堂对祖国医学之精神医学贡献极大。

19. 《景岳全书》

癫狂之病，病本不同，狂病之来，狂妄以渐，而经久难已，癫病之至，忽然僵仆，而时作时止。狂病常醒，多怒而暴，癫病常昏，多倦而静，由此观之，则其阴阳寒热，自有冰炭之异，故《难经》曰：“重阳者狂，重者为癫。”义可知矣。

【评议】 景岳学说，不及王肯堂鲜明，且论癫之征象，与痫又有疑

似之处,但其对阴阳两症之划分,界限较为明朗。重申《难经》,阴癫阳狂之旨,在症状描写上,又不及王肯堂生动。

20. 《沈氏尊生》

癫为久病,狂为暴病,癫病多喜、狂病多怒。癫有时人不之觉,是癫之轻者,狂有时人不及防,是狂之骤者。癫病痰火,一时忽动,阴阳相争,亦若狂之状,狂病痰火,经久煎熬,神魂迷瞽,亦兼癫之形。

【评议】 沈金鳌之论癫狂,界限亦较清楚,大致与王肯堂相同。但症状叙述,不及《证治准绳》清晰,其论癫之轻与狂之骤,皆为其个人心得,但丝毫不与痼症混淆,此为沈氏独到之处。

21. 《类证治裁》

癫狂,心肝脾胃病也,经曰:“重阴者癫,重阳者狂”,阳并于阴则癫,阴并于阳则狂,癫多喜笑,症属心脾不足,狂多忿怒,症属肝胃有余,癫则或哭或歌,或悲或泣,如醉如痴,语言颠倒,秽洁不知,经年不愈,多由心脾郁结,志愿不遂,更或因惊恐致神不守舍者有之。狂则自悲喜忘,善怒善恐,少卧不饥,自贤自贵,或邪并阳明发狂,骂詈不避亲疏,登高而歌,弃衣而走,不食数日,逾垣上屋,或阳气暴折而难决,而为怒狂,多由肝胆谋虑不决,屈无所伸,怒无所泄,木火合邪,乘心则神魂失守,乘胃则暴横莫制。总之癫狂皆心火自焚,痰迷心窍络,故癫始发,其情志失常,状亦如狂,狂经久则其神魂迷瞽状亦类癫,诊其虚实而分治之……。

【评议】 林佩琴综合《内经》与《证治准绳》及各家学说,对征象叙述,不仅丰富,且对癫狂之学说系统逐渐形成,不再与他症(如痼与心风等)混淆,特别提出“有余不足”之理论,开前人所未道,对后世启发甚大。其最后对临床之辨证论治,似乎过于理论程式,且亦较繁琐,故予略去。

22. 《石室秘录》

发狂多是热病,登高而歌,弃衣而走,见水而入,骂詈之声,叫喊杀人之语,不绝于口,舌如芒刺,饮水不休,痰色光亮,而如火肿是也。煎药取数碗,彼索水时与之饮,随索随予,饮尽必睡,一醒呼水,再以汤予之,彼必欣然自饮,眼完又必大睡,以后听其自然可也。如妇人病花癫,见男子抱住不肯放,此乃思慕男子不可得而然,得病如暴风疾病,罔识羞耻,

见男子则以为情人也。此肝木枯槁、内火燔盛，脉必弦出寸口，法当用平肝、散郁祛邪之味，用人灌之，彼必骂詈不休，久之人倦欲卧。卧后醒来，自觉羞耻，紧闭房门者三日，少予之饮食自愈，一剂后不必更予之药也。癲病之生也，多生子脾胃之虚寒，所食水谷，不变精而变痰，痰凝胸膈之间不得化，流于心而癲症生矣，徒治痰而不补气，未有不速之死者。

【评议】 陈士铎对狂症之叙述，似一种热性病谵妄发狂，如“舌如芒刺、而如火肿，大渴引饮”，为白虎证之属。其对女病人思慕异性，名之曰“花癲”，与世俗所云之“花痴”含义相同。其叙述似一种临诊笔记与个案之经验，虽对癲以痰立论，但整个篇幅，不及对“呆症”论述之精彩。

23. 《活人录》

或问：人本无病，忽而如醉如痴，或怒骂哭笑者，何病使然？有一发即愈者，有愈而复发者，有终身不愈者何也？

答曰：此乃情志之病，亦有阴阳之分，病属五脏为癲，癲为阴症，阴症难愈；病属六腑为狂，狂为阳症，阳症易愈，有触即发，无触则缓。

或问：癲狂虽分阴阳，若论其症，无非痰迷心窍，致使神情变乱，自当独责之心，何得有脏腑之别也？

答曰：癲本起于郁结，或忧思过度，或谋虑不遂，使五脏之神情意志，不得舒展，日渐衰微，故心虚无主而多疑，肾虚志弱而自愧，脾虚失意而不乐，肺虚多忧而悲苦，肝虚抑郁而恼怒，五者有一于此，遂至气郁化火，火郁生痰，痰气火三者，随其所传之脏，而现症不一，或言笑悲歌，或时恐惧恼怒之不定，言语则或清或昏，或邪或正，形状则如醉如醒，或呆坐，或沉睡，时而嬉笑怒骂，时而叹息愁困。若曰痰迷心窍，则又时乎明爽，宛然无病，以此则知不独心家受病，而致病之因，时止时发者，皆痰气火之为变不一，而五脏之神明受病，有虚无实，宜补而不宜泻者也。

或问：狂症属于何时？起于何因？幸以教我。

答曰：狂症由于郁怒，暴怒伤肝，肝木旺而生火，火乘于胃，胃火与肝火并发而病，盖怒气与火气躁烈难遏，非比癲症出于忧思郁结，纯乎阴象，故令人心神躁妄，失志狂言，不避亲疏而骂詈，不畏寒冷而露体，不顾羞耻而裸形，不知饥饿而夺食，甚至叫哭狂走，一刻不宁，升高上屋，如履平地，打人举重，越过虎贲，平素虽怯，而无所不能，内经阳明篇

言,甚则行步不休,或复僵仆不起,俗呼为失心风。

狂者刚暴猖狂,叫号骂詈,甚则逾垣上屋,蹈火赴汤,不避死生,不知饥饱,倍常勇力,若邪所凭,俗呼为发狂。

二者证既不同,因当各异,古人多以癫狂混称,亦疏略矣,盖人身气为阳,血为阴,腑为阳,脏为阴,府之手足六经为阳,脏之手足六经为阴,形质可见者为阳,神志不可见者为阴,身半已上为阳,身半已下为阴,表为阳,里为阴,凡此阴阳,俱各倚依,互为交通,而致气血和平,脏腑安静,经脉调匀,形神合一,上下无厥逆之虞,表里无盛虚之变,如是则微疴小疾,亦无自而生,况癫狂乎,今癫云重阴者,谓偏重于阴也,邪入于阴,而阴实也,五脏为阴,神志舍于五脏亦为阴,设或抑郁不伸,谋思不遂,悲哀不置,侘傺无聊,久久藏神凝结,情识昏迷,灵明何有,此癫之成于神志者也。狂则反是,乃重阳阳实之证也。其脉浮洪者,是为阳脉,阳狂得之,与证相宜,即阴癫得之,亦从阴转阳,自里达表之象,故云为吉兆。若沉不急,沉则入阴迫里,急则强而不动,是无胃气之脉也,不论狂癫,凶殃立至。

【评议】 医灯续焰之立论,可谓阐扁鹊之大旨,谓由阴阳两者之不平衡,因而致病,历来对癫狂之论阴阳者虽多,但剖析如此之详,尚属不易多见。其对脉象之论述,则不免过偏,留作参考可也。

26. 《医旨绪余》

诸家有言癫狂者,有言癫病者,有言风痫者,有言风癫者,有言惊痫者,有分癫病为二门者,异无定论,究其独言癫者,祖内经也,言癫病言癫狂者,祖灵枢也,要之癫病狂大相径庭,非名殊而实一之谓也。灵枢虽编癫狂为一门,而形证两具;取治异途,较之于痫又不相侔矣,诸书有云:大人为癫,小儿为痫,此又大不然也,素问谓癫为胎病,自母腹中受惊所致,今乃曰小儿无癫可乎?痫病大人历历有之,妇人尤多,又不可谓为无痫也。

【评议】 孙东宿对癫、狂病加以鉴别,除宗内经外,并根据《证治准绳》论证,对症状进行叙述,故将原文略去。

27. 《张氏医通》

癫之为症,多郁抑不遂,侘傺无聊,精神恍惚,语言错乱,或歌或笑,

或悲或泣，如醉如狂，言语有头无尾，秽洁不知，经年不愈，皆由郁痰塞于心包，神不守舍，俗名痰迷心窍。狂之为病，皆由阻物过极，故猖狂刚暴，若有邪附，妄为不避水火，骂詈不避亲疏，或言未尝见之事，非力所能，病反能也。

【评议】 张氏医通亦根据证治准绳立论，甚至连词句亦无差别，所言病因，亦不外痰浊情志数者，甚少新奇之说。

28. 《此事难知》

狂言、谵语、郑声辨：狂言者，大开目与人语，语所未尝见之事，即为狂言；谵语者，合目自言，言所日常见常行之事，即为谵语也；郑声者，声战无力，不相接续，造字出于喉中，即郑声也。

【评议】 王好古重复东垣所述，为症状上之鉴别，不足以云为一种疾病。

29. 《寿世保元》

癫狂，大抵狂为痰火实盛，癫为心血不足，多为求望高远不得志者有之。若神脱而目瞪如愚如痴者，纵有千金我酬，吾未如之何也已矣。癫者喜怒不常，颠倒错乱之谓也，狂者大开目与人语，语所未尝见之事，斯为狂也。

【评议】 龚廷贤宗医学正传之说，语句亦相差无几。

30. 《古今医鉴》

夫癫者喜怒不常，而颠倒错乱之谓也，狂者狂乱而无正定也，故心热盛则多喜而为癫，肝热盛则多怒而为狂，甚则弃衣而走，登高而歌，骂詈不避亲疏，是盖得之阳气太盛，胃与大肠实热，燥郁积于中而为之病，此则癫狂之候也。大抵狂为痰心实盛也，治当大吐大下。癫为心血不足，多为求望高远不遂其志者有之。

【评议】 龚信集前人如刘完素等几家学说，亦无新的见解。

31. 《医学衷中参西录》

癫者性情颠倒，失其是非之明，狂者无所畏惧，妄为妄言，甚或见闻皆妄，大抵此症初起先微露癫意，继则发狂，狂久不愈，又渐成癫，甚或知觉全无，盖其初微露癫意者，痰火犹不甚剧也，迨痰火积而益盛，则发狂矣，是以狂之甚者，迨病久则所郁之痰皆变为顽痰，其神明淆乱之极，

(2) 景岳强调环境心理因素,故云“或以郁结、不遂、思虑、疑贰、惊恐等”各种情况,但此种情况之产生,莫不与环境心理因素有关,此不仅与近代精神病学观点相符,且亦为其识见高人之处。

(3) 景岳论痴呆之临床症状,除“言词颠倒,举动不经”等精神症状外,并有“多汗”等症状,特别提到的是“其症千奇百怪”,则又与现代精神医学所提出精神分裂症之特点“怪”相符,其意义相同之程度,令人惊异。

(4) 景岳另一高人之处为观察此种患者“形体强壮,饮食不减,别无虚脱等症”且设“有可愈有不可愈”,此又与现代所观察到的大多精神患者,四诊所得,俱为阴性者,完全相符。

凡此种种,景岳论证之精,深深使人叹服,其所订立之方剂,可供参考之价值亦甚大。

2. 《石室秘录》

呆病如痴,而默默不言,如饿而悠悠若失,意欲癫而不能,心欲狂而不敢。有时睡数日不醒;有时坐数日不眠;有时将己身衣服密密缝完;有时将他人物体深深藏掩,与人言则无语而神游,背人言则低声而泣诉,与之食则厌薄而不吞,不与食则吞炭而称快。

【评议】 陈士铎对痴呆之叙述,症状生动,文词精美,虽名为痴呆,但未见精神衰退,临床以孤独、淡漠、退缩、缄默、矛盾、怪异、紧张、拒食、行为紊乱、睡眠障碍等精神症状为突出,与精神分裂症极为相似。陈氏对痴呆症之治疗,立有“逐呆仙丹”,尚待临床进一步加以验证。

有关痴呆症之临床记载,以上述《景岳全书》与《石室秘录》叙述最详,为中医论精神病之精深者,以后各家,虽有论说,但仍以此两家学说为宗。

三、怔忡惊悸

大抵论惊悸者,常常言及怔忡,而论怔忡者,亦往往伴有惊悸,故怔忡与惊悸,分类并不明确,然据历来所载,此病患者,其精神活动,并未见显著之异常,大多以自觉体诉为主,故怔忡、惊悸与健忘、失眠,有其重要的相互关系,兹先述怔忡惊悸。

1. 《内经》

灵枢本神：心怵惕思虑则伤神。

藏气法时论：肝虚则目眈眈无所见、耳无所闻，善恐如人将捕之。

生气通天论：起居如惊，神气乃浮。

阴阳别论：二阳一阴发病，主惊骇。

脉要精微论：阴盛则梦涉大水恐惧。

举痛论：惊则气乱。

四时刺逆从论：阳明湿则病积时善惊。

至真要大论：太阳司天、寒淫所胜，民病心，澹澹然大动。

五常政大论：委和之纪、其发惊骇。

著至教论：三阳者至阳也，积并则为惊。

【评议】《内经》言惊、骇、恐、惧，并未言及怔忡，可知怔忡为后人之所定。

2. 《巢氏病源》

风惊悸者，由体虚心气不足，心之虚为风邪所乘，或恐惧忧迫，令心气虚，亦受于风邪，风邪搏于心，则惊不自安，惊不已则悸动不定，其状目睛不转，而不能呼，诊其脉动而弱者，惊悸也，动则为惊，弱则为悸。

风惊恐者，由体虚受风，入乘藏腑，其状如人将捕之，心虚则惊，肝虚则恐，心肝虚而受风邪，胆气又弱而为风所乘，恐如人捕之，虚劳损伤心脉，致心气不足，因为风邪所乘，则使惊而悸动不定。

【评议】巢氏亦言惊悸未述怔忡，其论惊悸，由于心虚受风而成。尚有可商之处，唯其将惊与恐之征象分述，则为见识之言。

3. 《严用和济生方》

夫怔忡者，心血之不足也，盖心主血，血乃心之主；心乃形之君。血富则心君自安矣，多因汲汲富贵，戚戚贫贱，又思所爱，触事不如意，真血虚耗，心君失辅，渐成怔忡，怔忡不已，变生诸症，舌强恍惚，善忧恐，少颜色，皆心病之虞。

又有冒风寒暑湿、闭塞诸经、令人怔忡，五饮停蓄，埋塞中脘，亦令人怔忡，当腑其证施以治法。

夫惊悸者，心虚胆怯之所致也，且心者君主之官，神明出焉，胆者中正之官，决断出焉，心气安逸，胆气不怯，决断思虑得其所关，或因事有

所大惊，或闻虚响，或见异相，登高涉险，惊忤心神，气与涎郁，遂致惊悸，惊悸不已，变生诸症。

【评议】 济生方所载，标明为心血不足与心虚胆怯成为惊悸怔忡，较巢氏已更进一层。考查医籍，为怔忡命名之最早者。

4. 《丹溪心法》

人之所主者心，心之所养者血，心血一虚，神气不守，此惊悸之所以肇端也，曰惊曰悸，其可无辨乎，惊者恐怖之谓，悸者怔忡之谓，心虚而痰郁，则耳闻大声，目击异物，遇险临危，触事丧志，心为之忤，使人有惕惕之状，是则为惊；心虚而停水，则胸中渗漉，虚气流动，水既上乘，心火恶之，心不自安，使人有怏怏之状，是则为悸。

【评议】 丹溪将惊与悸分类，较以上又更详，临床之叙述，亦较为精细。唯云惊即为恐似属未妥，不及张从正论惊、恐区分之精辟。

5. 《医学正传》

怔忡惊悸之候，或因怒气伤肝，或因惊气入胆，母能令子虚，因而心血为之不足；又或遇事繁冗、思想无穷，则心舍亦为之不宁，故神明不安，而怔忡之症作矣。夫所谓怔忡者，心中惕惕然，动摇而不得安静，无时而作者是也，惊悸者，蓦然而跳跃惊动，而有欲厥之状，有时而作者是也，若夫二症之因，亦有清痰积饮，留结于心包胃口而为之者，又不可固执以为心虚而治。

【评议】 虞搏特指出痰饮蓄积亦成惊悸，分虚实两候，是亦为经验之谈，宗仲景“水停心下则悸”之说。其论怔忡与惊悸之定义，亦颇精彩。

6. 《证治要诀》

惊悸者，因事有所大惊，触忤心神，气与涎郁，遂生惊悸，此乃心虚胆怯所致。怔忡为久思所爱，触事不忘，虚耗真血，心血不足，遂成怔忡，俗谓心神脉乱是也。怔忡即忪悸也，忪悸与惊悸若相类而实不同，惊悸者，因事有所惊而悸，忪悸者，本无所惊，常心忪而自悸，焉得无辨。

【评议】 戴思恭分有事而惊与无故而悸，颇具临床经验。

7. 《医学入门》

思虑过度及因大惊大恐，以致心虚停痰，或耳闻大声，目见异物，临

危触事，便觉惊悸，甚则心跳欲厥，脉弦濡者虚也，时作时止者痰也。怔忡因惊悸久而成，痰在下，火在上故也，悸动也，心膈间客邪乘之，筑筑触动，如人将捕之。即怔忡意也。

【评议】李梴之说虽详，但其分类尚不及《证治要诀》为佳。

8. 《证治准绳》

悸即怔忡也，怔忡者，本无所惊，自心动而不宁，惊者因外有所触而卒动，张子和云：惊者为不自知故也，恐者为自知也，盖惊者闻响即惊，恐者自知如人将捕之状，及不能独自坐卧，必须人为伴侣，方不恐惧，或夜必用灯照，无灯烛亦恐惧者是也。

【评议】《证治准绳》将惊悸恐三者分析，至为明确，与癫狂痫之分类，同具有较高之归纳性质。

9. 《景岳全书》

怔忡证，唯阴虚劳损之人乃有之，盖阴虚于下，则宗气无根，而气不归根，所以在上则浮撼于胸臆，在下则振动于脐旁，虚微者动亦微，虚甚者动亦甚，凡此症宜节劳欲，戒酒色，养精气，培根本。

怔忡惊恐者，虽有心肝脾肾之分。然阳统乎阴，心本乎肾，所以上不宁者，未有不由乎下，心气虚者，未有不由乎精，心脾血气本虚，而或为怔忡，或为惊恐，或偶以大惊猝恐，而致神志昏乱者有之，肾水不足而怔忡不已者有之，肾火不足而怔忡者有之，元阴精血亏损，阴中之阳不足，而为怔忡惊恐者有之，水亏火盛，烦躁热渴，而怔忡惊悸不宁者有之，思虑郁结过度，耗伤心血而为怔忡惊恐者，宜逍遥散之类，寒痰停蓄心下而怔忡者有之，心气郁滞多痰而惊者有之，风热生痰，上乘心膈而惊悸者有之。

【评议】景岳论述虽详，未免过于繁冗，临床难以实用，尚不及王肯堂之扼要简明，使人易于了然。

10. 《活人录》

心忽跳跃不定谓之怔，怔者振动之谓，心若有物撞动谓之忡，忡者冲逆之谓，此症因三焦之火，冲入包络，致包络之火动，而心为之不宁乃忡。若心神自虚，包络无血以滋养，致心体虚而悸动者为怔。

惊恐出于仓卒，或眼见异物、耳闻异声，而究实无所见，无所闻，惟

有心虚胆怯，神不自主，若有所见所闻，常怀忧惧，惟恐复惊，大约惊则神气散乱，恐则心胆虚怯，此惊恐之义也。

【评议】 此述怔忡之症状，虽不明确，但定义尚佳。其论病因分虚实两种，则较为实用。

11. 《医衡》

或问惊悸、怔忡、恐怖之别，曰：悸即怔忡也，怔忡者本无所惊，自心动而不宁，惊者因外有所触而卒动，除火热二淫之外，皆因人气之阴阳所动而内生者也。

【评议】 沈氏以阴阳立论，广而言之，论述亦属有理。

12. 《赤水玄珠》

怔忡者，心中惕惕然，动不自安也，惊者从外而入，或闻异声，目击异物，惊而惧也，悸者心中畏怯，动而怕惊也。怔忡止于心，不自安，悸则心自动，而又恐恐然，畏惧如人将捕之，惊而骇也。治怔忡之法，惟当益其心血，壮其神气，治惊悸则有诸经之证，当分别治之。治惊之法，内经曰：惊者平之，平者常也，使平日常见常闻，何惊之有，张子和治卫德新之妻，被盗而惊，乃以平法治之立愈。

【评议】 《赤水玄珠》之所述，较为实用。

四、健忘

中医之论健忘，除记忆障碍而外，复包括临床所见之失识，失用等征象，自内经，伤寒开始，论之者不乏其人，对病机又各执一词，略录如下：

1. 《内经》

灵枢·大惑论：人之善忘者，何气使然，岐伯曰：上气不足，下气有余，肠胃实而心肺虚，虚则营卫留于下，久之不以时上，故善忘也。

灵枢·本神：肾盛怒不止则伤志，志伤则喜忘其前言。

素问·调经论：血并于下，气并于上，乱而善忘。

【评议】 《内经》以上虚下实，血并于下，肾伤等为健忘之源。

2. 《伤寒论》

阳明病，其入喜忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令善忘，屎虽鞭，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。

【评议】 仲景以蓄血为喜忘之因，但此乃指热性病中谵妄状态之善忘，故其首冠之以“阳明病”。

3. 《济生方》

夫健忘者常常喜忘是也，盖脾主意与思。心亦主思，思虑过度，意舍不清，神官不职，使人健忘，治之之法，当理心脾，使神志宁静，思则得之矣。

【评议】 济生方以健忘由心脾过伤而成。

4. 《丹溪心法》

健忘由精神短少者，多亦有痰者，此症皆由思虑过度，损其心胞，以致神舍不清，遇事多忘，乃思虑过度，病在心脾。又云思伤脾，亦令遗忘，治之以归脾汤，须兼理心脾，神宁意定，其症自除也。

【评议】 丹溪之论，与严用和相同，但提出与痰有关。

5. 《证治要诀》

健忘者，所过之事，转盼遗忘，此乃思虑过度，病在心脾。此乃病之故，非比生成之愚顽不知人事者。

【评议】 戴思恭宗其师丹溪之论，但从其论述中有“生成之愚顽不知人事”，可窥得彼时已有近乎精神发育迟滞征象记载。

6. 《医学入门》

怔忡久则健忘，皆心脾血少神亏，清气不足，浊气上攻，亦有所禀不足，及老年神衰者。

【评议】 李梴除云由于心脾血少外，又有清浊之论，并提及先天禀赋不足与老年之衰退性健忘。

7. 《石室秘录》

健忘心病也，方用人参、芡实、麦冬、生枣仁、当归、山茱萸各三两，五味子、菖蒲、远志、柏子仁（去油）各一两，熟地五两，莲须二两，山药四两，各为末蜜为丸，每日早晚各用白水送下五钱，半料而痊。

8. 《医学心悟》

肾者作强之官，伎巧出焉，心者君主之官，神明出焉，肾虚则志不足，故喜忘其前言。又心藏神，神明不聪，则遇事遗忘也。

【评议】 医学心悟，宗内经为主。

9. 《张氏医通》

因病而健忘者，精血亏少，成为痰饮，瘀血所致，是可以药治之，若生平健忘，乃心窍大疏之故，岂药石所能疗乎。

【评议】石顽之论、宗乎内经，但其后云因病易治与生成难疗两种。说明在临床上出现智力减退之情况，如因发育不足，或因退化而智力减退者，预后较差，为颇有识见之论。

10. 《活人录》

健忘者，善忘也，事才过念，随即遗忘，不复记忆，或心了然口欲言而意不能言。此因平日遇不得意事，郁郁不乐，而心脾之气，抑郁而化火化痰，由是痰涎痰饮之类，乘虚而渗入心包，则心体为之不灵，或火郁包络，而心神为之散越，则神机不能为酬应，非真有所忘也，脉多沉滑多涩，故以养血宁神开郁顺气消痰逐饮之药为治。

11. 《沈氏医衡》

入生气禀不同，得气之清，则心之知觉者明；得气之浊，则心之知觉者昏。心之明者，无有限量，虽千百世，已往之事，一过目则终身记而不忘，岂得忘其日前者乎；心之昏者，精神火昏浊，则不待遐远，即旦语而夕忘者有之矣，刘河间谓水清明而火昏浊，故上善若水、下愚若火，此禀质使之然也，识禀质清浊混者，则不耐于万物之扰，扰则失其灵而健忘、盖气且人之神也，经曰：静则神藏，躁则消亡，静乃水之体，燥乃火之用，故性静则存乎中，情动则心忘于外，动不已，则忘亦不已，忘不已则存乎中者几希矣，所以世人多忘者，役役扰扰，纷纭交错，劳事一生，气血两竭，是以清明有守，不为事物所乱者，百难一人也。由是言之，药固有安神养血之功，不若平时养其气，养其在克而已。若夫痰病健忘者，乃一时之痰，然病忘之邪，非独痰也，凡是心有所寄，与诸火热伤乱其心者，皆得健忘，夫如是岂可不各从所由而为治耶？

事其神者去之，体其神者神居之，故欲令强记，当务养心，然以识治忘，不若以忘治忘，尝读病忘章云：

宋华子病忘，朝取而夕忘，夕与而朝忘，在途忘行，在室忘坐，占祷弗灵，药石无效，有鲁儒自谋能治之，曰：吾试化其心，变其虑，庶几其瘳乎，于是露之而求衣，饥之而求食，幽之而求明，与居七日，莫知其所

为，积年之病，一朝都除，华子既悟，乃大怒持戈逐儒，宋人执而问其所以，曰：曩吾忘也，荡荡然不知天地之有无，今顿识既往数十年存亡得失，哀乐好恶之事，吾恐将来乱吾之心，扰扰万绪起矣，求须臾之忘，可复得乎？

夫鲁儒之治华子，以识治忘也，华子之逐鲁儒，以忘治忘也，若以华子为真病忘者，得毋御寇所笑。

【评议】 沈明生之论健忘，以气之清浊，情之动静，为主要病因，并谓“病忘之邪，非独为痰，凡心有所寄，与诸火热伤乱其心，皆得健忘，应各从而为治”，此似较其他诸家为可信。

华子病忘一案，似较有趣，从其完全可逆之征象而言，似不属于器质性之记忆缺乏，而其病忘之程度，又极为严重，甚至在途忘行，在室忘坐，与一般遗忘不同，似属假性遗忘之类，其治疗方法，又颇似仲景之“以诈治诈”，“故识治忘”之法，诚为可信而可用。

12. 《梦溪笔记》

松滋令姜愚者，忽不识字者数年，后稍变旧，信奇疾也。

13. 《顾晓澜医案》

肥人气虚多疾，又兼操心太过，营虚火生，痰凝包络，前此曾有右手痿痹之症，服药调治而愈，近忽于素日所读之书，开卷茫然，大有目识丁之患，及他事应酬，又复神志如故，百治无效。

【评议】 中医类此之医案甚多，大多为器质性疾病，痴呆状态属之。

五、不寐

不寐即失眠，可云其为症状，但亦可云其为病名，其他疾病中尝有失眠之症候，而失眠症亦可由其他疾病所造成。古代中医书籍中，多有“不寐”、“不得卧”之名，由此可见中医早有失眠一症之存在。历来诸家，俱将其与怔忡惊悸等合论，求之于今日临床，其中之相互关系亦极大，且为精神科一重大问题，略述于后：

1. 《内经》

灵枢·营卫生会：帝曰：老人之不夜眠者，何气使然？少壮之人，不昼眠者，何气使然？岐伯答曰：壮者之气血盛，其肌肉滑，气道通，营卫

控涎丹；五曰胃不和，橘红，甘草，石斛，茯苓，半夏，神曲，山楂之类。

【评议】上材为一代名家，立论颇明，治法亦较适切，惟临床必须辨证精确，始可立方定治。

6. 《石室秘录》

凡人卧不安枕，方用人参五两，远志，枣仁各二两，熟地八两，山茱萸四两，柏子仁一两，麦冬，茯神各三两，陈皮五钱各为末，蜜为丸，每日白滚水送下一两，五日即安，一料全愈，名曰安神宁志丸。

【评议】《石室秘录》此方，征象甚为偏限，属于虚者宜之，若果属于火盛邪扰而不寐者，用之徒有损而无益也。

7. 《医方类珠》

心虚不寐，宜加味定志丸，胆虚不寐，恍如人将捕之多惊，酸枣仁一两为末，每服竹叶汤下二钱；病后虚烦不得眠，宜温胆汤（宜十味温胆）；日夜劳心，虚火动多痰少睡，心中不眠，宜加味养心汤。

【评议】洪金鼎以不寐多属于虚，未免过偏，虽有温胆等剂，尚不能云其论证全面，当参考其他诸家学说，以补其不足。

8. 《医论》

痰火扰乱，心神不宁，思虑过伤，火炽痰郁，而致不寐者多有之，有因肾水不足，真阴上升，而心火独亢者亦然，有脾倦火郁不得疏散，每至五更，随气上升而发躁，便成不寐，此宜醒脾、解郁、清痰、降火之法。

9. 《冷庐医话》

不寐之症，由于思虑伤脾，繁冗劳心者，非专恃医药可治，《老老恒言》谓：“不寐有操纵二法，操者如贯想头顶，默数鼻息，返观丹田之类，使心有所著，乃不纷驰，庶可获寐。纵者顺其心游思于杳渺无联之区，亦可渐入朦胧之境”。余谓二法之中，纵法尤稍涉妄想，即难奏效，尤当寓操于纵为佳，余师归安沈鹿坪先生，任官台州教授时，因阅文繁劳，患怔忡不寐，有人传一法云：每夜就枕后，即收敛此心，勿萌杂念，惟游思于平素所历山水佳处，任情一往，定而能静，久而久之，心即渐于杳漠之中，则使不期寐而自寐矣。如法行之获效，是其能得纵法之要者。

【评议】冷庐医话中之操纵两法，临床极为实用，且每每用之获效，颇获病者好评，其中特别强调纵法之妙，又“寓操于纵之中”，此可谓

深悉辩证法之奥者,故此法不仅用之颇广,且亦为科学性较强之治疗方法。

(黄跃东 周 康)

[附篇二] 中西医结合精神疾病辨证分型诊断标准

一、精神分裂症的中西医结合辨证分型标准

西医辨病：按 1984 年中华医学会神经精神科委员会黄山会议《精神分裂症临床工作诊断标准》。

中西医结合的中医辨证按以下标准。

(一) 痰火内扰型

精神症状：(1)不协调性兴奋；(2)思维联想障碍；(3)矛盾情感；(4)情绪易激惹；(5)注意力涣散。

躯体症状：* (1)大便秘结，溲赤，面红目赤，喜冷饮；(2)舌红或绛，苔黄厚或黄腻；(3)脉滑数有力。

(二) 痰温内阻型

精神症状：(1)思维联想障碍；(2)幻觉或妄想；(3)情感淡漠；(4)精神活动迟缓；(5)意志减退或接触不良。

躯体症状：(1)心烦失眠，倦怠乏力，纳呆便溏；* (2)舌体胖或齿痕，舌苔白腻；(3)脉滑或沉缓。

(三) 气滞血瘀型

精神症状：(1)行为幼稚或愚蠢；(2)思维破裂；(3)幻觉、妄想；(4)情绪不稳；(5)兴奋躁动。

躯体症状：(1)周身不适，肌肤粗糙，面色晦暗，痛经、经闭、经少色暗或有血块；* (2)舌质紫或瘀暗，少苔，舌下静脉曲张瘀血；(3)脉涩或弦。

(四) 阴虚火旺型

精神症状：(1)病情迁延不愈或偶见冲动；(2)幻觉、妄想；(3)情感平淡偶伴激惹；(4)思维联想障碍；(5)孤独退缩。

躯体症状：(1)大便干结，小便短赤，颧红，口干不渴；* (2)舌红无苔，或舌绛苔剥；(3)脉细数。

(五) 阳虚亏损型

精神症状：(1)情感淡漠；(2)懒散退缩；(3)思维贫乏或片断妄想；(4)意志减退；(5)寡言少动。

躯体症状：* (1)面色无华或萎黄，体虚无力，畏寒肢冷，食物不化；(2)舌质淡，苔薄白；(3)脉沉细弱。

(六) 其他型

难以纳入以上各型者。

【说明】(1)精神症状五项中，应具备其中3—4项。(2)躯体症状三项中，划“*”号者为必备症状，并同时具备其余任何一项症状。(3)此次修订是在1984年分型草案[发表于中西医结合杂志，1984；4(11)：678]的基础上，将脾肾阳虚和气血两虚型归并为阳虚亏损型。

[中西医结合杂志 1988；8(2)；127]

二、躁狂抑郁症的中西医结合辨证分型标准

躁狂抑郁症的诊断，按1984年中华医学会神经精神科委员会黄山会议《躁狂抑郁症临床工作诊断标准》。中西医结合辨证分型按以下标准。

【一】 躁狂发作

(一) 肝火内扰型

1. 精神症状：* ①情感高涨，易激惹；②思维奔逸，言语滔滔不绝；③躁动不安，喊闹不休；④昼夜少眠；⑤重者可意识模糊。

2. 躯体症状：①大便干结；②小便黄；* ③舌质深红，苔黄燥；④脉弦洪数。

(二) 肝胆郁热型

1. 精神症状：* ①情感活跃，易激惹；②联想加速，言语增多；③夸大、自负；④精力充沛，动作增多；⑤睡眠减少。

2. 躯体症状：①大便干结；②小便色黄；* ③舌质红，苔黄；④脉弦数。

(三) 热盛伤阴型

[中西医结合杂志 1988;8(2): 127]

三、神经症的中西医结合辨证分型标准

中国中西医结合研究会精神病专业委员会,于1989年5月10—13日在烟台市召开了神经症中西医结合辨证分型标准研讨会,讨论并制定了神经症中西医结合辨证分型标准(初稿)。

神经症的诊断,按照中华医学会神经精神科委员会制定的“神经症临床工作诊断标准”(1985年),中西医结合辨证分型按照以下标准。

(一) 肝郁化火型

多见于焦虑症、强迫症、癔症等。

躯体症状: ①头痛,眩晕,或面红目赤;②口苦咽干,胸胁胀痛,便秘;③舌边尖红,苔黄;④脉弦或弦数。

精神症状: ①情绪不稳,烦躁紧张,易激惹;②肢体瘫痪,暴聋,暴盲,意识障碍;③失眠多梦,易醒;④肌肉紧张,麻木震颤。

(二) 肝郁脾虚型

多见于抑郁性神经症、神经衰弱、疑病症、强迫症等。

躯体症状: ①眩晕,食欲不振,便溏;②胸胁满闷,腹胀,月经不调;③舌质暗淡,舌苔白腻;④脉弦细。

精神症状: ①情绪低落,烦闷;②失眠,难以入睡;③多疑,注意力不集中,梅核气;④强迫思虑。

(三) 心脾两虚型

多见于神经衰弱、恐怖抑郁性神经症、癔症等。

躯体症状: ①心悸,乏力;②纳差,腹胀或便溏;③舌质淡舌边尖有齿痕,舌苔薄;④脉沉细弱。

精神症状: ①精神不振,多思多虑;②失眠,多梦,易醒或多寐;③健忘;④胆怯,惊恐不安,附体妄想。

(四) 肝肾阴虚型

可见于各种神经症。

躯体症状: ①五心烦热,盗汗,心悸或耳鸣;②腰酸腿软,遗精,月经不调;③舌红或舌尖红,少苔或剥苔;④脉细数或沉细。

精神症状: ①情绪不稳,烦躁,易怒,惊恐,悲泣;②虚烦不眠,多

梦；③健忘，多疑；④肢体抖动，抽搐或强迫行为。

（五）脾肾阳虚型

多见于神经衰弱、抑郁性神经症、恐怖症等。

躯体症状：①形寒，畏冷或纳差，腹泻；②性欲减退，阳萎或月经不调；③舌质淡，舌体胖，舌苔白滑；④脉沉，迟，弱。

精神症状：①精神萎靡，倦怠，少动；②多卧少眠，易醒；③胆怯，恐惧；④兴趣减低，健忘。

（六）其他型

难以纳入以上各型者。

【说明】①证型的确定需具备该型躯体症状，精神症状各两条以上。②本分型标准为初稿，希望在临床实践中验证，以便于今后修订，使之不断完善。

[中西医结合杂志 1989;9(10): 615]

小柴胡汤(《伤寒论》)柴胡 黄芩 半夏 人参 甘草 大枣 生姜

小承气汤(《伤寒论》)大黄 厚朴 枳实

三才封髓丹(《卫生宝鉴》)天冬 熟地黄 人参 黄柏 砂仁 甘草

三仁汤(《温病条辨》)杏仁 白通草 白蔻仁 正滑石 生苡仁 半夏 厚朴 竹叶

三圣散(《圣惠方》)瓜蒂 防风 藜芦

川芎茶调散(《太平惠民和剂局方》)川芎 荆芥 防风 细辛 薄荷 白芷 羌活 甘草

四 画

六味地黄丸(《小儿药证直诀》)熟地黄 山萸肉 山药 泽泻 丹皮 茯苓

六安煎(《景岳全书》)陈皮 半夏 茯苓 甘草 杏仁 白芥子 生姜

天麻钩藤饮(《杂病证治新义》)天麻 钩藤 石决明 山栀 黄芩 杜仲 川牛膝 益母草 桑寄生 茯苓 夜交藤

天王补心丹(《摄生秘剖》)人参 玄参 丹参 茯苓 五味子 远志 桔梗 归身 天冬 麦冬 柏子仁 酸枣仁 生地黄 辰砂

天门冬煎(《古今图书集成》)天门冬 生地黄

五磨饮子(《医编》)木香 沉香 槟榔 枳实 乌药

牛黄抱龙丸(《明医杂著》)天竺黄 胆星 辰砂 雄黄 中黄 甘草 生姜

牛黄泻心汤(《古今图书集成》)脑子 牛黄 朱砂 大黄

牛黄膏(《脉因证治》)牛黄 朱砂 郁金 甘草 脑子 丹皮

丹枝逍遥散(《校注妇人良方》)牡丹皮 炒栀子 炙甘草 炒当归 白芍药 茯苓 白术 柴胡

不烦汤(《神元是保》)阿胶 黄连 枳壳 大黄 乌梅 生姜 白蜜

开迷散(《古今医鉴》)当归 炒白术 白芍 柴胡 白茯苓 炙甘

草 桃仁 苏木 红花 远志 生地黄

引神归舍丹(《证治准绳》)天南星 附子 朱砂 用猪心血和丸

五 画

半夏厚朴汤(《金匱要略》)半夏 厚朴 茯苓 生姜 干苏叶

半夏白术天麻汤(《医学心悟》)半夏 白术 天麻 橘红 茯苓
甘草 生姜 大枣

平补镇心丹(《太平惠民和剂局方》)酸枣仁 车前子 茯苓 五味
子 肉桂 麦门冬 茯神 天门冬 龙齿 熟地黄 山药 远志

生铁落饮(《金匱翼》)生铁落 石膏 龙齿 茯苓 防风 玄参
秦艽 竹沥

甘麦大枣汤(《金匱要略》)甘草 小麦 大枣

甘遂散(《证治准绳》)甘遂 用猪心血和丸

右归丸(《景岳全书》)熟地 山药 枸杞 山萸肉 菟丝子 鹿角
胶 杜仲 当归 肉桂 制附子

左归丸(《景岳全书》)熟地 山药 枸杞 山萸肉 牛膝 菟丝子
鹿胶 龟板

龙胆泻肝汤(《古今医方集成》)龙胆草 黄芩 栀子 泽泻 木通
车前子 当归 柴胡 生地 甘草

龙骨汤(《外台秘要》)龙骨 茯苓 桂心 远志 麦门冬 牡蛎
炙甘草 生姜

龙齿散(《圣惠方》)龙齿 远志 茯神 防风 甘草 人参 麦门
冬 羚羊角

归脾汤(《济生方》)白术 茯神 黄芪 龙眼肉 酸枣仁 人参
木香 甘草 当归 远志

归神汤(《辨证奇闻》)人参 白术 巴戟天 茯神 紫河车 半夏
陈皮 白芥子 甘草 柏子仁 丹砂 菖蒲 麦冬

归魂饮(《辨证录》)白芍 人参 贝母 香附 郁金

四逆散(《伤寒论》)甘草 枳实 柴胡 芍药

生脉饮(《内外伤辨惑论》)人参 麦冬 五味子

加味定志丸(《杂病源流犀烛》)茯苓 远志 菖蒲 人参 琥珀

郁金 朱砂

加味归脾汤(《医学心悟》)人参 茯苓 白术 甘草 当归 黄芪
枣仁 远志 木香 水煎后调服辰砂 琥珀末

加味泻脑汤(《医宗金鉴》)车前子 木通 菟藟子 茯苓 元参
元明粉 桔梗 炒黄芩 怀牛膝 川郁金 川贝

加味玉女煎(《温病条辨》)石膏 知母 元参 生地 麦冬

失笑散(《局方》)蒲黄 五灵脂

夺命散(《证治准绳》)没药 血竭

达营汤(《周康经验方》)三棱 赤芍 大黄

瓜蒂散(《伤寒明理论》)瓜蒂 赤小豆

宁志化痰汤(《古今医鉴》)胆星 制半夏 茯苓 天麻 人参 黄
连 酸枣仁 石菖蒲 生姜

六 画

安宫牛黄丸(《温病条辨》)牛黄 郁金 犀角 黄连 朱砂 栀子
雄黄 黄芩 珍珠 冰片 麝香 金箔

安神定志丸(《医学心悟》)人参 茯苓 茯神 远志 石菖蒲 龙
齿

安神丸(《小儿药证直诀》)牙硝 茯苓 麦冬 山药 甘草 寒水
石 龙脑 朱砂

安神滚痰丸(《证治汇补》)礞石 风化硝 朱砂 沉香 珍珠

安脑丸(《惺铁樵方》)白花蛇 麝香 白附子 犀角 生川乌 全
蝎 梅片 薄荷尖 天麻 郁金 麻黄 独活 腰黄

交泰丸(《韩氏医通》)黄连 肉桂

地黄饮子(《河间六书》)生地 巴戟天 山萸肉 石斛 肉苁蓉
附子 五味子 肉桂 茯苓 麦门冬 菖蒲 远志

百合地黄汤(《韩氏医通》)百合 生地黄

当归龙荟汤(《丹溪心法》)当归 龙胆草 芦荟 山梔 黄连 黄
芩 黄柏 大黄 木香 麝香

当归承气汤(《增补内经》)归尾 大黄 芒硝 枳实 厚朴 炙甘
草

没药 当归 五灵脂 香附 牛膝 地龙

忘忧汤(《经验方》)生地 忘忧草 当归 红花 赤芍 合欢皮

洗心汤(《辨证录》)人参 甘草 半夏 陈皮 菖蒲 附子 茯神
枣仁 神曲

芩连清心丸(《杂病源流犀烛》)黄芩 黄连 花粉 茯神 麦冬
丹参 牛黄 菖蒲 远志

抵当汤(《伤寒论》)水蛭 虻虫 桃仁 大黄

别离散(《千金方》)扬上寄生 白术 桂心 茵芋 天雄 菖蒲
细辛 茜根 炮附子 干姜

八 画

河车大造丸(《扶寿精方》)紫河车 败龟板 黄柏 杜仲 牛膝
麦冬 天冬 生地 人参

济生肾气丸(《济生方》)地黄 山茱萸 山药 泽泻 茯苓 丹皮
牛膝 车前子 附子 桂枝

枕中丹(《千金要方》)龟板 龙骨 远志 菖蒲

知柏地黄丸(《医宗金鉴》)知母 黄柏 熟地 山萸肉 山药 茯
苓 丹皮 泽泻

参附汤(《妇人良方》)人参 附子

定志小丸(《千金方》)菖蒲 远志 茯苓 人参

抽薪饮(《景岳全书》)黄芩 石斛 木通 炒栀子 黄柏 枳壳
泽泻 甘草

泽兰汤(《医学心悟》)泽兰 生地 当归 赤芍 甘草 生姜 大
枣 桂心

服蜜煎(《景岳全书》)生地 麦冬 芍药 石菖蒲 石斛 丹皮
茯神 陈皮 木通 知母

九 画

泻心汤(《金匱要略》)大黄 黄连 黄芩

泻肝汤(《三因极一病证方论》)前胡 柴胡 秦皮 细辛 栀子仁
黄芩 升麻 蕤仁 决明子

养心汤(《证治准绳》)黄芪 茯苓 茯神 当归 川芎 炙甘草

半夏 柏子仁 酸枣仁 远志 五味子 人参 肉桂

养血安神汤(《经验方》)当归 川芎 白芍 生地 酸枣仁 柏子仁 茯神 白术 黄连 甘草

柏子养心丸(《体仁汇编方》)枸杞子 麦冬 当归 石菖蒲 茯神 玄参 熟地 甘草

柏子仁散(《证治准绳》)柏子仁 远志 人参 桑寄生 防风 琥珀 炒当归 生地黄 白羊心 甘草

复元活血汤(《医学发明》)柴胡 瓜蒌根 红花 甘草 穿山甲 大黄 桃仁

指迷汤(《辨证录》)人参 白术 半夏 神曲 南星 甘草 陈皮 石菖蒲 附子 肉豆蔻

养血清心汤(《寿世保元》)人参 白术 白茯苓 远志 炒酸枣仁 川芎 生地黄 石菖蒲 当归 麦门冬 甘草

神志丸(《增补内经》)茯神 远志 羌活 天南星 辰砂 益智仁 山附子 雄黄 枯矾

独圣散(《古今医鉴》)甜瓜蒂

十 画

涤痰汤(《济生方》)半夏 胆星 橘红 枳实 茯苓 人参 菖蒲 竹茹 甘草 生姜 大枣

益气聪明汤(《证治准绳》)黄芪 升麻 葛根 蔓荆子 芍药 黄柏 炙甘草

桂枝加龙骨牡蛎汤(《金匱要略》)桂枝 炙甘草 芍药 龙骨 牡蛎 大枣 生姜

桃仁四物汤(《医宗金鉴》)熟地黄 川芎 白芍 当归 桃仁 红花

桃仁承气汤(《伤寒论》)桃仁 大黄 桂枝 芒硝 甘草

柴胡加龙骨牡蛎汤(《伤寒论》)柴胡 龙骨 黄芩 生姜 铅丹 人参 桂枝 茯苓 半夏 大黄 牡蛎 大枣

柴胡疏肝散(《景岳全书》)陈皮 柴胡 川芎 香附 枳壳 芍药 甘草

逍遥散(《太平惠民和剂局方》)柴胡 当归 白芍 白术 茯苓
甘草

通窍活血汤(《医林改错》)赤芍 川芎 桃仁 红花 老葱 红枣
麝香 黄酒

葶苈丸(《圣济总录》)葶苈子酒浸数日晒干捣碎

控涎丹(《三因极一病证方论》)甘遂 紫大戟 白芥子

涤痰开窍汤(《经验方》)胆南星 青皮 陈皮 竹沥 半夏 木香
煅礞石 天竺黄 石菖蒲 生大黄 郁金

振奋口服液(经验方):附片 巴戟 肉桂 细辛 三棱 桃叶
甘草

十 一 画

清火涤痰汤(《医醇賸义》)丹参 橘红 胆星 僵蚕 菊花 杏仁
麦冬 茯神 柏子仁 贝母 竹沥 姜汁

清心滚痰丸(《沈氏尊生方》)大黄 黄芩 青礞石 犀角 朱砂
沉香 麝香

清营汤(《温病条辨》)犀角 生地 元参 竹叶 麦冬 丹参 黄
连 银花 连翘

清心温胆汤(《杂病源流犀浊》)陈皮 半夏 茯苓 枳实 竹茹
白术 菖蒲 香附 当归 白芍 黄连 麦冬 川芎 远志 人参
甘草 生姜

清心丸(《古今图书集成》)人参 生地黄 郁金 天麻 朱砂 胆
南星

羚羊钩藤汤(《通俗伤寒论》)羚羊角 钩藤 桑叶 川贝 鲜生地
鲜竹茹 菊花 茯神 白芍 甘草

黄连温胆汤(《六因条辨》)黄连 半夏 陈皮 茯苓 炙草 竹茹
枳实 生姜 大枣

黄连阿胶汤(《伤寒论》)黄连 黄芩 白芍 阿胶 鸡子黄

黄连解毒汤(《外台秘要》)黄连 黄柏 黄芩 栀子

菖蒲郁金汤(《温病全书》)鲜石菖蒲 广郁金 栀子 连翘 菊花
滑石 竹叶 丹皮 牛蒡子 竹沥 姜汁 玉枢丹

加冰片

镇脑汤(《经验方》)柴胡 龙骨 牡蛎 半夏 桃仁 赤芍 大黄
三棱 地龙干

解郁化痰汤(《经验方》)橘红 半夏 柴胡 郁金 香附 远志
菖蒲 瓜蒌 胆星 竹茹 丹参 琥珀

镇狂汤(《经验方》)黄连 黄芩 酒大黄 礞石 生铁落 龙骨
磁石 牡蛎 神曲 菖蒲

新制柴胡汤(《上海精神卫生中心方》)柴胡 龙骨(或磁石) 牡蛎
半夏 竹沥 黄芩 桃仁 红花 丹参 香附 丹皮 赤芍 青陈
皮 酒大黄 甘草

